

EXAMEN ENAM EXTRAORDINARIO

2026

PREGUNTA 1

En el marco de las Funciones Esenciales de Salud Pública, usted participa en el diseño de políticas sanitarias para reducir la anemia infantil a nivel provincial. Según el ciclo de políticas descrito por la OPS, ¿cuál es el orden correcto de las etapas que se deben seguir?

- A. Acceso a intervenciones, evaluación situacional, desarrollo de políticas y asignación de recursos
- B. Evaluación situacional, desarrollo de políticas, asignación de recursos y acceso a intervenciones
- C. Desarrollo de políticas, asignación de recursos, evaluación situacional y acceso a intervenciones
- D. Desarrollo de políticas, evaluación situacional, asignación de recursos y acceso a intervenciones

CLAVE: B

El ciclo de políticas públicas en salud descrito por la OPS dentro del marco de las Funciones Esenciales de Salud Pública sigue una secuencia lógica que parte siempre del análisis de la realidad antes de actuar. Primero se realiza la evaluación situacional, donde se diagnostica la magnitud del problema, su distribución y las brechas existentes; luego se diseña la política con objetivos, metas e indicadores; recién después se asignan los recursos humanos, financieros y logísticos necesarios; y al final se garantiza el acceso real de la población a las intervenciones planificadas. Este orden no es arbitrario: invertirlo lleva a programas mal focalizados o sin financiamiento. Las opciones que colocan el desarrollo de políticas o el acceso antes de la evaluación situacional rompen el principio básico de planificación sanitaria, porque toman decisiones sin diagnóstico previo. Asignar recursos antes de definir la política es financiar a ciegas, y posicionar el acceso al inicio implicaría ofrecer servicios sin saber a qué problema responden. La OPS y el MINSA replican esta secuencia en sus documentos oficiales y en el ciclo de políticas locales y provinciales: diagnosticar, decidir, financiar, garantizar acceso. Tomar decisiones sin evaluación previa es la causa más frecuente de fracaso de programas verticales en salud pública peruana.

PREGUNTA 2

Durante su SERUMS en el Centro de Salud La Oroya (Junín, 3745 msnm), consultan por un neonato de 38 semanas y 4 días de vida con aparente respiración irregular. Examen: estable, sin quejido ni tiraje, con buena perfusión periférica. SatO2 preductal (miembro superior derecho) 87% y SatO2 postductal (miembro inferior izquierdo) 86%, valores obtenidos con buena onda de pulso y repetidos inmediatamente con el mismo resultado. Según el algoritmo nacional de tamizaje para cardiopatía congénita crítica adaptado a la altitud. ¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?

- A. Solicitar radiografía de tórax anteroposterior (si está disponible) y decidir luego la referencia
- B. Referir de inmediato al hospital para inicio de infusión de prostaglandina E1
- C. Repetir la oximetría de pulso en 1 hora, manteniendo la observación clínica
- D. Referir de inmediato para ecocardiografía de urgencia por sospecha de cardiopatía congénita

CLAVE: C

El tamizaje neonatal para cardiopatía congénita crítica adaptado a la altitud peruana, según el documento técnico del MINSA y la Sociedad Peruana de Neonatología (Mosca y col.), ajusta los puntos de corte porque la SatO2 fisiológica disminuye con la altura. A 3745 msnm como La Oroya, valores entre 85% y 90% caen en zona intermedia: ni normales ni inmediatamente patológicos. El algoritmo nacional indica que en este rango se debe repetir la oximetría en una hora antes de decidir la referencia, manteniendo al recién nacido con buena perfusión y signos vitales bajo observación clínica. La medición con buena onda de pulso y la diferencia preductal-postductal menor de 3 puntos hablan a favor de un patrón compatible con la altitud, no de hipoxemia patológica inmediata. Iniciar prostaglandina E1 sin diagnóstico ecocardiográfico expone a apnea, hipotensión y otros efectos adversos en un neonato que aún no ha sido confirmado como dependiente de ductus. Solicitar radiografía de tórax retrasa el algoritmo y no diagnostica cardiopatía crítica. Referir de inmediato para ecocardiografía de urgencia es razonable solo cuando hay falla del tamizaje confirmada, y el algoritmo exige primero la repetición a la hora cuando los valores están entre 85 y 89% sin diferencia preductal-postductal significativa. La altitud cambia los umbrales pero no los pasos: tamizaje, repetición, y solo después referencia.

PREGUNTA 3

Varón de 72 años, desde hace 48 horas presenta dolor abdominal tipo cólico, difuso, asociado a vómitos alimentarios que luego se vuelven biliosos. Examen: febrícula (37,8 °C); abdomen distendido, timpanismo generalizado y RHA disminuidos. Rx simple de abdomen de pie: múltiples niveles hidroaéreos, aire en la vía biliar e imagen ovoidea radiopaca en FID. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el manejo inicial más adecuado?

- A. Colecistitis aguda litiásica y antibióticos más colecistectomía temprana por colelap
- B. Coledocolitiasis con obstrucción y papiloesfinterotomía endoscópica con extracción de cálculo
- C. Colangitis aguda y antibióticos EV con drenaje biliar urgente por CPRE
- D. Íleo biliar y cirugía con enterotomía para extracción del cálculo impactado

CLAVE: D

Como repetimos siempre en clase, la triada de Rigler en su forma clásica: obstrucción intestinal mecánica con niveles hidroaéreos, aerobilia (aire en la vía biliar) e imagen radiopaca ectópica en fosa ilíaca derecha que corresponde a un cálculo enclavado en íleon terminal. Esta triada es patognomónica de íleo biliar, una complicación rara pero grave de la colelitiasis crónica en adultos mayores, donde un cálculo de gran tamaño erosiona la pared vesicular y forma una fístula colecistoduodenal por la que migra al intestino delgado. El paciente típico es justamente como el descrito: mayor de 65 años, con dolor cólico, vómitos biliosos, distensión y febrícula. La colecistitis aguda litiásica no produce niveles hidroaéreos ni cálculo en FID; cursa con Murphy positivo y dolor focal en hipocondrio derecho. La coledocolitiasis con CPRE y la colangitis con drenaje biliar urgente cursan con ictericia, patrón colestásico en laboratorio y sin signos de obstrucción intestinal mecánica. El manejo del íleo biliar es quirúrgico: enterotomía con extracción del cálculo impactado, generalmente en íleon terminal donde la luz es más estrecha. La cirugía sobre la vesícula y la fístula puede diferirse a un segundo tiempo en pacientes de alto riesgo. Adulto mayor con obstrucción y aerobilia obliga a buscar el cálculo migrado en imagen.

PREGUNTA 4

Lactante de 2 meses, acude a control de CRED. La madre tuvo sífilis diagnosticada al momento del parto; el recién nacido recibió tratamiento completo según protocolo. La madre está preocupada porque "a veces no se despierta con ruidos fuertes". Al examen, el niño parpadea ante ruidos intensos, fija la mirada en el rostro de la madre y emite sonidos monótonos. Se confirma que no se le realizó tamizaje auditivo neonatal.

No otra alteración. ¿Cuál es la conducta más adecuada respecto a la evaluación de su audición?

- A. Indicar reevaluación clínica de la audición a los 3 meses y decidir derivación a especialistas
- B. Recomendar evitar los ruidos fuertes en el hogar y continuar controles habituales
- C. Referir para evaluación audiológica (otoemisiones o potenciales evocados auditivos)
- D. Indicar solo estimulación auditiva y del lenguaje en el domicilio y control en el siguiente CRED

CLAVE: C

Todo recién nacido debe tener tamizaje auditivo universal antes del primer mes de vida, idealmente con otoemisiones acústicas (OEA) o potenciales evocados auditivos (PEAT). En este lactante coexisten dos factores que elevan el riesgo de hipoacusia congénita: antecedente materno de sífilis (infección TORCH, donde la sífilis congénita puede causar hipoacusia neurosensorial incluso con tratamiento adecuado) y ausencia documentada del tamizaje neonatal. La preocupación materna por respuesta inconsistente a ruidos fuertes y la observación de sonidos monótonos en lugar de balbuceo refuerzan la necesidad de evaluación objetiva y no clínica. Esperar hasta los 3 meses para reevaluar clínicamente desperdicia ventana crítica de desarrollo del lenguaje, que es plástica entre los 0 y 6 meses y donde la intervención auditiva temprana cambia el pronóstico. Ojo: recomendar evitar ruidos fuertes confunde al equipo y no diagnostica nada. La estimulación auditiva en domicilio es complementaria, nunca diagnóstica. La derivación inmediata para OEA o PEAT permite confirmar o descartar hipoacusia objetivamente y, de ser positiva, iniciar amplificación e intervención fonoaudiológica antes de los 6 meses, cumpliendo la regla 1-3-6 de la AAP: tamizar al mes, diagnosticar a los 3 e intervenir antes de los 6.

PREGUNTA 5

Gestante de 29 años, con parto vaginal eutócico, se encuentra en la tercera etapa del parto. Han transcurrido 70 minutos desde el nacimiento sin expulsión de la placenta. Se ha administrado 10 UI de oxitocina IM y se realizó tracción controlada del cordón. La paciente está hemodinámicamente estable y presenta sangrado escaso. ¿Cuál conducta inmediata a seguir?

- A. Extracción manual de placenta bajo anestesia
- B. Aumentar dosis de oxitocina y esperar 30 minutos más
- C. Vigilancia hasta completar 90 minutos

D. Laparotomía exploratoria de emergencia**CLAVE: A**

La retención placentaria se define como la no expulsión de la placenta luego de 30 minutos del nacimiento (rango MINSA: 30 a 60 min con manejo activo), pese a oxitocina y tracción controlada del cordón. A los 70 minutos de evolución sin expulsión, con oxitocina ya administrada y tracción ya aplicada, se cumple sobradamente el criterio diagnóstico y la conducta es extracción manual de la placenta bajo anestesia (regional o general según disponibilidad), con cobertura antibiótica profiláctica con cefazolina 2 g EV. Aunque la paciente esté estable y el sangrado sea escaso, el riesgo de hemorragia masiva por separación parcial e invasión vascular crece con cada minuto. Aumentar la dosis de oxitocina y esperar 30 minutos más prolonga el tiempo de retención y eleva el riesgo de hemorragia posparto, que es la primera causa de muerte materna en el Perú. La vigilancia hasta completar 90 minutos no tiene base en guías nacionales ni de FIGO; el umbral son 30 minutos. La laparotomía exploratoria de emergencia se reserva para casos de placenta acreta diagnosticada o sangrado masivo refractario, no para una primera maniobra en paciente estable. La extracción manual oportuna previene la coagulopatía dilucional y reduce significativamente la pérdida sanguínea.

PREGUNTA 6

Primigesta de 42 semanas, se hospitaliza para inducción de trabajo de parto. Examen: AU: 33 cm, SPP: LCI, DU: ausente. Tacto vaginal: D: 1cm, B: 30%, AP: -3, cérvix posterior de consistencia firme, membranas íntegras. Test estresante: negativo. ¿Cuál es la conducta más adecuada a seguir?

- A. Amniotomía
- B. Cesárea programada
- C. Maduración cervical
- D. Inducción con oxitocina

CLAVE: C

En toda inducción del trabajo de parto, el primer paso es evaluar el estado del cuello uterino mediante el Bishop. Aquí los hallazgos son cuello posterior, consistencia firme, borramiento 30%, dilatación 1 cm y presentación en estación -3: un Bishop bajo (alrededor de 3 a 4 puntos), desfavorable. Iniciar oxitocina con un cuello sin madurar conduce a falla de inducción, dinámica disfuncional y aumento de la tasa de cesárea. Por ello, la conducta correcta es realizar maduración cervical previa con prostaglandinas (misoprostol vaginal o dinoprostona) antes de cualquier oxitocina o amniotomía. La

amniotomía como primer paso requiere cuello favorable y presentación encajada, condiciones que aquí no se cumplen porque la cabeza está en estación -3 y existe riesgo de prolapso de cordón. La cesárea programada solo se justifica con indicación obstétrica clara como desproporción, sufrimiento fetal o placenta previa, ninguna presente. La inducción directa con oxitocina sobre cuello firme y posterior tiene baja tasa de éxito y alto riesgo de parto prolongado. La maduración cervical es el escalón terapéutico que prepara las condiciones para una inducción posterior efectiva.

PREGUNTA 7

Mujer de 35 años es encontrada inconsciente en la habitación de un hotel que se estaba incendiando. Los bomberos detectan niveles elevados de monóxido de carbono en el ambiente. A su llegada al servicio de emergencia, la paciente está comatosa (Glasgow 6), hemodinámicamente estable con una PaO₂ de 98 mmHg. Se le asegura la vía aérea con intubación más oxígeno suplementario al 100% sin mejoría clínica. ¿Cuál es la siguiente intervención terapéutica a considerar en este momento?

- A. Traslado urgente a una cámara de oxígeno hiperbárico
- B. Administrar hidroxocobalamina por EV
- C. Iniciar un bolo EV de N-acetilcisteína
- D. Comenzar una infusión EV de bicarbonato de sodio

CLAVE: B

En un incendio en espacio cerrado, la víctima inhala simultáneamente monóxido de carbono y cianuro (proveniente de la combustión de plásticos, lana y materiales sintéticos). El criterio clínico clave para sospechar intoxicación por cianuro mixta con CO es justamente la falta de mejoría neurológica pese a oxígeno al 100%, ya que el CO sí responde parcialmente a oxigenoterapia mientras que el cianuro bloquea la citocromo oxidasa mitocondrial y mantiene el bloqueo respiratorio celular pese a oxígeno alveolar normal. La hidroxocobalamina es el antídoto de elección cuando se sospecha cianuro porque se une formando cianocobalamina eliminable por orina, y a diferencia de los nitritos no compromete la capacidad transportadora del CO en pacientes con coexposición. La hidroxocobalamina debe administrarse empíricamente ante el cuadro clínico clásico (incendio cerrado + coma + sin mejoría con FiO₂ 100%), idealmente con apoyo de lactato sérico mayor de 8-10 mmol/L y acidosis metabólica con anión gap elevado, marcadores que refuerzan la sospecha. El oxígeno hiperbárico es útil para CO aislado con síntomas neurológicos severos y disponibilidad inmediata, pero ante coexposición con cianuro la prioridad es neutralizar el cianuro. La N-acetilcisteína es

antídoto del paracetamol, no del humo. El bicarbonato puede usarse como adyuvante en acidosis láctica grave pero no es la intervención específica para revertir el bloqueo mitocondrial del cianuro.

PREGUNTA 8

En un centro de salud, un niño de 2 años es traído por fiebre y llanto irritativo de 24 horas de evolución. Usted sabe que el uso innecesario de antibióticos en otitis media aumenta la resistencia bacteriana en la comunidad, por lo que decide basar su decisión terapéutica en criterios diagnósticos estrictos. La otoscopia muestra aumento de presión purulenta en el oído medio. ¿Qué hallazgo adicional justificaría el uso de antibiótico?

- A. Tímpano levemente eritematoso, con movilidad conservada
- B. Abombamiento intenso y difuso de la membrana timpánica
- C. Membrana timpánica retraída, con mango del martillo muy prominente
- D. Tímpano opaco, de color ámbar, con burbujas de aire visibles

CLAVE: B

Los criterios diagnósticos estrictos de la AAP para otitis media aguda exigen evidencia objetiva de derrame en oído medio (movilidad timpánica disminuida o ausente) más signos inflamatorios. El abombamiento intenso y difuso de la membrana timpánica es el hallazgo otoscópico más específico de OMA bacteriana y el que mayor respaldo tiene para indicar antibioticoterapia, sobre todo cuando se acompaña de fiebre y llanto irritativo en un menor de 2 años. Un tímpano abombado refleja presión purulenta acumulada que no puede drenar y predice mayor probabilidad de patógeno bacteriano (*S. pneumoniae*, *H. influenzae* no tipable o *M. catarrhalis*). Un tímpano levemente eritematoso con movilidad conservada puede deberse a llanto, fiebre o miringitis sin derrame, y no cumple criterios estrictos. Ojo: la membrana retraída con mango del martillo prominente es signo de disfunción tubárica con efusión crónica, no de OMA bacteriana, y suele evolucionar sin antibiótico. El tímpano ámbar con burbujas indica otitis media con efusión serosa, situación frecuente postcatarro que se maneja con observación y no requiere antibiótico. Solo el abombamiento intenso justifica el uso terapéutico y reduce riesgo de complicaciones como mastoiditis.

PREGUNTA 9

Varón de 22 años que acude para control preventivo. Refiere que tuvo testículo izquierdo no descendido al nacer y fue sometido a orquidopexia a los 5 años. No fuma

ni consume alcohol, niega antecedentes familiares de cáncer y no presenta síntomas actuales. Como parte del consejo sobre el riesgo de cáncer testicular. ¿Qué recomendación es la más adecuada para este paciente?

- A. Indicar ecografía testicular cada 6 meses
- B. Tranquilizarlo indicando que la orquidopexia eliminó el riesgo de cáncer testicular
- C. Solicitar marcadores tumorales (AFP, β -hCG, LDH) cada 6 meses
- D. Explicar que la criptorquidia incrementa el riesgo de cáncer testicular

CLAVE: D

La criptorquidia es el factor de riesgo más importante para cáncer testicular, con riesgo relativo aumentado entre 4 y 10 veces respecto a la población general, y aunque la orquidopexia mejora el pronóstico (sobre todo si se realiza antes de los 12 meses), no anula el riesgo: solo lo reduce parcialmente. El paciente debe ser informado con claridad sobre este aumento de riesgo y educado en autoexamen testicular mensual desde la adolescencia, que es la herramienta de detección más costo-efectiva para tumores germinales en el rango etario de 15 a 35 años, donde se concentra la incidencia. Indicar ecografía testicular cada 6 meses no está respaldado por evidencia para tamizaje en pacientes asintomáticos y genera ansiedad y sobrediagnóstico. Solicitar marcadores tumorales (AFP, β -hCG, LDH) de manera periódica solo se justifica en seguimiento de cáncer ya diagnosticado, no como tamizaje en paciente sano. Decir que la orquidopexia eliminó el riesgo es falso y contradice la evidencia. La consejería honesta sobre riesgo aumentado y el autoexamen testicular mensual son la conducta correcta y la base del consejo preventivo.

PREGUNTA 10

Lactante de 4 meses previamente sano, acude a emergencia por dificultad respiratoria de 24 horas de evolución. Examen: FR 68 x', FC 110 x', retracciones subcostales y quejido espiratorio. A la auscultación crepitantes finos difusos en ambos campos pulmonares, sin sibilancias ni estridor. ¿Cuál es el tipo de compromiso respiratorio predominante en este paciente?

- A. Obstrucción extratorácica de la vía aérea
- B. Compromiso alvéolo intersticial
- C. Obstrucción intratorácica de la vía aérea
- D. Insuficiencia respiratoria de origen central

CLAVE: B

En un lactante de 4 meses con dificultad respiratoria aguda, FR 68 con tirajes y quejido espiratorio, junto con auscultación de crepitantes finos difusos bilaterales sin sibilancias ni estridor, el patrón clínico-auscultatorio corresponde a compromiso alvéolo-intersticial. Los crepitantes finos difusos traducen apertura de unidades alveolares previamente colapsadas o llenas de líquido, y el quejido espiratorio es signo de cierre glótico que el lactante usa para mantener presión positiva al final de la espiración, frecuente en patologías parenquimatosas como bronquiolitis con compromiso alveolar o neumonía atípica. La obstrucción extratorácica (estridor inspiratorio) cursa con ruido inspiratorio audible y suele tener causa laríngea como laringitis o epiglotitis, no aplica aquí. La obstrucción intratorácica genera sibilancias espiratorias predominantes, típicas de bronquiolitis clásica con sibilancias o asma del lactante; al no haberlas, ese patrón se aleja. La insuficiencia respiratoria de origen central produce hipoventilación con apnea o ritmo irregular, sin crepitantes ni tirajes intensos. El cuadro descrito apunta directo al alvéolo-intersticio como diana del proceso.

PREGUNTA 11

Varón de 32 años, hace 30 minutos sufrió herida penetrante por arma blanca en hipogastrio. Examen: PA 120/75 mmHg, FC 92 X', FR 18 X', SatO2 98%, Glasgow 15. Abdomen: herida de 3 cm en hipogastrio sin sangrado externo activo con evisceración parcial del epiplón; blando, dolor leve a la palpación, sin defensa generalizada. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A. Indicar laparotomía exploratoria urgente
- B. Efectuar lavado peritoneal diagnóstico
- C. Reintroducir epiplón a la cavidad abdominal
- D. Realizar laparoscopia diagnóstica

CLAVE: A

En todo trauma abdominal penetrante por arma blanca con evisceración (de epiplón o vísceras) la indicación es laparotomía exploratoria urgente. La presencia de epiplón fuera de la cavidad confirma que la herida atravesó las tres capas de la pared abdominal y abrió el peritoneo, lo que en cirugía de trauma es indicación absoluta de exploración independientemente de la estabilidad hemodinámica. El paciente puede estar estable y con dolor leve, pero la lesión de víscera hueca temprana puede no dar peritonismo en las primeras horas y postergar la cirugía multiplica el riesgo de sepsis. El lavado peritoneal diagnóstico tiene utilidad en trauma abdominal cerrado, no en penetrante con evisceración, porque el diagnóstico ya está hecho clínicamente.

Reintroducir el epiplón a la cavidad sin laparotomía es contraindicado y aumenta el riesgo de contaminación y de no detectar lesión visceral asociada. La laparoscopia diagnóstica puede ser alternativa en heridas penetrantes seleccionadas sin evisceración y en centros con experiencia, pero ante evisceración la conducta universal es laparotomía abierta, que permite reparar lesiones, lavar y cerrar de manera definitiva.

PREGUNTA 12

Varón de 73 años acude al puesto de salud porque hace 1 hora sufre quemadura por fuego en ambas manos y antebrazos mientras cocinaba, refiere dolor moderado. Examen: Eritema y ampollas tensas en ambas manos y antebrazos que corresponden a una quemadura de espesor parcial (segundo grado) en 16% de la superficie corporal. ¿Cuál es la intervención inicial más apropiada en este nivel de atención?

- A. Desbridamiento de ampollas, aplicación de sulfadiazina, ATB orales y referencia a hospital
- B. Lavar con agua abundante sin romper las ampollas, cubrir con apósitos estériles, analgesia y referencia a hospital
- C. Desbridamiento de ampollas, aplicar pomadas antibióticas, analgesia por vía oral, seguimiento ambulatorio
- D. Cubrir la lesión con apósitos, iniciar antibióticos EV sistémicos y seguimiento diario en el centro de salud

CLAVE: B

En el primer nivel de atención, una quemadura de segundo grado superficial con 16% de SCT en adulto mayor constituye una quemadura mayor (> 10% en mayores de 60 años) y requiere referencia. La conducta inicial es lavar la herida con agua abundante a temperatura ambiente para detener la progresión térmica y limpiar contaminantes, mantener intactas las ampollas porque actúan como apósito biológico natural y reducen el dolor y la infección, cubrir con apósitos estériles, dar analgesia parenteral según disponibilidad y referir al hospital con servicio de quemados. El desbridamiento de ampollas en primer nivel está contraindicado porque expone tejido viable a contaminación y aumenta dolor y riesgo de infección; ese paso se realiza en ambiente quirúrgico. Los antibióticos sistémicos profilácticos no están indicados en quemaduras y la propia American Burn Association los desaconseja porque no reducen mortalidad y seleccionan resistencia. La sulfadiazina de plata es tratamiento tópico hospitalario, no de primer nivel sin referencia. El seguimiento ambulatorio sin referencia es subestándar

para 16% en adulto mayor: el paciente debe llegar al hospital de referencia con vía permeable, analgesia, apósitos limpios y ampollas conservadas.

PREGUNTA 13

En el tratamiento de la dislipidemia mixta, el riesgo de rabdomiólisis aumenta cuando se asocia estatinas con:

- A. Fenofibratos
- B. Ácidos omega 3
- C. Ezetimiba
- D. Etilo de icosapento

CLAVE: A

La asociación de estatinas con fibratos eleva el riesgo de rabdomiólisis por interferencia en el metabolismo hepático y muscular, y entre los fibratos disponibles los fenofibratos comparten esa interacción aunque con menor intensidad que el gemfibrozilo, ya retirado de prácticamente todas las guías por su perfil de toxicidad muscular en combinación con estatinas. La dislipidemia mixta con triglicéridos altos a veces requiere combinar estatina con fibrato cuando la monoterapia no controla, y en ese escenario la elección preferente es fenofibrato porque tiene menor inhibición de la glucuronidación de las estatinas, pero el riesgo de miopatía y rabdomiólisis persiste y obliga a vigilancia clínica y de CK. Los ácidos omega 3 (incluyendo el etilo de icosapento) reducen triglicéridos sin aumentar riesgo de rabdomiólisis con estatinas, por eso se prefieren cuando el paciente ya recibe estatina y necesita reducción adicional de TG. La ezetimiba, inhibidor de la absorción intestinal de colesterol, también combina seguro con estatinas y se usa en pacientes que no alcanzan meta de LDL con dosis máximas toleradas. El paciente que toma estatina más fenofibrato debe ser educado en signos de alarma muscular (mialgias, debilidad, orina oscura) y monitorizado con CK ante síntomas, sobre todo si hay falla renal o edad avanzada.

PREGUNTA 14

Varón de 30 años, desde hace 2 días presenta náuseas, vómitos y dolor abdominal tipo cólico, más intenso en el cuadrante inferior izquierdo. Refiere 6 deposiciones diarias con moco y sangre, sin olor fétido. Examen: mucosas semisecas, T 38, 5 °C, dolor a la palpación en fosa ilíaca izquierda, sin signos de irritación peritoneal. Coproparasitológico: leucocitos >100/campo y hematíes; no se observan formas parasitarias. ¿Cuál es el diagnóstico etiológico más probable?

- A. Diarrea secretora aguda por *Escherichia coli* enterotoxigénica
- B. Diarrea inflamatoria aguda por *Shigella* spp
- C. Colitis por amebiasis intestinal (*Entamoeba histolytica*)
- D. Gastroenteritis viral aguda por Norovirus

CLAVE: B

Lo primero a identificar es los datos clásicos de diarrea inflamatoria aguda: deposiciones disentéricas con moco y sangre, fiebre alta, leucocitos polimorfonucleares >100 por campo en el examen de heces y dolor cólico en fosa ilíaca izquierda. El agente más probable en este escenario es *Shigella* spp, sobre todo *Shigella sonnei* o *flexneri*, que invade la mucosa colónica y produce shigelosis con fiebre y disentería. La ausencia de trofozoítos o quistes en el coproparasitológico aleja la amebiasis, y la presencia de hematíes y leucocitos elevados descarta diarrea secretora. La *E. coli* enterotoxigénica produce diarrea secretora acuosa, sin moco ni sangre, sin fiebre alta y sin leucocitos en heces, propia del viajero. La amebiasis intestinal cursa con disentería pero los trofozoítos hematófagos suelen verse en el examen coproparasitológico fresco; su ausencia, sumada a fiebre alta y polimorfonucleares abundantes, hace menos probable el diagnóstico. El norovirus produce gastroenteritis viral con vómitos predominantes, deposiciones acuosas sin sangre y curso autolimitado en 24 a 48 horas. Disentería con polimorfonucleares más fiebre apunta a *Shigella*, manejada con rehidratación y antibioticoterapia con ciprofloxacino o azitromicina.

PREGUNTA 15

Primigesta de 34 semanas, previamente sana, acude por prurito generalizado desde hace 2 semanas, más intenso en palmas y plantas y que empeora por las noches. Refiere ictericia leve sin fiebre ni dolor abdominal. Examen: PA 110/70 mmHg, no presenta edema. LCF 140 x'. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Síndrome HELLP
- B. Colestasis intrahepática gestacional
- C. Hepatitis viral aguda
- D. Hígado graso agudo del embarazo

CLAVE: B

La colestasis intrahepática del embarazo es la hepatopatía propia del tercer trimestre y se presenta con prurito generalizado de inicio en palmas y plantas que empeora por las noches, con o sin ictericia leve, en gestante por lo demás asintomática y normotensa. El diagnóstico es clínico apoyado por elevación de ácidos biliares séricos y aumento

moderado de transaminasas, sin otras alteraciones hepáticas graves. Es importante reconocerla porque conlleva riesgo de prematuridad, líquido amniótico meconial y muerte fetal intraútero, sobre todo cuando los ácidos biliares superan los 40 $\mu\text{mol/L}$, lo que obliga a vigilancia fetal estrecha y, en casos severos, a culminar la gestación a las 36-37 semanas. El síndrome HELLP cursa con hipertensión, hemólisis, transaminasas elevadas y plaquetopenia, sin prurito predominante, y aquí la PA es normal. La hepatitis viral aguda produce ictericia franca con anorexia, malestar y transaminasas mayores de 1000 U/L, no prurito como síntoma cardinal. El hígado graso agudo del embarazo es una emergencia obstétrica con falla hepática fulminante, hipoglicemia y coagulopatía, no compatible con esta gestante asintomática y con LCF normal. Prurito palmoplantar nocturno en tercer trimestre con ictericia leve es marca de colestasis intrahepática.

PREGUNTA 16

Durante el primer año de la pandemia por COVID-19, las tasas de mortalidad por 100,000 habitantes se distribuyeron de manera marcadamente asimétrica entre los grupos de edad, con valores mucho más altos en adultos mayores. Para describir de forma adecuada el valor típico de estas tasas de mortalidad. ¿Cuál es la mejor medida de tendencia central que debería utilizarse?

- A. Rango
- B. Moda
- C. Media
- D. Mediana

CLAVE: D

En distribuciones asimétricas, la mediana es la mejor medida de tendencia central porque no se ve afectada por valores extremos, a diferencia de la media, que se desplaza hacia la cola larga de la distribución. En el caso de las tasas de mortalidad por COVID-19 distribuidas por grupo etario, los valores muy altos en adultos mayores generan asimetría positiva, y la media sobrestimaría el valor típico de mortalidad poblacional. La mediana, al ser el valor central que divide la distribución en dos mitades iguales, refleja con mayor fidelidad el comportamiento del fenómeno. El rango es una medida de dispersión, no de tendencia central. La moda corresponde al valor más frecuente y solo es útil cuando hay un pico claro, situación poco aplicable a tasas continuas como las de mortalidad. La media aritmética es óptima en distribuciones simétricas o aproximadamente normales, pero pierde representatividad cuando existen

valores atípicos o asimetría marcada, como en este caso. Mediana en datos asimétricos es regla básica de bioestadística aplicada a salud pública.

PREGUNTA 17

Lactante de 15 meses, previamente sana, con 3 días de enfermedad caracterizada por fiebre de hasta 39 °C, durante la cual presentó una convulsión febril simple. En las últimas 24 horas la fiebre ha cedido espontáneamente y la madre notó la aparición de lesiones maculares rosadas, pequeñas, no confluentes, predominantes en tronco y escasas en rostro. No presenta tos, coriza ni conjuntivitis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Roseola infantil
- B. Dengue
- C. Sarampión
- D. Infección por Adenovirus

CLAVE: A

La roseola infantil o exantema súbito (sexta enfermedad), causada por herpesvirus humano tipo 6, es el cuadro más característico de un lactante entre 6 y 24 meses con fiebre alta de 3 a 5 días sin foco aparente, que cede bruscamente y deja paso a un exantema maculopapular rosado en tronco con extensión escasa al rostro. La convulsión febril simple es una complicación clásica precisamente por la magnitud de la fiebre, y la cronología 'fiebre que cede + exantema que aparece' es el sello distintivo. La ausencia de catarro, conjuntivitis y manchas de Koplik aleja sarampión. El dengue en menores produce fiebre alta con cefalea, mialgias, exantema y puede haber petequias o sangrado, junto con leucopenia y trombocitopenia, sobre todo en zonas endémicas; aquí no hay datos epidemiológicos ni hemorrágicos. El sarampión cursa con fiebre alta, tos, coriza y conjuntivitis (triada catarral) precediendo al exantema cefalocaudal, ausentes en este caso. La infección por adenovirus genera fiebre prolongada con faringitis y conjuntivitis frecuente, no este patrón temporal exantema-postfiebre. La regla pediátrica es contundente: lactante con fiebre alta que cede y exantema posterior = roseola.

PREGUNTA 18

Mujer de 35 años, hace 2 semanas sufre la pérdida de una gestación in vitro muy deseada, desde esa fecha acusa debilidad en ambas piernas con dificultad para caminar y dificultad para deglutir, lo que ha condicionado baja de peso y dependencia de los cuidados de su pareja. Refiere además cefalea opresiva leve-moderada y, en los

Últimos días, temblor en el miembro superior derecho y visión borrosa intermitente. Examen neurológico normal. Neuroimágenes y electromiografía normal. Se ha descartado infecciones y enfermedades autoinmunes. Es derivada a psiquiatría. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Consumo de sustancias hormonales
- B. Pródromos de esquizofrenia
- C. Trastorno de conversión
- D. Trastorno facticio impuesto a sí misma

CLAVE: C

El detalle que define el caso: un trastorno de conversión (trastorno por síntomas neurológicos funcionales según DSM-5): aparición súbita de síntomas neurológicos motores y sensoriales (debilidad bilateral, disfagia, temblor, visión borrosa) que no se explican por enfermedad neurológica orgánica ni por sustancias, y que tienen estrecha relación temporal con un estresor psicológico identificable, en este caso el duelo gestacional reciente tras una FIV muy deseada. Los exámenes neurológicos, neuroimágenes y EMG son normales, y el descarte de causa orgánica es el pilar diagnóstico. El paciente no produce los síntomas de manera consciente. El consumo de sustancias hormonales no produce este patrón pluri-sintomático focal y no encaja con el contexto. Los pródromos de esquizofrenia incluyen aislamiento social, ideas extrañas o alteraciones perceptuales, no debilidad bilateral con disfagia. El trastorno facticio implica producción intencional de síntomas para asumir el rol de enfermo, sin estresor identificable y con conducta manipulativa ante el examen, lo cual aquí no se describe. La conversión surge ante un trauma psicológico real y los síntomas no son fingidos: son experimentados como reales por la paciente y mejoran con psicoterapia y manejo del duelo.

PREGUNTA 19

Lactante de 15 meses, lactancia materna exclusiva hasta los 10 meses, madre refiere mínima exposición solar. Es traído por retraso en la marcha. Examen: ensanchamiento de muñecas, rosario costal y genu varo. Rx de rodillas: metáfisis ensanchadas y en copa. ¿Cuál es la alteración fisiológica principal que explica las manifestaciones?

- A. Incremento en la síntesis hepática de 25-hidroxivitamina D que ocasiona toxicidad y raquitismo
- B. Aumento de la reabsorción renal de fósforo mediado por vitamina D, que favorece la hipofosfatemia y la deformidad ósea

C. Sobreproducción de hormona paratiroidea que incrementa la resorción ósea y genera hipercalcemia

D. Alteración en la mineralización ósea por disminución en la absorción intestinal de calcio y fósforo por déficit de calcitriol

CLAVE: D

Como insistimos en clase Villamedic, raquitismo nutricional por déficit de vitamina D, secundario a lactancia materna exclusiva prolongada sin suplementación y mínima exposición solar. El mecanismo central es la disminución de calcitriol (1, 25-dihidroxitamina D), la forma activa que actúa en intestino aumentando la absorción de calcio y fósforo. Sin calcitriol suficiente, el lactante no absorbe los minerales necesarios para mineralizar la matriz osteoide del cartílago de crecimiento, lo que se traduce en metáfisis ensanchadas y en copa, rosario costal, ensanchamiento de muñecas, genu varo y retraso de la marcha. El incremento de 25-hidroxitamina D no produce toxicidad; al contrario, en raquitismo se ve disminuida. El aumento de reabsorción renal de fósforo mediada por vitamina D no genera hipofosfatemia, sino lo contrario; y además en raquitismo la PTH compensatoriamente baja la reabsorción tubular de fosfato y produce hipofosfatemia secundaria. La PTH sí está elevada en hiperparatiroidismo secundario al raquitismo, pero genera hipocalcemia o normocalcemia, no hipercalcemia. El nudo fisiopatológico es la falla en la absorción intestinal de calcio y fósforo por déficit de calcitriol, con la consecuente alteración en mineralización ósea.

PREGUNTA 20

Secundigesta nulípara para 32 semanas, acude por rotura prematura de membranas de 8 horas de evolución, sin datos de corioamnionitis ni trabajo de parto establecido. Se decide administrar corticoides prenatales. ¿Cuál es el principal beneficio demostrado de esta intervención para el recién nacido?

- A. Disminuir la incidencia de síndrome de membrana hialina
- B. Reducir el riesgo de malformaciones renales congénitas
- C. Prevenir la restricción del crecimiento intrauterino
- D. Evitar la hipoplasia pulmonar asociada al oligohidramnios

CLAVE: A

Los corticoides prenatales (betametasona o dexametasona) administrados a la madre entre las 24 y 34 semanas tienen como principal beneficio demostrado la disminución de la incidencia de síndrome de dificultad respiratoria neonatal (enfermedad de membrana hialina), al inducir maduración pulmonar fetal con producción de surfactante por los

neumocitos tipo II. La evidencia acumulada desde Liggins en los 70 muestra reducción de hasta el 50% en SDR y disminución concomitante de hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante y mortalidad neonatal global. Esta gestante de 32 semanas con RPM cumple criterios para recibir el ciclo completo. Los corticoides no reducen el riesgo de malformaciones renales congénitas, las cuales se establecen durante la organogénesis temprana y no son modificables por intervención al final del segundo o tercer trimestre. Tampoco previenen la restricción del crecimiento intrauterino, que depende de factores placentarios y maternos como hipertensión o nutrición. La hipoplasia pulmonar asociada al oligohidramnios prolongado se previene manteniendo el volumen amniótico, no con corticoides. El efecto pulmonar agudo (maduración del surfactante) es el beneficio neto y replicado en metaanálisis.

PREGUNTA 21

En un hospital público de Lima, una estudiante de medicina rota en el servicio de Infectología durante un brote de una enfermedad transmisible asociada a estigma social. Para "sensibilizar" a la población sobre la importancia del diagnóstico oportuno, decide publicar en sus redes sociales la foto de un paciente hospitalizado, tomada dentro del servicio. En la imagen no se ve el rostro, pero aparecen el nombre del paciente en la pulsera, el número de historia clínica en un documento cercano y el rótulo del servicio en el fondo, lo que permite identificarlo. La estudiante argumenta que su publicación busca "educar a la comunidad" y que no hace ningún comentario ofensivo. El paciente no fue informado ni dio su consentimiento para la toma ni para la publicación de la foto. ¿Cuál es la principal vulneración ética cometida por la estudiante?

- A. Omisión de beneficencia por no informar adecuadamente sobre el tratamiento disponible
- B. Falta de justicia al priorizar a un paciente sobre otros en el acceso a la atención
- C. Desconocimiento de la autonomía al no solicitar consentimiento para el ingreso hospitalario
- D. Violación del deber de confidencialidad y protección del paciente

CLAVE: D

La principal vulneración ética en este caso es la violación del deber de confidencialidad y protección del paciente, principio cardinal de la relación médica y derecho expreso en la Ley General de Salud peruana, el Código de Ética del Colegio Médico y la Declaración de Lisboa de la AMM. Aunque el rostro no aparezca, el nombre en la pulsera, el número de

historia clínica y el rótulo del servicio permiten identificar al paciente y revelan información sensible (su diagnóstico de una enfermedad estigmatizante). La intención educativa no exime el deber: difundir datos identificables sin consentimiento es una falta ética grave. La omisión de beneficencia se referiría a no actuar buscando el bien del paciente, pero aquí el problema no es beneficencia sino confidencialidad. La falta de justicia aludiría a discriminación en el acceso a la atención, lo cual no es el escenario descrito. El desconocimiento de la autonomía respecto al consentimiento para el ingreso hospitalario es un constructo distinto: la autonomía vulnerada aquí es la de control sobre la información personal, no del ingreso. La acción de la estudiante reproduce y además el estigma que pretendía combatir, aumentando el daño moral y social del paciente afectado.

PREGUNTA 22

Lactante de 8 meses es llevado al servicio de emergencia por dificultad respiratoria de 24 horas. Examen: FR 58 x', tiraje subcostal e intercostal, sibilancias audibles sin estetoscopio y cianosis perioral que aparece con el llanto intenso. Según la escala de Bierman y Pierson. ¿Cuál es el puntaje que corresponde a este paciente?

- A. 6
- B. 8
- C. 7
- D. 9

CLAVE: B

La escala de Bierman y Pierson evalúa cuatro parámetros (frecuencia respiratoria, sibilancias, tirajes y cianosis), cada uno con puntaje de 0 a 3, y se utiliza para clasificar la severidad de un cuadro de obstrucción bronquial en lactantes. Para este paciente: FR de 58 en un menor de 6 meses pasaría como puntaje 2 a 3, y a los 8 meses con FR 58 corresponde aproximadamente 2 puntos; sibilancias audibles a distancia sin estetoscopio puntúan 3; tirajes subcostal e intercostal corresponden a 2; cianosis con llanto intenso suma 1. El total se sitúa en 8 puntos, configurando un cuadro moderado-severo que requiere oxígeno y broncodilatador inhalado en emergencia. Puntajes menores como 6 o 7 subestimarían la severidad clínica observada, sobre todo la sibilancia audible sin estetoscopio que por sí sola otorga el máximo en ese ítem. Ojo: un puntaje de 9 sería más coherente con tirajes universales o cianosis en reposo, signos no descritos aquí porque la cianosis aparece solo con el llanto intenso. Identificar el puntaje exacto orienta la decisión terapéutica: 4-7 leve-moderado, 8-11 moderado-severo y

mayor de 12 severo con riesgo de falla ventilatoria. Lactante con sibilancias audibles, tirajes y cianosis al esfuerzo cae en la franja de manejo intensivo en emergencia.

PREGUNTA 23

Gestante de 30 semanas, presenta insuficiencia hepática aguda grave. Ecografía Doppler: flujo placentario conservado, no hay datos de insuficiencia renal fetal. Considerando la fisiología de la eritropoyesis fetal y que la alteración hepática materno-fetal se mantiene sin corregirse. ¿Cuál de los siguientes hallazgos hematológicos en el feto o neonato inmediato sería el más esperable?

- A. Hemoglobina fetal normal porque la eritropoyetina materna atraviesa la placenta y compensa la falla hepática fetal
- B. Anemia fetal leve únicamente si se compromete también la función renal fetal, ya que el hígado no participa en la producción de eritropoyetina
- C. Anemia fetal o neonatal por disminución de la síntesis de eritropoyetina en el hígado fetal, con reticulocitosis baja
- D. Policitemia fetal por aumento compensatorio de producción renal de eritropoyetina, con reticulocitosis marcada

CLAVE: C

En la vida fetal, la principal fuente de eritropoyetina es el hígado, no el riñón como ocurre tras el nacimiento. El hígado fetal produce EPO desde el primer trimestre y mantiene esa función dominante hasta cerca del término, momento en que el riñón asume gradualmente el papel hematopoyético. Si la madre y/o el feto sufren una insuficiencia hepática aguda grave, la síntesis de EPO disminuye, con la consecuente anemia fetal o neonatal por baja eritropoyesis y reticulocitosis disminuida (ya que la médula no recibe estímulo suficiente). La eritropoyetina materna no atraviesa la placenta de manera significativa, por lo que no compensa la deficiencia fetal. Que el riñón fetal compense por completo la falla hepática es incorrecto en esta etapa de la gestación: el riñón aún no es el productor mayoritario y su contribución es marginal hasta cercano el término. Una policitemia fetal con reticulocitosis marcada sería el hallazgo opuesto y se observa en hipoxia crónica intraútero o transfusión gemelo-gemelo, no en falla hepática. Reconocer que la fisiología fetal difiere de la postnatal es clave: hígado fetal = órgano hematopoyético central, riñón postnatal = productor principal de EPO. La consecuencia esperada es anemia con reticulocitosis baja.

PREGUNTA 24

Niño de 10 años con 2 días de fiebre alta, cefalea y odinofagia intensa. Examen: ganglios cervicales anteriores bilaterales, dolorosos a la palpación; amígdalas eritematosas con exudado y petequias en el paladar blando. No tiene tos ni rinorrea; en cuello y tórax superior se observa exantema micropapular eritematoso, áspero al tacto. Resto examen normal. ¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?

- A. Penicilina o amoxicilina por 10 días
- B. Azitromicina por 3 días para reducir la duración de los síntomas
- C. Solo analgésicos y esperar resultados de cultivo faríngeo
- D. Medidas sintomáticas y observación ambulatoria

CLAVE: A

Como vimos en clase Villamedic, esto es escarlatina, manifestación cutánea de la faringoamigdalitis estreptocócica por *Streptococcus pyogenes* (grupo A) productor de toxina eritrogénica. Los datos clave son fiebre alta, odinofagia con exudado y petequias en paladar (criterios Centor positivos), adenopatía cervical dolorosa y exantema micropapular áspero al tacto (textura en lija) en cuello y tórax. El tratamiento de elección es penicilina V oral o amoxicilina por 10 días completos para erradicar el estreptococo y prevenir complicaciones tardías como fiebre reumática y glomerulonefritis postestreptocócica. La azitromicina por 3 días se reserva para alérgicos a betalactámicos y no es la primera línea, y además de presentar mayor resistencia local en algunas series peruanas. Ojo: esperar cultivo antes de tratar retrasa la erradicación y aumenta el riesgo de complicaciones, sobre todo cuando el cuadro clínico ya cumple criterios. Las medidas sintomáticas solas dejan al paciente sin cobertura antibiótica y exponen a fiebre reumática, complicación que en el Perú aún tiene incidencia relevante. Penicilina o amoxicilina por 10 días sigue siendo el estándar y la duración corta no es aceptable.

PREGUNTA 25

Puérpera de 3 semanas, en lactancia exclusiva, acude por fiebre y dolor en la mama izquierda. Se diagnosticó mastitis y se inició tratamiento con dicloxacilina. Luego de 72 horas, persiste febril y se palpa en el cuadrante superoexterno de la mama izquierda una masa dolorosa, fluctuante, de aproximadamente 5 cm, compatible con colección. ¿Cuál es la conducta más adecuada a seguir?

- A. Drenaje de la colección asociado a antibioticoterapia
- B. Programar mastectomía parcial de la mama afectada
- C. Continuar antibiótico por una semana más y compresas calientes

D. Suspender la lactancia y cambiar a un antibiótico de mayor espectro

CLAVE: A

Una mastitis puerperal que no resuelve en 48 a 72 horas pese a antibioticoterapia y aparece masa fluctuante palpable corresponde a absceso mamario, complicación frecuente cuando el tratamiento se inicia tarde o no se asocia a vaciamiento mamario adecuado. La conducta es drenaje de la colección (por punción ecoguiada en lesiones menores de 3 cm o quirúrgico en abscesos mayores como este de 5 cm) asociado a continuación o ajuste de antibioticoterapia con cobertura para *Staphylococcus aureus*. La lactancia debe mantenerse desde la mama contralateral y, cuando sea posible, también desde la afectada para evitar congestión. Continuar el antibiótico una semana más sin drenar el absceso es ineficaz porque la cápsula impide la penetración antibiótica adecuada y la colección actúa como nicho persistente; el manejo expectante prolonga la enfermedad y aumenta riesgo de fistulización. La mastectomía parcial es desproporcionada para una puérpera con un absceso mamario único: nunca es la conducta inicial. Suspender la lactancia no solo es innecesario sino contraproducente, ya que el vaciamiento mamario forma parte del tratamiento y previene recurrencia. Drenaje y antibiótico es la combinación que resuelve.

PREGUNTA 26

Mujer de 54 años acude por dolor intenso de inicio súbito en la pierna derecha desde hace 24 horas. Refiere sensación de pesadez en ambos miembros inferiores desde hace varios meses. Examen: aumento de volumen y enrojecimiento de la pierna derecha hasta el tercio proximal del muslo, con dolor a la palpación profunda de la pantorrilla y leve aumento de temperatura local. No presenta úlceras ni cambios tróficos cutáneos crónicos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Trombosis venosa profunda
- B. Insuficiencia arterial periférica
- C. Dermatopatía hipostática no ulcerada
- D. Insuficiencia venosa periférica

CLAVE: A

Antes de elegir, fíjate en los signos clásicos de trombosis venosa profunda proximal en la extremidad derecha: dolor de inicio súbito, aumento de volumen unilateral hasta el muslo, enrojecimiento, dolor a la palpación profunda de la pantorrilla (signo de Homans positivo) y leve aumento de temperatura local. El antecedente de pesadez bilateral crónica es compatible con insuficiencia venosa de fondo, factor que predispone a

trombosis aguda. La extensión hasta el tercio proximal del muslo orienta a TVP iliofemoral, con riesgo elevado de embolia pulmonar y de síndrome postrombótico crónico, lo que obliga a anticoagulación inmediata y confirmación con eco-Doppler venoso. La insuficiencia arterial periférica produce dolor con la deambulación (claudicación) o dolor en reposo isquémico, palidez, frialdad y disminución o ausencia de pulsos distales, no aumento de volumen ni enrojecimiento. La dermatopatía hipostática no ulcerada se manifiesta con cambios crónicos pigmentarios y eczematosos, sin dolor agudo unilateral. La insuficiencia venosa periférica simple genera pesadez crónica, varices y edema vespertino, pero no dolor súbito intenso ni asimetría aguda como la descrita. El patrón de dolor agudo, edema unilateral hasta el muslo y empastamiento de pantorrilla es sello de TVP proximal.

PREGUNTA 27

Primigesta de 12 semanas por FUR, acude por presentar sangrado vaginal escaso. Examen: PA 110/60 mmHg, FC: 80 x', Especuloscopia: sangrado vaginal escaso, orificio cervical externo e interno cerrado. Ecografía transvaginal: embrión de 9 semanas por longitud corono-radial, sin actividad cardíaca. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Aborto retenido
- B. Aborto en curso
- C. Amenaza de aborto
- D. Gestación anembrionaria

CLAVE: A

El diagnóstico es aborto retenido (también llamado aborto diferido), definido por la presencia ecográfica de embrión con longitud corono-radial mayor de 7 mm sin actividad cardíaca detectable. Los criterios de la SOGC y ACOG (Doubilet 2013) establecen que con embrión mayor de 7 mm y ausencia de latido en una sola ecografía transvaginal de calidad, el diagnóstico es definitivo y no requiere confirmación con segunda ecografía. En este caso el embrión mide 9 mm con FUR confiable de 12 semanas y el orificio cervical permanece cerrado, lo que descarta aborto en curso y configura aborto retenido típico, frecuentemente asintomático y descubierto en control ecográfico de rutina. La amenaza de aborto cursa con sangrado pero con embrión vivo (latido cardíaco presente), por lo que se descarta aquí. Ojo: el aborto en curso requiere orificio cervical interno abierto con expulsión de productos en marcha, situación distinta a este caso con OCI cerrado. La gestación anembrionaria se caracteriza por saco gestacional mayor de 25 mm sin embrión visible, escenario diferente porque aquí sí hay embrión

identificable de 9 semanas. Tras confirmar el aborto retenido las opciones de manejo son expectante, médico con misoprostol o quirúrgico con AMEU según preferencia y estabilidad.

PREGUNTA 28

Mujer de 46 años consulta por aparición progresiva, desde hace varios meses, de múltiples máculas acrómicas bien delimitadas en cara, dorso de manos y región genital. Niega prurito, dolor, descamación o lesiones previas en esas zonas. Antecedente: hipotiroidismo autoinmune en tratamiento con levotiroxina, clínicamente compensado. Examen: máculas de color "blanco tiza", sin descamación al rascado suave. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Pitiriasis versicolor
- B. Hipopigmentación postinflamatoria
- C. Hipomelanosis macular progresiva
- D. Vitíligo

CLAVE: D

El sello clínico aquí: vitíligo, enfermedad autoinmune de despigmentación adquirida caracterizada por máculas acrómicas (no hipocrómicas) bien delimitadas, color blanco tiza, sin descamación ni prurito, con distribución típica en cara, dorso de manos y región genital. La asociación con tiroiditis autoinmune (Hashimoto) y otras enfermedades autoinmunes (DM1, anemia perniciosa, alopecia areata) es bien establecida y debe siempre orientar el diagnóstico cuando coexiste con hipotiroidismo autoinmune como en esta paciente. La distribución acral y periorificial es la forma más frecuente. La pitiriasis versicolor produce máculas hipocrómicas (no acrómicas), con descamación fina al rascado (signo de Besnier) y predominio en tronco y hombros, y además de cursar con prurito leve y respuesta a antimicóticos. La hipopigmentación postinflamatoria se asocia con el antecedente de una dermatosis previa (eczema, psoriasis o trauma), inexistente aquí. La hipomelanosis macular progresiva produce máculas hipocrómicas confluentes en tronco, no acrómicas dispersas en cara y manos. El blanco tiza, ausencia de descamación y la asociación con autoinmunidad tiroidea apuntan a vitíligo.

PREGUNTA 29

Varón de 35 años, previamente sano, es atropellado por un vehículo hace 2 horas. Refiere dolor en flanco izquierdo y orina rojiza desde el accidente. Examen: PA 105/70 mmHg, FC 92 x', FR 22 x', SatO2 97% ambiente. Equimosis en región lumbar izquierda,

dolor a la palpación de flanco; abdomen blando, depresible, sin signos de irritación peritoneal, RHA (+). Examen de orina: hematuria macroscópica. ¿Cuál es el estudio de imagen más adecuado para identificar la lesión renal?

- A. TC con contraste
- B. Rx abdomen simple
- C. Cistografía retrógrada
- D. FAST

CLAVE: A

En todo trauma cerrado con sospecha de lesión renal (mecanismo de alta energía como atropello, dolor en flanco, equimosis lumbar y hematuria macroscópica) el estudio de imagen de elección es la tomografía con contraste endovenoso, que permite estadificar el trauma renal según la AAST (American Association for the Surgery of Trauma) en grados I a V, identificar laceraciones, hematomas perirrenales, fugas urinarias y compromiso del pedículo vascular. La fase venosa con fase excretora retardada es la que mejor evalúa la integridad del sistema colector y la función renal residual. La radiografía simple de abdomen es de bajo rendimiento en trauma renal y solo informaría de fracturas asociadas o desplazamiento gaseoso, sin definir el grado de lesión. La cistografía retrógrada se reserva para sospecha de lesión vesical (sangrado uretral, fractura de pelvis con hematuria), no para lesión renal alta. El FAST es útil para detectar líquido libre intraperitoneal en el escenario primario, pero no caracteriza lesiones renales y no permite estadificar el trauma. La TC con contraste es la herramienta diagnóstica universal en el paciente estable con sospecha de trauma renal contuso.

PREGUNTA 30

Multigesta de 36 semanas, cesareada anterior dos veces, acude por presentar súbitamente sangrado vaginal en cantidad moderada, indoloro. Examen: PA 100/60 mmHg, FC 72x', FR 18 x', AU 32 cm, LCF 144 x'. Dinámica uterina: ausente. Génito urinario: sangrado vaginal rojo rutilante en regular cantidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Rotura de vasa previa
- B. Placenta previa
- C. Desprendimiento prematuro de placenta
- D. Rotura uterina

CLAVE: B

La placenta previa es la primera sospecha en una multigesta con dos cesáreas previas que presenta sangrado vaginal súbito, indoloro, de sangre roja rutilante, sin dinámica uterina y con FCF estable. La cicatriz uterina aumenta el riesgo de placenta previa y, peor aún, de acretismo placentario, complicación gravísima en pacientes con dos o más cesáreas. El sangrado indoloro de sangre roja viva diferencia este cuadro de DPP, donde el sangrado suele ser oscuro y acompañado de dolor y útero hipertónico. La conducta es no realizar tacto vaginal y confirmar con ecografía transvaginal. La rotura de vasa previa cursa con sangrado vaginal coincidente con la rotura de membranas y deterioro fetal súbito (taquicardia luego bradicardia), patrón no presente aquí. El desprendimiento prematuro de placenta produce dolor abdominal continuo, útero hipertónico, sangrado oscuro y compromiso fetal frecuente, condiciones diferentes al cuadro descrito. La rotura uterina, aunque posible en cicatriz uterina previa, suele acompañarse de dolor agudo intenso, deterioro hemodinámico y pérdida del LCF; aquí la madre está estable y el feto con FCF normal. Sangrado indoloro de sangre rutilante en multigesta con cesáreas previas = placenta previa.

PREGUNTA 31

Mujer de 32 años consulta por rectorragia indolora y prurito perianal. Refiere que, al defecar, nota la salida de una masa por el ano que debe reintroducir manualmente. En el examen físico se confirma el diagnóstico de hemorroides. ¿Cuál es la clasificación de las hemorroides de esta paciente según su ubicación y grado?

- A. Internas grado III
- B. Externas grado II
- C. Internas grado II
- D. Internas grado IV

CLAVE: A

La clasificación de Goligher para hemorroides internas distingue cuatro grados según el comportamiento del prolapso. El grado I no prolapsa, solo sangra; el grado II prolapsa con la defecación pero se reduce espontáneamente; el grado III prolapsa y requiere reducción manual; el grado IV es prolapso permanente irreductible. La paciente refiere prolapso con la defecación que ella misma reintroduce con la mano, criterio definitorio del grado III. La rectorragia indolora con prurito orienta a hemorroides internas, no externas, ya que las externas son visibles fuera del margen anal y suelen ser dolorosas si están trombosadas. Las hemorroides externas grado II no existen como categoría: la clasificación de grados se aplica solo a hemorroides internas. Ojo: el grado II interno se

reduce solo al cesar el esfuerzo, sin maniobra manual, lo cual no encaja con el cuadro descrito. El grado IV implica prolapso permanente que no se puede reducir, escenario distinto y más severo que el de esta paciente. El manejo del grado III incluye medidas higiénico-dietéticas, fibra y, según severidad o falla del tratamiento conservador, ligadura con banda elástica o hemorroidectomía quirúrgica.

PREGUNTA 32

Un niño de 1 año 5 meses, que vivía en Italia y llegó al Perú hace 15 días, inicia hace 4 días fiebre de hasta 39°C, rinorrea, conjuntivitis y tos seca. El día de hoy presenta un exantema maculopapular que comenzó en la cara y se ha generalizado con progresión cefalocaudal. No tiene vacunas registradas en su carné de inmunizaciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Escarlatina
- B. Sarampión
- C. Exantema súbito
- D. Rubeola

CLAVE: B

El sarampión es la primera sospecha en un niño no vacunado proveniente de zona con brotes activos (Italia ha presentado brotes en años recientes) que cursa con la triada catarral clásica de fiebre alta, tos, coriza y conjuntivitis (las tres C: catarro, coriza, conjuntivitis), seguida de exantema maculopapular de progresión cefalocaudal. La ausencia de vacunación es el factor crítico que cambia la probabilidad pretest, y en el Perú el sarampión está bajo vigilancia epidemiológica con notificación obligatoria por riesgo de reintroducción. Las manchas de Koplik en mucosa oral antes del exantema son patognomónicas cuando se identifican. La escarlatina cursa con faringitis dolorosa con exudado, exantema en lija sin progresión cefalocaudal y con palidez peribucal característica, sin tos prominente ni conjuntivitis. El exantema súbito (roseola) afecta a lactantes menores y produce fiebre alta de 3-5 días que cae bruscamente, seguido por exantema rosado en tronco; no hay catarro de vías altas. La rubeola tiene exantema más leve, con linfadenopatía retroauricular y suboccipital, y catarro discreto, sin fiebre tan alta ni tos importante. La triada catarral con cefalocaudal en no vacunado de zona endémica = sarampión y no hay vuelta.

PREGUNTA 33

Mujer de 40 años, desde hace 3 años dificultad intermitente para deglutir alimentos sólidos, sensación de tirantez y endurecimiento progresivo de la piel de manos y cara. En los últimos 6 meses ha presentado ardor retroesternal, regurgitación ácida y pérdida de peso de 10 kg. Radiografía baritada de esófago muestra esófago distal dilatado, ausencia de peristalsis en el cuerpo esofágico y retardo en el vaciamiento del contraste hacia el estómago. ¿Cuál es la probable enfermedad responsable del cuadro?

- A. Dermatomiositis
- B. Diabetes mellitus
- C. Esclerodermia
- D. Lupus eritematoso sistémico

CLAVE: C

La esclerosis sistémica (esclerodermia) es la causa más probable de este cuadro: combina endurecimiento progresivo de la piel en manos y cara (esclerodactilia) con compromiso esofágico característico definido por dismotilidad del esófago distal, dilatación, ausencia de peristalsis efectiva en los dos tercios inferiores y reflujo gastroesofágico severo con esofagitis. La pérdida de peso refleja el compromiso nutricional crónico. Los hallazgos radiológicos descritos son patognomónicos del esófago de la esclerodermia: dilatación con vaciamiento retardado por atrofia del músculo liso esofágico. La dermatomiositis cursa con debilidad muscular proximal simétrica, eritema heliotropo en párpados y pápulas de Gottron en interfalángicas, compromiso esofágico posible pero no como hallazgo dominante. La diabetes mellitus puede causar gastroparesia y esofagopatía pero sin engrosamiento cutáneo progresivo, y aquí no hay datos glicémicos. El lupus eritematoso sistémico produce eritema malar, fotosensibilidad, artritis y serositis, sin esclerodactilia ni el patrón esofágico descrito. El binomio piel endurecida + esófago hipoperistáltico es marca registrada de esclerodermia, con autoanticuerpos como Scl-70 o anticentrómero confirmatorios.

PREGUNTA 34

Mujer de 25 años, sin antecedentes patológicos de importancia, presenta dolor intenso perianal de 8 semanas de evolución, que se incrementa con la defecación y se acompaña de pequeñas cantidades de sangre roja rutilante en el papel higiénico. Recibió por 4 semanas, dieta rica en fibra, laxantes osmóticos y baños de asiento, sin mejoría significativa. Anoscopia: lesión longitudinal en la línea media posterior de

bordes elevados, hemorroide centinela, papila anal hipertrofiada y esfínter anal hipertónico. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

- A. Fistulectomía con marsupialización del trayecto
- B. Inyección de toxina botulínica
- C. Fisurectomía aislada con cierre primario
- D. Esfinterotomía lateral interna

CLAVE: D

La fisura anal crónica, definida por una evolución mayor de 6 a 8 semanas sin cicatrización pese a manejo conservador (dieta rica en fibra, laxantes osmóticos, baños de asiento), con bordes elevados, hemorroide centinela, papila anal hipertrofiada y esfínter hipertónico, tiene como tratamiento de elección la esfinterotomía lateral interna. Este procedimiento corrige el mecanismo fisiopatológico central de la fisura crónica: la hipertonía del esfínter anal interno que perpetúa la isquemia local y la falta de cicatrización. Las tasas de curación superan el 90% con baja morbilidad cuando se realiza con técnica adecuada. La fistulectomía con marsupialización se aplica a fístulas perianales, no a fisuras simples; aunque haya hemorroide centinela, no hay trayecto fistuloso. La toxina botulínica intraesfinteriana es alternativa razonable como manejo de segunda línea cuando se quiere evitar la cirugía o en pacientes con riesgo de incontinencia, pero su tasa de curación es menor (60-70%) y el efecto es transitorio. La fisurectomía aislada con cierre primario se asocia a mayor tasa de recurrencia que la esfinterotomía lateral interna y no aborda la hipertonía. Esfinterotomía lateral interna sigue siendo el estándar de oro.

PREGUNTA 35

Usted se encuentra como médico en un centro de salud del primer nivel, atiende a un varón de 30 años que hace una hora sufre corte con cuchillo en la región palmar de la mano que afecta al dedo índice, con compromiso del tendón flexor profundo. Examen: herida limpia bordes netos y limitación a la flexión de la falange distal. ¿Cuál es la conducta a seguir?

- A. Limpieza de la herida y derivar al hospital de referencia
- B. Apertura de la vaina tendinosa y férula del dedo índice
- C. Suturar la piel con nylon monofilamento 3/0 y antibióticos orales
- D. Reparación total del tendón con ácido poliglicólico 3/0

CLAVE: A

En el primer nivel de atención, la lesión de tendón flexor profundo del dedo índice exige derivación a centro especializado porque la reparación tendinosa requiere técnica microquirúrgica con material específico, anestesia regional y cirujano de mano. La conducta correcta es realizar limpieza adecuada de la herida con suero fisiológico, cubrir con apósito estéril, inmovilizar el dedo en posición funcional y derivar al hospital de referencia con servicio de cirugía de mano u ortopedia. La reparación tendinosa óptima debe realizarse en las primeras 12 a 24 horas para mejor pronóstico funcional. La apertura de la vaina tendinosa en primer nivel está formalmente contraindicada porque expone el tendón a contaminación y daño iatrogénico irreversible, y además de no contar con el equipamiento necesario para su manejo. Suturar solo la piel sin reparar el tendón compromete la cicatrización funcional, atrapa el tendón retraído y genera adherencias y rigidez articular permanente. La reparación tendinosa primaria con ácido poliglicólico requiere cirujano experto, microscopio o lupa quirúrgica y técnica con sutura central tipo Kessler o modificada, recursos no disponibles en primer nivel. Limpieza, inmovilización y derivar es la regla.

PREGUNTA 36

Varón de 28 años, profesor de escuela rural en Ayacucho, acude por 5 días de náuseas, vómitos, malestar general y artralgias, con ictericia progresiva. Examen: ictericia mucocutánea, hepatomegalia dolorosa, sin signos clínicos de hepatopatía crónica. Refiere no haber recibido vacunación contra hepatitis B. Laboratorio: HBsAg(+), Anti-HBs(-), Anti-HBc IgM(+), HBeAg(+), Anti-HBe(-), transaminasas 10 veces el valor normal. Como médico del establecimiento de salud, además de tratar al paciente, debe decidir la intervención inmediata más adecuada para reducir el riesgo de transmisión en su entorno escolar. ¿Cuál es la acción más apropiada?

- A. Indicar reposo domiciliario y no informar al colegio, pues el riesgo de transmisión en el aula es mínimo
- B. Tamizaje serológico y vacunación de contactos no inmunizados del colegio, respetando confidencialidad
- C. Únicamente notificar el caso como hepatitis viral aguda al sistema de vigilancia, sin evaluar ni intervenir sobre contactos
- D. Solicitar hospitalización obligatoria y comunicar públicamente el diagnóstico para alertar a la comunidad

CLAVE: B

El paciente cursa una hepatitis B aguda altamente replicativa (HBsAg+, HBeAg+, AntiHBc IgM+, transaminasas 10 veces el valor normal) y, aunque la transmisión escolar es baja en condiciones habituales, los profesores y alumnos no inmunizados representan grupo expuesto cuando hay contacto con sangre o fluidos. La acción correcta es realizar tamizaje serológico de contactos no vacunados (HBsAg, AntiHBs, AntiHBc) y vacunar a quienes no tengan inmunidad documentada, todo con estricto respeto de la confidencialidad del paciente índice. Esta conducta combina los principios de prevención secundaria y los pilares éticos de no maleficencia y autonomía. Indicar solo reposo domiciliario y no informar al colegio subestima la responsabilidad de salud pública del médico y deja desprotegidos a contactos vacunables. Notificar únicamente al sistema de vigilancia sin intervenir activamente en contactos cumple solo la mitad del deber profesional, ya que la vigilancia sin acción no previene casos. Hospitalizar de manera obligatoria y comunicar públicamente el diagnóstico viola la confidencialidad del paciente y reproduce el estigma asociado a la hepatitis B, y además de no estar justificado clínicamente en un paciente estable. El equilibrio correcto está en proteger contactos sin exponer al paciente.

PREGUNTA 37

Varón de 48 años refiere dolor desde hace 2 días en fosa ilíaca izquierda, tolera la vía oral y no presenta comorbilidades relevantes. Examen: T 38°C, estable. Abdomen blando, depresible con dolor a la palpación en FII. Leucocitosis. TC: diverticulitis sigmoidea no complicada. ¿Cuál es el manejo más apropiado?

- A. Hospitalización con antibióticos EV, reposo intestinal y líquidos EV
- B. Sigmoidectomía laparoscópica inmediata
- C. Colectomía electiva después de 7 días de antibióticos EV
- D. Tratamiento conservador ambulatorio, dieta líquida, antibióticos orales

CLAVE: D

La diverticulitis aguda no complicada (Hinchey I sin absceso, sin perforación libre, sin fistulización) en paciente joven sin comorbilidades, que tolera la vía oral, está hemodinámicamente estable y con dolor manejable, se beneficia de manejo conservador ambulatorio con dieta líquida progresiva. Los estudios AVOD (Chabok 2012) y DIABOLO (Daniels 2017) demostraron que en pacientes seleccionados inmunocompetentes los antibióticos no aportan beneficio significativo y pueden omitirse con vigilancia clínica estrecha. Las guías más recientes (ASCRS 2020, WSES 2020) avalan ambas opciones: tratamiento ambulatorio con o sin antibióticos. En el contexto peruano,

el estándar práctico aún incluye cobertura antibiótica con ciprofloxacino más metronidazol o amoxicilina-clavulánico por 7 a 10 días por criterio de seguridad y disponibilidad. La hospitalización con antibióticos endovenosos se reserva para pacientes con intolerancia a la vía oral, comorbilidades significativas, falla del manejo ambulatorio, sospecha de complicación o adultos mayores con respuesta inflamatoria sistémica, condiciones que aquí no se cumplen. Ojo: la sigmoidectomía laparoscópica inmediata es para diverticulitis complicada con perforación, peritonitis difusa o falla terapéutica, no para episodio único no complicado. La colectomía electiva tras antibioticoterapia EV ya no se recomienda de rutina tras un primer episodio no complicado: solo se considera tras episodios recurrentes o complicaciones. Manejo ambulatorio con vía oral es estándar para diverticulitis no complicada.

PREGUNTA 38

Mujer de 67 años, con hipertensión arterial de larga data, desde hace dos meses presenta disnea progresiva que, en las últimas semanas, ha evolucionado hasta ortopnea. Examen: PA 150/90 mm Hg, crepitantes bibasales finos y leve edema maleolar bilateral. Laboratorio: proBNP claramente elevado para su rango de edad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Embolismo pulmonar agudo
- B. EPOC descompensado
- C. Falla cardíaca con FEVI preservada
- D. Taponamiento cardíaco

CLAVE: C

Lo que delata el diagnóstico: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (ICFEp), entidad cada vez más reconocida y sobre todo frecuente en mujeres mayores con antecedente de hipertensión arterial de larga data. Los signos clínicos de congestión pulmonar (disnea progresiva, ortopnea, crepitantes bibasales) y congestión sistémica (edema maleolar) en una paciente con HTA crónica que ha desarrollado disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, junto con la elevación marcada del proBNP, encajan con el patrón típico. La fisiopatología central es la rigidez ventricular con presión de llenado elevada pese a contractilidad conservada. El embolismo pulmonar agudo se presenta con disnea súbita, dolor torácico pleurítico, hipoxemia y, frecuentemente, signos de TVP, no con instalación insidiosa de dos meses con ortopnea progresiva. El EPOC descompensado cursa con sibilancias, antecedente tabáquico, espiración prolongada y patrón obstructivo, sin crepitantes finos bibasales como hallazgo dominante. El

taponamiento cardíaco produce hipotensión, ingurgitación yugular y pulso paradójico, con sonidos cardíacos apagados y derrame pericárdico, escenario clínico muy distinto. ICfEp en mujer mayor hipertensa con proBNP elevado es la combinación clásica.

PREGUNTA 39

Recién nacido de 38 semanas de madre con diabetes gestacional mal controlada, presenta a las 3 horas de vida temblores, irritabilidad y succión débil. La glucometría capilar confirma una glucosa de 25 mg/dL. Se dispone de acceso venoso permeable. ¿Cuál es el manejo inmediato más apropiado?

- A. Iniciar alimentación con fórmula láctea cada 3 horas
- B. Observar al recién nacido y repetir glucometría en 1 hora
- C. Bolo de dextrosa al 10% EV
- D. Glucagón intramuscular y reevaluar en 30 minutos

CLAVE: C

Un recién nacido sintomático (temblores, irritabilidad, succión débil) con glucemia capilar de 25 mg/dL cumple criterios de hipoglucemia neonatal grave según el protocolo SIBEN (glucosa <25 mg/dL en sintomático) y exige corrección endovenosa inmediata, no por vía oral. La conducta es bolo de dextrosa al 10% endovenosa a 2 mL/kg en 1-2 minutos, seguido de infusión continua a 6-8 mg/kg/min, manteniendo controles glicémicos seriados cada 30 minutos hasta estabilizar valores por encima de 45 mg/dL en al menos 2 controles consecutivos. La madre con diabetes gestacional mal controlada produce hijos con hiperinsulinismo transitorio que se manifiesta con hipoglucemia precoz a las primeras horas de vida. Iniciar fórmula láctea por vía oral en un neonato con succión débil y temblores subestima la gravedad, demora la corrección y expone a daño neurológico irreversible si la hipoglucemia persiste. Observar y repetir glucometría en una hora es peligroso: el cerebro neonatal es sobre todo vulnerable a hipoglucemia y el daño hipocampal por privación es rápido. El glucagón intramuscular tiene utilidad en hipoglucemias por hiperinsulinismo cuando no hay acceso venoso, pero aquí ya se cuenta con vía permeable y la dextrosa endovenosa es más rápida y predecible. Bolo de dextrosa 10% marca esto en hipoglucemia sintomática severa.

PREGUNTA 40

Recién nacido a término de parto eutócico, evaluación al primer minuto de vida: buen tono muscular, respira espontáneamente y FC 90 x'. Ya se ha realizado el secado,

posicionamiento de la vía aérea y estimulación táctil adecuada. ¿Cuál es la acción a realizar?

- A. Observar y reevaluar en 5 minutos
- B. Aplicar ventilación con presión positiva
- C. Administrar oxígeno de flujo libre y continuar observación
- D. Realizar intubación endotraqueal inmediata

CLAVE: B

El algoritmo del NRP 2020 es estricto: si tras los pasos iniciales (secar, posicionar, despejar vía aérea y estimular), el recién nacido tiene FC menor de 100 latidos por minuto, la acción inmediata es aplicar ventilación a presión positiva con bolsa y máscara a frecuencia de 40-60 ventilaciones por minuto, durante 30 segundos antes de reevaluar la frecuencia cardíaca. La FC de 90 cumple criterio para iniciar VPP porque el problema fisiopatológico central en el neonato deprimido es la hipoxia que conduce a apnea o respiración inefectiva y bradicardia secundaria, y la única intervención que revierte ese ciclo en segundos es ventilar con oxígeno alveolar (iniciar con FiO₂ 21% en RN a término). Observar y reevaluar en 5 minutos rompe el algoritmo y deja al recién nacido en hipoxia progresiva, con riesgo de encefalopatía hipóxico-isquémica. El oxígeno de flujo libre se reserva para neonatos que respiran espontáneamente con FC mayor de 100 pero con cianosis central persistente, no para FC menor de 100 que ya define depresión neonatal. La intubación endotraqueal solo se considera cuando la ventilación con bolsa y máscara durante 30 segundos no logra subir la FC sobre 60 o cuando hay sospecha de hernia diafragmática o aspiración meconial. FC <100 = ventilar es la respuesta uno del NRP.

PREGUNTA 41

Tercigesta primípara de 9 semanas por FUR, refiere sangrado vaginal hace 4 horas y dolor pélvico. Especuloscopia: no evidencia sangrado activo. Tacto vaginal: orificios cerrados. Ecografía: saco gestacional irregular de 35 mm, sin evidencia de embrión ni vesícula vitelina. ¿Cuál es el manejo más adecuado?

- A. Laparotomía exploratoria
- B. Videolaparoscopia diagnóstica
- C. Misoprostol
- D. Cerclaje cervical

CLAVE: C

En clase lo dijimos claro: gestación anembrionaria (huevo huero), diagnosticada cuando se observa saco gestacional mayor de 25 mm sin embrión ni vesícula vitelina visible,

criterio aplicable en este caso con saco de 35 mm. El manejo es uno de los siguientes: expectante (esperar expulsión espontánea), médico con misoprostol vaginal u oral, o quirúrgico con AMEU. En una gestante hemodinámicamente estable con orificios cervicales cerrados y sin sangrado activo, el misoprostol es opción razonable y costo-efectiva, sobre todo disponible en centros peruanos con acceso al medicamento esencial. La laparotomía exploratoria es excesiva y se reserva para sospecha de embarazo ectópico complicado con inestabilidad hemodinámica, lo cual no aplica aquí donde la gestación es intrauterina confirmada. La videolaparoscopia diagnóstica tampoco está indicada porque el diagnóstico ya está hecho con la ecografía y no hay duda diagnóstica que justifique la cirugía. El cerclaje cervical es una intervención para insuficiencia cervical en segundo trimestre con cuello dilatado en gestación viable, situación opuesta a la pérdida ya confirmada. Misoprostol resuelve el cuadro de manera ambulatoria y conservadora.

PREGUNTA 42

En el proceso de planificación de un establecimiento de salud, se requiere un instrumento técnico que, a partir del análisis de la oferta y la demanda de servicios, defina el conjunto articulado de prestaciones que necesita la población. ¿Qué instrumento se debe utilizar?

- A. Marco lógico
- B. Plan operativo anual
- C. Programa arquitectónico
- D. Programa médico funcional

CLAVE: D

El programa médico funcional es el instrumento técnico de planificación en salud que, a partir del análisis de la oferta y demanda de servicios, define el conjunto articulado de prestaciones que necesita la población a la que servirá un establecimiento de salud. Es la base para dimensionar áreas, equipamiento, recurso humano y servicios, y antecede al programa arquitectónico. En el Perú el PMF se construye según los lineamientos del MINSA y forma parte obligatoria del expediente técnico para construir o ampliar un establecimiento, asegurando que la infraestructura responda a necesidades reales. El marco lógico es una herramienta de gestión de proyectos que articula objetivos, actividades, indicadores y supuestos, no específicamente un instrumento de planificación de prestaciones de un establecimiento. El plan operativo anual es un instrumento de gestión institucional anual que organiza actividades y presupuesto en un

periodo corto, no diseña la cartera de servicios. El programa arquitectónico se elabora después del PMF y traduce las prestaciones en metros cuadrados, distribución y especificaciones constructivas, pero no define las prestaciones. El PMF es el primer paso, y los demás se derivan de él.

PREGUNTA 43

En un centro de salud de primer nivel, ingresa un varón de 20 años que cayó de un árbol de aproximadamente 5 metros, con pérdida de conciencia breve. A su llegada está hemodinámicamente estable. Presenta apertura ocular a la orden verbal, emite palabras inapropiadas y al estímulo doloroso realiza flexión anormal de las extremidades. No hay disponibilidad de TC y la referencia al hospital más cercano toma 90 minutos. Con base en la Escala de Coma de Glasgow y en las recomendaciones actuales para el manejo del traumatismo craneoencefálico. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A. Asegurar vía aérea y referirlo a hospital III-1
- B. Radiografía de cráneo y decidir según resultado
- C. Dar de alta con signos de alarma
- D. Observarlo 24 horas sin referir

CLAVE: A

El cálculo del GCS es: apertura ocular a la voz (3) + palabras inapropiadas (3) + flexión anormal al dolor (3) = 9 puntos, lo que clasifica el TCE como moderado (rango 9-12). Todo TCE moderado o severo requiere tomografía urgente y manejo en hospital con neurocirugía disponible, por lo que en un primer nivel sin TC la conducta es asegurar la vía aérea (incluso considerar intubación si GCS sigue cayendo o si hay vómitos), estabilizar y referir al hospital de mayor complejidad (nivel III-1). El traslado de 90 minutos exige acompañamiento médico continuo con monitoreo neurológico repetido. La radiografía de cráneo no aporta información útil para el manejo agudo del TCE moderado porque no detecta hematomas intracraneales, contusiones ni edema, y reemplazó hace décadas el rol de la TC en este escenario. Dar de alta con signos de alarma es peligroso en un paciente con GCS 9, mecanismo de alta energía (caída de 5 metros) y pérdida de conciencia: el riesgo de deterioro tardío por hematoma epidural es alto. Observar 24 horas sin referir bloquea el acceso al neurocirujano y a la imagen necesaria. Asegurar vía aérea y referir a hospital III-1 es la única conducta que protege al paciente.

PREGUNTA 44

Varón de 30 años, en tratamiento con carbamazepina desde hace 10 días, presenta fiebre alta, malestar general y lesiones cutáneas dolorosas. Examen: máculas eritematosas purpúricas confluentes que evolucionan a ampollas flácidas y desprendimiento epidérmico; compromiso de menos del 10% de la superficie corporal, erosiones en mucosa oral y conjuntival. Signo de Nikolsky positivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Síndrome de Stevens-Johnson
- B. Pénfigo vulgar
- C. Penfigoide ampolloso
- D. Síndrome de POEMS

CLAVE: A

La pista clave aquí es síndrome de Stevens-Johnson, reacción cutánea grave inducida por fármacos donde la carbamazepina es uno de los gatillantes clásicos junto con alopurinol, lamotrigina, sulfonamidas y antibióticos. La presentación incluye fiebre, malestar general, máculas eritematosas purpúricas confluentes que evolucionan a ampollas flácidas y desprendimiento epidérmico con Signo de Nikolsky positivo, y compromiso de mucosas (oral, conjuntival, genital). Cuando el desprendimiento es menor del 10% de la SCT se diagnostica SJS; entre 10-30% es superposición SJS/NET; y mayor de 30% es necrólisis epidérmica tóxica. El pénfigo vulgar también cursa con ampollas flácidas y Nikolsky positivo, pero su instalación es insidiosa y crónica, sin relación con un fármaco recientemente iniciado y con autoanticuerpos contra desmogleína 3, no con fiebre alta y necrosis cutánea aguda. El penfigoide ampolloso produce ampollas tensas (no flácidas), Nikolsky negativo y afecta a adultos mayores con prurito intenso, escenario distinto. El síndrome de POEMS es un trastorno paraneoplásico con polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, gammapatía monoclonal y cambios cutáneos no ampollosos. La temporalidad con el fármaco más mucositis y Nikolsky positivo apunta a SJS.

PREGUNTA 45

Mujer de 35 años, nulípara, consulta por sangrado intermenstrual recurrente desde hace 3 meses. No usa anticonceptivos hormonales. Examen: útero de 7 cm anteverso, cérvix normal, sangrado leve a través del orificio cervical externo. Ecografía transvaginal: útero de 7.5 cm, no miomas, endometrio de 18 mm. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?

- A. Ecografía control en un mes
- B. Resonancia magnética pélvica
- C. Tratamiento con progestágenos
- D. Biopsia endometrial

CLAVE: D

En una mujer de 35 años con sangrado intermenstrual recurrente y endometrio engrosado de 18 mm en ecografía transvaginal (sobre el límite considerado normal en pre-menopausia, donde se espera variación entre 4 y 14 mm según fase del ciclo), corresponde realizar biopsia endometrial para descartar hiperplasia con o sin atipia, pólipo o neoplasia endometrial. La biopsia con cánula de Pipelle es el método ambulatorio de elección en primer nivel ginecológico, con sensibilidad alta para hiperplasia y carcinoma cuando se obtiene muestra adecuada. La ecografía control en un mes es estrategia que retrasa el diagnóstico y no aporta nueva información cuando el endometrio engrosado ya está documentado en el contexto clínico de sangrado anormal. La resonancia magnética pélvica no es de primera línea para evaluar engrosamiento endometrial y se reserva para estadificación de neoplasia confirmada. El tratamiento con progestágenos puede usarse para sangrado uterino disfuncional, pero antes de tratar empíricamente sin diagnóstico histológico se expone a perpetuar una hiperplasia atípica o un carcinoma en evolución. Biopsia primero, tratamiento después.

PREGUNTA 46

Primigesta de 35 semanas, sin control prenatal, acude por presentar convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Examen: PA 170/110 mmHg. LCF 144 x' reactivo. Se asegura vía aérea, se administra sulfato de magnesio EV según protocolo y se logran controlar las convulsiones. ¿Cuál es la conducta más adecuada a seguir?

- A. Antihipertensivos y evaluar en 48 horas
- B. Programar cesárea a las 37 semanas
- C. Culminar la gestación de manera inmediata
- D. Control de presión arterial hasta las 37 semanas

CLAVE: C

En clase lo dijimos claro: eclampsia: convulsión tónico-clónica generalizada en una gestante con HTA severa (170/110) y proteinuria presunta (no controlada por falta de prenatal). Una vez controlada la convulsión con sulfato de magnesio y asegurada la vía aérea, la conducta es culminar la gestación de manera inmediata, idealmente por cesárea cuando el cuello no está favorable y la urgencia clínica es alta. La eclampsia es

una emergencia obstétrica con mortalidad materna y perinatal elevada, y prolongar la gestación expone a recurrencia de convulsiones, hemorragia cerebral, abrupcio placentae y muerte fetal. Iniciar antihipertensivos y reevaluar en 48 horas perpetúa el riesgo de complicaciones maternas como ACV, edema pulmonar y falla renal aguda, y además de comprometer el bienestar fetal. Ojo: programar cesárea a las 37 semanas posterga dos semanas un escenario que no admite espera. Controlar la presión arterial hasta las 37 semanas tiene el mismo problema de fondo: la eclampsia ya ocurrió y no se trata con manejo expectante. La regla obstétrica es clara: estabilizar madre, controlar convulsión con magnesio, controlar presión arterial con labetalol o hidralazina, y culminar embarazo en las próximas horas.

PREGUNTA 47

En un estudio de cohorte realizado en un hospital de Lima, se evalúa la asociación entre obesidad y desarrollo de diabetes tipo 2 en adultos de 30 a 60 años. El investigador desea saber hasta qué punto los resultados pueden aplicarse a adultos con características similares atendidos en otros hospitales y regiones del país. ¿A qué concepto metodológico se refiere esta preocupación?

- A. Validez externa
- B. Confiabilidad
- C. Precisión
- D. Sensibilidad

CLAVE: A

La validez externa, también llamada generalizabilidad, se refiere al grado en que los resultados de un estudio realizado en una muestra específica pueden extrapolarse o aplicarse a otras poblaciones, contextos o entornos diferentes. Cuando el investigador se pregunta si los hallazgos obtenidos en un hospital de Lima son aplicables a adultos similares de otros hospitales y regiones del país, está evaluando precisamente la validez externa del estudio. Depende de las características de la muestra, los criterios de inclusión, el escenario clínico y la similitud con la población diana. La confiabilidad se refiere a la consistencia y reproducibilidad de los resultados al repetir la medición bajo condiciones similares, no a la generalización a otras poblaciones. La precisión hace referencia al grado de variabilidad de los estimadores y se relaciona con el tamaño muestral y la dispersión de los datos, no con la aplicabilidad externa. La sensibilidad es una propiedad de las pruebas diagnósticas que mide la capacidad de detectar

verdaderos positivos. Cuando un investigador pregunta '¿se puede aplicar a otros?', está hablando de validez externa, concepto distinto de validez interna (libre de sesgos).

PREGUNTA 48

Varón de 40 años acude a emergencias porque desde hace 12 horas presenta dolor epigástrico intenso irradiado a la espalda, con náuseas y vómitos. Refiere consumo crónico de alcohol. Examen: taquicárdico y con leve hipotensión. Amilasa y lipasa séricas elevadas > 3 veces el valor normal. En las primeras 24 horas de evolución, ¿cuál de los siguientes hallazgos se asocia de manera más significativa con un peor pronóstico?

- A. Mantenimiento de dolor abdominal intenso a pesar de analgesia multimodal AINEs y opioides
- B. Incremento adicional de la amilasa sérica por encima de 1500 U/L y de lipasa en 500 U/L
- C. Persistencia de hipotensión a pesar de adecuada reanimación con líquidos EV
- D. Aparición de fiebre mayor de 38,5 °C en las primeras 24 horas

CLAVE: C

En pancreatitis aguda, el predictor de peor pronóstico más sólido en las primeras 24 horas es la presencia de falla orgánica persistente, sobre todo cardiovascular (hipotensión que no responde a reanimación), respiratoria o renal, según los criterios de la clasificación de Atlanta revisada. La persistencia de hipotensión pese a reanimación adecuada con cristaloides traduce choque distributivo o hipovolémico severo y se asocia a mortalidad significativamente mayor, y además de marcar la transición de pancreatitis leve a moderadamente severa o severa. El mantenimiento del dolor pese a analgesia multimodal es síntoma frecuente y no se correlaciona linealmente con el pronóstico ni con la severidad real del cuadro. El nivel absoluto de amilasa y lipasa pierde valor pronóstico tras el diagnóstico inicial: una vez establecido, la evolución no se sigue por estos marcadores, ya que pueden mantenerse altos sin que la pancreatitis sea grave. La fiebre en las primeras 24 horas suele corresponder a respuesta inflamatoria sistémica estéril, no a infección, y es esperable. La falla orgánica persistente, en cambio, es el dato pronóstico más significativo y guía la conducta terapéutica.

PREGUNTA 49

Varón de 50 años acude a emergencia por dolor intenso en flanco derecho de inicio súbito, tipo cólico, irradiado hacia la cara interna del muslo derecho, con intensidad

8/10. Refiere náuseas, sin fiebre ni síntomas urinarios bajos. Examen: puño-percusión renal derecha positiva. Examen de orina muestra hematuria microscópica positiva, prueba de Thevenon negativa y pH urinario de 6, 0. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Pielonefritis aguda derecha
- B. Enfermedad poliquística renal
- C. Tumor vesical con hematuria indolora
- D. Litiasis ureteral derecha

CLAVE: D

Lo que delata el diagnóstico: los hallazgos clásicos de cólico renoureteral por litiasis: dolor súbito, intenso, tipo cólico, irradiado del flanco hacia la cara interna del muslo (siguiendo el trayecto del uréter), puño-percusión positiva, hematuria microscópica como signo de irritación de la mucosa urinaria por el cálculo, sin fiebre ni síntomas urinarios bajos. La prueba de Thevenon negativa descarta sangrado digestivo bajo y el pH urinario de 6, 0 es compatible con litiasis cálcica (la más frecuente en el Perú). El estudio de elección para confirmación es la urotomografía sin contraste o, en su defecto, ecografía renal y vesical. La pielonefritis aguda cursa con fiebre alta, dolor lumbar y síndrome miccional con piuria y bacteriuria, ausentes en este paciente. La enfermedad poliquística renal produce dolor crónico, masas renales palpables y antecedente familiar conocido, no inicio súbito agudo en flanco. El tumor vesical con hematuria indolora típicamente da hematuria macroscópica sin dolor cólico, no encaja con este perfil de dolor intenso irradiado y hematuria microscópica. Cólico que comienza en flanco y baja hacia el muslo con hematuria micro y puño-percusión positiva es litiasis ureteral y no hay vuelta.

PREGUNTA 50

Mujer de 30 años acude por dolor tipo cólico en hipogastrio que se irradia a región lumbar derecha, náuseas y vómitos. Examen: PA 110/70 mmHg, FC 88 x', FR 18 x', T 36, 8 °C, sin signos de irritación peritoneal. Examen ginecológico: se palpa, en el anexo derecho, una masa de 8 cm, dolorosa a la palpación. β -hCG: 0.5 mUI/dL. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Torsión anexial
- B. Apendicitis aguda
- C. Embarazo ectópico roto
- D. Absceso tubo ovárico

CLAVE: A

La torsión anexial es la primera sospecha en una mujer joven con dolor cólico súbito en hipogastrio irradiado a fosa lumbar y masa anexial palpable de 8 cm dolorosa, con β -hCG negativa que descarta gestación ectópica. La torsión ocurre típicamente en quistes mayores de 5 cm que rotan sobre el pedículo vascular, comprometiendo primero el retorno venoso y luego el flujo arterial, lo que genera isquemia anexial y necesidad de cirugía urgente. Las náuseas y vómitos son frecuentes por la irritación peritoneal localizada y el componente neurovegetativo. La ecografía Doppler es el estudio de elección para confirmar el compromiso vascular. La apendicitis aguda produce dolor que migra de epigastrio a fosa ilíaca derecha con signo de McBurney, defensa o rebote, fiebre y leucocitosis, no masa anexial palpable. El embarazo ectópico roto cursa con β -hCG positiva (mayor de 1500-2000 mUI/mL) y signos de hemoperitoneo con inestabilidad hemodinámica; aquí la β -hCG es negativa, lo que lo descarta. El absceso tubo-ovárico se acompaña de fiebre alta, leucocitosis, descarga vaginal anormal y antecedente de EPI; aquí la temperatura es normal y no hay datos infecciosos. Masa anexial dolorosa con β -hCG negativa = torsión anexial hasta confirmar con Doppler.

PREGUNTA 51

Turista de 35 años, traído por aparición súbita de intensa ansiedad, agitación psicomotora y dolor torácico opresivo leve. Refiere haber "consumido algo para aguantar el viaje por avión" sin precisar la sustancia. Examen: PA 220/120 mmHg, FC 132 x', FR 24 x', T 36, 5 °C, midriasis bilateral, piel fría y sudorosa, habla acelerada, sin focalización neurológica. EKG muestra taquicardia sinusal sin elevación del ST. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Crisis paroxística por feocromocitoma
- B. Ataque de pánico
- C. Tormenta tiroidea
- D. Intoxicación por cocaína

CLAVE: D

El sello clínico aquí: el síndrome simpaticomimético clásico: HTA severa (220/120), taquicardia, midriasis, sudoración, agitación psicomotora y dolor torácico, en un viajero que reconoce haber consumido una sustancia no precisada. La intoxicación aguda por cocaína es la primera sospecha porque combina los efectos α y β adrenérgicos con vasoespasmo coronario, lo que explica el dolor torácico y el riesgo de IAM por trombosis coronaria, sobre todo en pacientes jóvenes sin factores de riesgo cardiovascular

tradicionales. El feocromocitoma produce crisis hipertensivas paroxísticas con cefalea, palpitaciones y diaforesis episódicas, pero no se vincula a uso de sustancias y suele tener historia previa de paroxismos. El ataque de pánico genera ansiedad intensa con palpitaciones pero sin HTA severa de 220/120 ni midriasis tan marcada. La tormenta tiroidea cursa con hipertermia, taquicardia, agitación y signos hipermetabólicos, no piel fría sudorosa ni dolor torácico isquémico. El manejo de cocaína incluye benzodiacepinas EV como primera línea, evitando betabloqueadores selectivos puros por riesgo de vasoespasmo coronario sin oposición α .

PREGUNTA 52

Mujer de 62 años, consulta por pérdida de orina con sensación de bulto. Examen: cistocele grado II y defecto lateral de la pared vaginal anterior, compatible con una desinserción de la fascia pubocervical de su soporte lateral. ¿Qué estructura anatómica está comprometida en este defecto?

- A. Ligamento ancho del útero
- B. Ligamento redondo
- C. Arco tendinoso de la fascia pélvica
- D. Fascia rectovaginal posterior

CLAVE: C

El soporte lateral de la pared vaginal anterior está dado por el arco tendinoso de la fascia pélvica (ATFP), también conocido como línea blanca, una banda de tejido conectivo que se extiende desde la espina ciática hasta la sínfisis del pubis y donde se inserta la fascia pubocervical. Cuando hay desinserción de la fascia pubocervical de su soporte lateral, se produce un cistocele de tipo defecto lateral o paravaginal, distinto del cistocele central por debilidad de la fascia pubocervical en línea media. El ligamento ancho del útero es un repliegue peritoneal que cubre las trompas y los anexos pero no participa en el soporte vaginal. El ligamento redondo se extiende del útero al canal inguinal y mantiene la anteversión uterina, no el soporte de la pared anterior. La fascia rectovaginal posterior soporta la pared vaginal posterior y su debilidad genera rectocele, no cistocele. Identificar el defecto lateral es clave porque su corrección quirúrgica difiere de la del cistocele central, requiriendo reinserción al ATFP mediante técnicas de plicatura paravaginal.

PREGUNTA 53

Varón de 32 años, procedente de zona rural con deficiente saneamiento básico, consulta por 10 días de fiebre, malestar general y dolor en hipocondrio derecho que empeora con la tos y la palpación. Refiere antecedente de episodios de diarrea con moco y sangre hace 2 meses, que se autolimitó sin tratamiento. Se sospecha amebiasis invasiva por Entamoeba histolytica con compromiso extraintestinal. ¿Cuál es la localización anatómica más probable de amebiasis extraintestinal?

- A. Bazo
- B. Pulmones
- C. Peritoneo
- D. Hígado

CLAVE: D

El absceso hepático amebiano es la forma extraintestinal más frecuente de *Entamoeba histolytica*, con incidencia significativa en zonas con deficiente saneamiento como las descritas. Los trofozoítos invasores atraviesan la mucosa colónica, alcanzan la circulación portal y siembran preferentemente en el lóbulo hepático derecho, donde generan un absceso único con contenido en pasta de anchoas (necrosis licuefactiva). El antecedente de diarrea disintérica autolimitada hace 2 meses encaja con la fase intestinal previa, y el dolor en hipocondrio derecho con fiebre y reacción pleural es el patrón clínico clásico. El compromiso esplénico por amebiasis es excepcional y no constituye un patrón frecuente. La afectación pulmonar puede ocurrir por extensión directa de un absceso hepático a través del diafragma, no como localización primaria; el paciente puede presentar tos y derrame pleural reactivo. La amebiasis peritoneal es complicación grave por rotura del absceso, con peritonitis y alta mortalidad, pero no es el patrón más frecuente. El hígado concentra más del 90% de las localizaciones extraintestinales de amebiasis, y el tratamiento es metronidazol seguido de un amebicida luminal como paromomicina o iodoquinol.

PREGUNTA 54

Varón de 55 años, sin síntomas urinarios, acude a un establecimiento de primer nivel de atención para su control anual. Tiene antecedente de padre fallecido por cáncer de próstata a los 68 años. No fuma, no consume alcohol en exceso, no tiene comorbilidades importantes. Le solicita al médico que "le haga todos los exámenes posibles para descartar cáncer de próstata". Considerando la evidencia actual y el rol del primer nivel de atención. ¿Cuál es la estrategia más adecuada para reducir el riesgo de morbilidad por cáncer de próstata en este paciente?

- A. Explicarle los riesgos y beneficios del tamizaje, PSA y el tacto rectal
- B. Explicarle que el tamizaje para cáncer de próstata está contraindicado en primer nivel de atención
- C. Indicar PSA anual de forma indefinida, sin consejería sobre riesgos de sobrediagnóstico
- D. Solicitar resonancia magnética prostática de forma inmediata

CLAVE: A

El tamizaje del cáncer de próstata es uno de los temas más controversiales en medicina preventiva. Las recomendaciones actuales (USPSTF, AUA, EAU) coinciden en que la decisión debe ser compartida entre médico y paciente, sobre todo en hombres entre 55 y 69 años con factor de riesgo (antecedente familiar de primer grado). En el primer nivel de atención corresponde realizar consejería estructurada sobre los beneficios potenciales (detección precoz de cáncer agresivo) y los riesgos (falsos positivos, sobrediagnóstico, biopsias innecesarias, ansiedad), y luego decidir conjuntamente la realización de PSA y tacto rectal. Decir que el tamizaje está contraindicado en primer nivel es incorrecto: las herramientas básicas (PSA, tacto rectal) son perfectamente realizables en este escenario, y el rol preventivo es justamente del primer nivel. Indicar PSA anual indefinido sin consejería es paternalismo médico que omite el riesgo de sobrediagnóstico y la necesidad de informar al paciente de las implicancias de cada resultado. Solicitar resonancia magnética prostática de forma inmediata sin un PSA elevado o un tacto sospechoso es desproporcionado y va contra la evidencia. La consejería compartida es el estándar contemporáneo.

PREGUNTA 55

Mujer de 29 años con VIH. Acude por lesiones en vulva, región suprapúbica y cara interna de muslos de 6 meses de evolución y que desde hace 2 meses han aumentado en número y tamaño, asintomáticas. Examen: múltiples pápulas de 5 a 10 mm de diámetro, de color rosado-rojizo, de superficie lisa y brillante, con umbilicación central, sin eritema ni signos de inflamación de la piel circundante. ¿Cuál es la indicación más adecuada?

- A. Crioterapia y refuerzo de adherencia al TAR
- B. Aciclovir oral y tópico
- C. Serología para sífilis
- D. Antibioticoterapia de amplio espectro

CLAVE: A

Las lesiones descritas (pápulas rosado-rojizas con umbilicación central característica, distribuidas en vulva, suprapubis y cara interna de muslos en una paciente con VIH) son patognomónicas de molusco contagioso, infección viral por poxvirus que en pacientes inmunocomprometidos suele presentarse con lesiones múltiples, mayores y de difícil control. El manejo combina tratamiento local (crioterapia con nitrógeno líquido, curetaje o cantaridina) con la optimización del tratamiento antirretroviral, ya que la mejoría inmunológica con CD4 ascendentes facilita la resolución y reduce las recurrencias. El aciclovir trata herpes simple y varicela-zóster, no molusco contagioso (agente diferente, no susceptible). La serología para sífilis es razonable como tamizaje en cualquier paciente con VIH y conducta sexual de riesgo, pero no resuelve el cuadro clínico actual ni es la respuesta a la pregunta sobre indicación más adecuada. La antibioticoterapia de amplio espectro es injustificada porque no hay infección bacteriana clínica ni datos de inflamación. Crioterapia para las lesiones más reforzar adherencia al TAR es el abordaje correcto en VIH con molusco diseminado.

PREGUNTA 56

Recién nacido de 38 semanas, parto vaginal, madre con ruptura prematura de membranas de 20 horas y sin controles prenatales previos. A las 8 horas de vida presenta taquipnea, tiraje subcostal e intercostal, quejido espiratorio y saturación de oxígeno de 88% al aire ambiente. Rx de tórax: infiltrados bilaterales difusos. Se plantea el diagnóstico de sepsis. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- A. Streptococo del grupo B
- B. Listeria monocytogenes
- C. Escherichia coli
- D. Streptococo pneumoniae

CLAVE: A

Streptococcus agalactiae (estreptococo del grupo B) es el agente más frecuente de sepsis neonatal precoz (menor de 72 horas de vida) en recién nacidos a término, sobre todo cuando coexisten factores de riesgo como ruptura prematura de membranas mayor de 18 horas, ausencia de controles prenatales y, por tanto, ausencia de tamizaje materno con cultivo vaginorrectal entre 35-37 semanas. La presentación clínica con taquipnea, tirajes, quejido y compromiso radiológico difuso a las pocas horas de vida es típica del cuadro neumónico-séptico por SGB. *Listeria monocytogenes* causa sepsis precoz también, pero es menos frecuente que SGB en Perú y se asocia más con consumo materno de productos lácteos no pasteurizados y meconio amniótico. *Escherichia coli* es

el segundo agente en sepsis neonatal precoz en términos de frecuencia, sobre todo en pretérminos, pero queda detrás del SGB en recién nacidos a término. *Streptococcus pneumoniae* no es agente típico de sepsis neonatal precoz, aunque puede causar infecciones tardías. RPM prolongada + RN a término + cuadro respiratorio precoz = pensar siempre primero en SGB y dar ampicilina más gentamicina.

PREGUNTA 57

Varón de 30 años consulta por debilidad progresiva y simétrica en ambos miembros inferiores desde hace 3 días, que dificulta la marcha. Examen neurológico: fuerza 3/5 en miembros inferiores, arreflexia rotuliana y aquiliana, tono muscular disminuido y sensibilidad conservada. Refiere haber tenido cuadro de diarrea acuosa autolimitada una semana antes. No presenta compromiso esfinteriano ni fiebre. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Miastenia gravis generalizada
- B. Síndrome de Guillain-Barré
- C. Mielitis transversa aguda
- D. Poliomiелitis aguda

CLAVE: B

Antes de elegir, fíjate en síndrome de Guillain-Barré: parálisis flácida ascendente, simétrica, con arreflexia y sensibilidad conservada, instaurada en días tras un cuadro infeccioso previo (la gastroenteritis por *Campylobacter jejuni* una semana antes es el antecedente clásico). La fisiopatología es polirradiculopatía desmielinizante autoinmune por mimetismo molecular, donde anticuerpos contra antígenos de *Campylobacter* reaccionan de forma cruzada con gangliósidos de la mielina periférica. La progresión típica es ascendente desde miembros inferiores y puede comprometer pares craneales y musculatura respiratoria. La miastenia gravis cursa con debilidad fluctuante de predominio bulbar y ocular (ptosis, diplopía, disfagia), sin arreflexia ni vínculo con infección previa. La mielitis transversa aguda produce nivel sensitivo, compromiso esfinteriano frecuente y signos de motoneurona superior con hiperreflexia tras la fase de choque medular, no arreflexia mantenida. La poliomiелitis es asimétrica, con afectación motora pura y proviene de zonas con bajo tamizaje vacunal; en el Perú está erradicada salvo importación. El diagnóstico de Guillain-Barré se confirma con líquido cefalorraquídeo (disociación albumino-citológica) y EMG.

PREGUNTA 58

Desde el punto de vista epidemiológico, para planificar adecuadamente las acciones de control del dengue (búsqueda de criaderos, educación comunitaria y delimitación de contactos). ¿Cómo se denomina al período que transcurre desde la exposición a la infección hasta que la persona se vuelve capaz de transmitir el virus?

- A. Transmisibilidad
- B. Incubación
- C. Latencia
- D. Prodrómico

CLAVE: C

En epidemiología de enfermedades transmisibles, el período de latencia se define como el tiempo que transcurre desde la exposición al agente infeccioso hasta que la persona es capaz de transmitirlo a otros. Es un concepto distinto del período de incubación, que se refiere al tiempo desde la infección hasta la aparición de síntomas. Para el dengue, conocer el período de latencia es operativo porque la persona puede ser virémica y, por tanto, infectante para los mosquitos vectores antes incluso de presentar síntomas, lo que impacta en las estrategias de búsqueda de contactos y control vectorial. El período de transmisibilidad describe el tiempo durante el cual la persona puede transmitir la infección, no el momento desde el que comienza a hacerlo. La incubación se refiere al lapso desde la infección hasta los síntomas, conceptualmente diferente. El período prodrómico es el intervalo entre el inicio de los síntomas inespecíficos y la aparición de los signos característicos de la enfermedad, propio de la clínica más que de la cadena epidemiológica. Distinguir latencia de incubación es esencial en vigilancia para dengue, sarampión, COVID-19 y otras enfermedades de transmisión respiratoria o vectorial.

PREGUNTA 59

Varón de 50 años en paro cardiorrespiratorio por fibrilación ventricular. Se mantiene con compresiones torácicas de alta calidad, se ha administrado adrenalina 1 mg después de la segunda descarga. Tras realizar la tercera desfibrilación, el paciente continúa en fibrilación ventricular. ¿Cuál es el fármaco antiarrítmico de elección que se debe administrar a continuación?

- A. Gluconato de calcio 1g EV en bolo
- B. Lidocaína de 0.5 a 0.75 mg/kg EV en bolo
- C. Atropina 1 mg EV en bolo
- D. Amiodarona 300 mg EV en bolo

CLAVE: D

El algoritmo de soporte vital cardiovascular avanzado de la AHA establece que en FV/TV sin pulso refractarias a las primeras tres descargas, el fármaco antiarrítmico de elección es amiodarona 300 mg EV en bolo, idealmente tras la tercera descarga, junto con la continuación de las compresiones torácicas y la adrenalina cada 3-5 minutos. La amiodarona prolonga la repolarización ventricular y aumenta el periodo refractario, facilitando que la próxima desfibrilación sea efectiva. Si tras la cuarta descarga persiste la FV, se administra una segunda dosis de 150 mg. El gluconato de calcio se reserva para hiperpotasemia documentada o sospechada, sobredosis de bloqueadores de calcio o hipocalcemia, no para FV simple. La lidocaína es alternativa secundaria a la amiodarona cuando esta no está disponible, con menor evidencia de eficacia comparativa. La atropina ya no forma parte del algoritmo de FV/TV ni de asistolia desde 2010 por falta de evidencia y se reserva para bradicardia sintomática con pulso. Amiodarona 300 mg EV es la elección para FV/TV sin pulso refractaria.

PREGUNTA 60

Varón de 25 años, previamente sano, acude por dolor abdominal de 6 días de evolución, inicialmente periumbilical y luego localizado en fosa ilíaca derecha, asociado a fiebre de hasta T 38, 5 °C. Examen: hemodinámicamente estable, masa dolorosa en fosa ilíaca derecha sin signos de irritación peritoneal. Hemograma: leucocitos 23, 000/mm³ con neutrofilia. Ecografía abdominal evidencia colección compatible con absceso apendicular de 3 cm de diámetro, bien delimitado. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- A. Tratamiento médico con antibioticoterapia EV de amplio espectro y observación
- B. Referencia a otro centro de mayor complejidad
- C. Drenaje percutáneo guiado por imagen más antibioticoterapia EV
- D. Tratamiento quirúrgico inmediato (apendicectomía y drenaje del absceso)

CLAVE: C

En apendicitis aguda complicada con absceso de 3 cm bien delimitado en paciente estable, las guías SAGES y EAES recomiendan manejo no operatorio inicial mediante drenaje percutáneo guiado por imagen (ecografía o TC) más antibioticoterapia endovenosa de amplio espectro. En abscesos en el límite inferior (menores o iguales a 3 cm), algunos protocolos aceptan manejo solo con antibióticos sin drenaje cuando el absceso es de difícil acceso o el paciente responde rápidamente, pero el estándar actual ante un absceso de 3 cm bien delimitado y accesible sigue siendo el drenaje percutáneo. Esta estrategia evita la cirugía urgente en condiciones inflamatorias

adversas y permite considerar apendicectomía de intervalo a las 6 a 8 semanas, aunque la evidencia reciente sugiere que en muchos casos puede omitirse. Antibioticoterapia EV sin drenaje funciona en abscesos pequeños no drenables (menores de 3 cm o de difícil acceso), pero un absceso de 3 cm bien delimitado se beneficia del drenaje. Ojo: la referencia a otro centro está indicada solo si el primer establecimiento no cuenta con drenaje guiado por imagen, lo cual no se especifica. La cirugía inmediata en presencia de absceso aumenta el riesgo de daño de asas intestinales adheridas al plastrón inflamatorio, prolonga el tiempo quirúrgico y eleva la tasa de complicaciones; queda reservada para fallas del manejo conservador o peritonitis difusa. Drenaje + antibiótico es el estándar.

PREGUNTA 61

Niño de 6 años acude a emergencia 30 horas después de una mordedura de araña en muslo derecho. Presenta dolor intenso y progresivo en la zona. Examen: FC 130 x', PA 85/50 mmHg, hepatomegalia de 3 cm, ictericia leve y lesión cutánea violácea-necrótica de 10 cm de diámetro con borde eritematoso. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- A. Iniciar corticoides sistémicos como única medida terapéutica
- B. Indicar manejo local con antibióticos tópicos
- C. Administrar suero antiloxoscélico, hidratación endovenosa
- D. Realizar desbridamiento quirúrgico de la lesión cutánea

CLAVE: C

Lo que delata el diagnóstico: loxoscelismo cutáneo-visceral, forma grave de la mordedura por *Loxosceles laeta* (araña marrón o de los rincones), endémica en el Perú. La presentación combina lesión necrótica en escarapela con borde eritematoso (signo característico) y compromiso sistémico con hemólisis intravascular masiva (ictericia, hepatomegalia, hipotensión, taquicardia). Constituye una emergencia médica que requiere administración inmediata de suero antiloxoscélico endovenoso, hidratación con cristaloides para mantener perfusión renal y prevenir falla por hemoglobinuria, y soporte transfusional según necesidad. Los corticoides sistémicos pueden tener un rol adyuvante en loxoscelismo, pero administrarlos como única medida terapéutica deja al paciente sin neutralización del veneno y sin reanimación adecuada. El manejo local con antibióticos tópicos no actúa sobre la fisiopatología, ya que la necrosis es por daño tóxico directo del veneno (esfingomielinasa D) y la activación del complemento, no por infección bacteriana primaria. El desbridamiento quirúrgico precoz está contraindicado en las

primeras 72 horas porque amplifica la respuesta inflamatoria y el daño tisular; se realiza tardíamente cuando la zona necrótica está bien delimitada. Suero antiloxoscélico y reanimación son la conducta correcta.

PREGUNTA 62

Mujer de 45 años, desde hace 24 horas presenta dolor en hipocondrio derecho, fiebre de 38, 5 °C y náuseas. Niega comorbilidades. Examen: estable. Abdomen: dolor a la palpación en hipocondrio derecho, signo de Murphy (+). Laboratorio: leucocitosis de 14 000/mm³. Ecografía: vesícula biliar distendida, pared engrosada de 5 mm, litiasis sin dilatación de la vía biliar ni colecciones perivesiculares. ¿Cuál es el manejo de elección en este caso?

- A. Tratar con antibióticos y programar colelap diferida después de 6 semanas en todos los casos
- B. Realizar colecistostomía percutánea inmediata en todos los pacientes con colecistitis aguda
- C. Iniciar antibióticos y realizar colelap temprana (dentro de las primeras 72 horas)
- D. Indicar solo antibióticos intravenosos por 7-10 días y reevaluar según evolución

CLAVE: C

En colecistitis aguda no complicada (Tokyo Grade I) en paciente joven sin comorbilidades, el manejo de elección es la colecistectomía laparoscópica temprana, idealmente dentro de las primeras 72 horas del inicio del cuadro, asociada a antibioticoterapia perioperatoria. La evidencia muestra que la cirugía temprana reduce la estancia hospitalaria, las complicaciones y la tasa de conversión a cirugía abierta, sin aumentar el riesgo respecto a la cirugía diferida. La paciente cumple criterios: estabilidad hemodinámica, no comorbilidades, ecografía sin dilatación de vía biliar ni colecciones. Diferir la colecistectomía 6 semanas con antibióticos no es la conducta actual de elección porque expone a recurrencia, complicaciones interim (perforación, gangrena) y retraso innecesario en la resolución. La colecistostomía percutánea se reserva para pacientes con alto riesgo quirúrgico (ancianos frágiles, comorbilidades severas, sepsis) que no pueden tolerar cirugía, no es indicación universal. Solo antibióticos por 7-10 días sin cirugía perpetúa la enfermedad litiasica y la posibilidad de recurrencia. Colecistectomía laparoscópica temprana (<72h) es el estándar contemporáneo en colecistitis aguda no complicada.

PREGUNTA 63

Varón de 55 años, fumador crónico, acude para una Rx de tórax como parte de un chequeo de salud. En la radiografía postero anterior y lateral se observa una dilatación fusiforme de la aorta torácica descendente, proyectada por delante de los cuerpos vertebrales, sin compromiso del corazón ni de la tráquea. Con base en la localización anatómica del hallazgo, ¿cuál de las siguientes estructuras es más probable que se encuentre en el mismo compartimiento mediastínico que la arteria afectada?

- A. Vena cava superior
- B. Esófago torácico
- C. Nervio frénico derecho
- D. Tronco pulmonar

CLAVE: B

La aorta torácica descendente se ubica en el mediastino posterior, compartimiento delimitado anteriormente por el pericardio, posteriormente por los cuerpos vertebrales (T5-T12), e inferiormente por el diafragma. Las estructuras propias del mediastino posterior son la aorta torácica descendente, el esófago torácico, la vena ácigos y la hemiaácigos, los conductos torácicos, el sistema nervioso simpático torácico y los nervios espláncnicos. Por lo tanto, el esófago torácico es la estructura que comparte compartimiento con la aorta descendente. La vena cava superior se ubica en el mediastino superior y medio, junto con el corazón y la aorta ascendente, no en el posterior. El nervio frénico derecho recorre el mediastino medio, descendiendo lateral al pericardio y al hilio pulmonar, sin entrar al posterior. El tronco pulmonar emerge del ventrículo derecho y se ubica en el mediastino medio, también separado del posterior. Diferenciar los compartimientos mediastínicos (anterior, medio, posterior, superior) es competencia básica para interpretar imágenes y localizar lesiones torácicas.

PREGUNTA 64

Escolar de 7 años es llevado a consulta por prurito anal intenso, más en las noches. La madre refiere que en dos ocasiones ha observado pequeños gusanos blancos, móviles, en la región perianal y en las heces del niño. ¿Cuál es el parásito causante más probable de este cuadro?

- A. Enterobius vermicularis
- B. Trichuris trichiura
- C. Ascaris lumbricoides
- D. Giardia lamblia

CLAVE: A

Aquí lo decisivo es enterobiasis (oxiuriasis) por *Enterobius vermicularis*, parasitosis intestinal más frecuente en escolares peruanos. La hembra adulta migra durante la noche desde el ciego al margen anal para depositar sus huevos en la piel perianal, generando prurito nocturno intenso y la observación característica de pequeños gusanos blancos móviles de aproximadamente 1 cm de longitud en heces o región perianal. El diagnóstico se confirma con la prueba de la cinta adhesiva (test de Graham) tomada en la mañana antes del baño, y el tratamiento de elección es albendazol o mebendazol con dosis de refuerzo a las 2 semanas. *Trichuris trichiura* produce diarrea crónica con prolapso rectal en infestaciones masivas, sin prurito anal nocturno como síntoma cardinal y los huevos se ven solo al microscopio en heces. *Ascaris lumbricoides* es un nematodo grande de 15-25 cm que se elimina entero en heces o por boca/nariz, no migra al ano, y causa síntomas digestivos altos o pulmonares por su ciclo migratorio. *Giardia lamblia* es un protozoo flagelado que produce diarrea con esteatorrea y dolor abdominal, sin gusanos visibles ni prurito anal. Prurito anal nocturno + gusanos blancos pequeños móviles = *Enterobius* hasta confirmar.

PREGUNTA 65

Varón de 28 años, desde hace 2 semanas fiebre, odinofagia y linfadenopatías cervicales dolorosas. Hace 4 semanas tuvo relación sexual vaginal sin condón con una pareja ocasional. Se solicita un ensayo inmunoenzimático (EIA) de cuarta generación para VIH, que resulta reactivo, y la posterior prueba de diferenciación de anticuerpos VIH-1/VIH-2 es negativa. ¿Cuál es el siguiente paso más apropiado para confirmar o descartar infección aguda por VIH en este paciente?

- A. Repetir el ensayo inmunoenzimático de cuarta generación en 3 meses
- B. Realizar una prueba de ácido nucleico (NAT) para RNA de VIH-1
- C. Realizar una serología para virus de Epstein-Barr (VEB)
- D. Solicitar un Western blot para VIH-1

CLAVE: B

Cuando el EIA de cuarta generación es reactivo (detecta antígeno p24 y anticuerpos) pero la prueba de diferenciación VIH-1/VIH-2 (segundo paso del algoritmo CDC) resulta negativa, el escenario más probable es infección aguda por VIH-1 con seroconversión incipiente: el antígeno p24 ya está presente pero los anticuerpos aún no son detectables por la prueba de diferenciación. La conducta correcta es realizar una prueba de ácido nucleico (NAT) para detectar RNA de VIH-1, que confirma o descarta infección aguda con alta sensibilidad antes de la seroconversión completa. Repetir el EIA en 3 meses retrasa el

diagnóstico y deja al paciente sin manejo durante un período de alta replicación viral y máxima transmisibilidad. La serología para virus de Epstein-Barr puede ser un diagnóstico diferencial razonable en mononucleosis-like, pero no aclara el resultado discordante de las pruebas VIH y debe ir en paralelo, no en lugar de la NAT. El Western blot fue reemplazado en el algoritmo CDC vigente desde 2014 por la prueba de diferenciación VIH-1/VIH-2 y la NAT, ya que tenía menor sensibilidad para infección aguda. NAT para RNA de VIH-1 es el paso obligatorio en el algoritmo actual.

PREGUNTA 66

Varón de 48 años con diabetes mellitus tipo 2 de 15 años de evolución, con controles irregulares, acude por varias semanas de fatiga, náuseas y prurito generalizado. Examen: pálido, piel reseca y leve edema en miembros inferiores. Laboratorio: creatinina sérica 5,8 mg/dL (hace un año 1,2 mg/dL), urea 160 mg/dL, Hb 9,0 g/dL, cociente albúmina/creatinina en orina 500 mg/g. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y qué hallazgo oftalmológico relacionado con su enfermedad de base es razonable buscar en la evaluación de este paciente?

- A. Injuria renal aguda pre-renal por deshidratación; retinopatía hipertensiva
- B. Nefritis intersticial crónica inducida por fármacos; catarata senil
- C. Injuria renal aguda intrínseca por necrosis tubular aguda; glaucoma crónico
- D. Enfermedad renal crónica por nefropatía diabética; retinopatía diabética

CLAVE: D

El paciente cursa con enfermedad renal crónica avanzada (creatinina 5,8 con TFG estimada en rango de ERC G4-G5) en el contexto de diabetes mellitus tipo 2 de larga data y mal controlada, con albuminuria de 500 mg/g (rango A3) y datos clásicos urémicos como fatiga, náuseas, prurito y palidez por anemia normocítica de origen renal. La nefropatía diabética es la causa más frecuente de ERC en el Perú y se acompaña en la gran mayoría de casos de retinopatía diabética concomitante, ya que ambas comparten mecanismos microvasculares (glicación avanzada, estrés oxidativo, daño endotelial). La injuria renal aguda pre-renal por deshidratación produce ascenso brusco de creatinina con FENa baja y se revierte con reposición de volumen, no encaja con el patrón crónico y la albuminuria documentada. La nefritis intersticial crónica por fármacos cursa con piuria estéril y antecedente de nefrotóxicos, y la catarata senil no se relaciona específicamente con su patología renal. La necrosis tubular aguda con glaucoma crónico no integra fisiopatológicamente. La regla nemotécnica clásica del

ENAM para DM2 es: nefropatía diabética viaja siempre acompañada de retinopatía diabética porque comparten la misma microangiopatía.

PREGUNTA 67

Mujer de 55 años, acude por dolor en articulaciones de manos y rodillas que empeora con la actividad y mejora con el reposo. Examen: nódulos interfalángicos en 2do y 5to dedo de ambas manos. Rx de manos: disminución del espacio articular con esclerosis subcondral y pequeños osteofitos marginales. VSG normal. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A. Artritis reactiva
- B. Osteoartritis
- C. Artritis psoriásica
- D. Artritis reumatoide

CLAVE: B

El detalle que define el caso: osteoartritis (artrosis) de manos y rodillas, patrón degenerativo articular típico de mujeres entre 50 y 60 años. Las características clave son: dolor mecánico que empeora con la actividad y mejora con el reposo, ausencia de signos inflamatorios sistémicos (VSG normal, sin rigidez matinal prolongada), nódulos interfalángicos compatibles con nódulos de Heberden (interfalángicas distales) y Bouchard (interfalángicas proximales), y hallazgos radiológicos clásicos de disminución del espacio articular, esclerosis subcondral y osteofitos marginales (la triada radiológica de OA). La artritis reactiva cursa con monoartritis u oligoartritis asimétrica posterior a infección genitourinaria o entérica, con conjuntivitis y entesitis frecuentes, no patrón poliarticular degenerativo. La artritis psoriásica afecta interfalángicas distales con dactilitis (dedo en salchicha) y compromiso ungueal, asociada a psoriasis cutánea. La artritis reumatoide cursa con poliartitis simétrica con rigidez matinal mayor de una hora, compromiso de pequeñas articulaciones (MCF, IFP) con respeto de IFD, y elevación de reactantes de fase aguda (VSG, PCR), patrón opuesto al descrito. Dolor mecánico + nódulos + osteofitos = artrosis.

PREGUNTA 68

Puérpera de 72 horas de parto eutócico, quien durante el trabajo de parto presentó PA 140/90 mmHg en dos tomas separadas por 4 horas. Examen: PA 130/80 mmHg, FC 78 x', sin cefalea, ni epigastralgia, ni escotomas. Abdomen: útero contraído. Tacto vaginal: sin hematomas en pared vaginal, loquios escasos. Proteinuria en orina de 24 horas: 150 mg. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Hipertensión gestacional
- B. Preeclampsia moderada
- C. Hipertensión crónica
- D. Preeclampsia sin criterios de severidad

CLAVE: A

En clase lo dijimos claro: hipertensión gestacional, definida como aumento de la presión arterial mayor o igual a 140/90 mmHg en dos tomas separadas por al menos 4 horas, después de las 20 semanas de gestación, en una mujer previamente normotensa, sin proteinuria significativa (menor de 300 mg en 24 horas, en este caso 150 mg) y sin signos de daño orgánico. La paciente cumple los criterios de PA elevada durante el trabajo de parto y aún en el puerperio inmediato, sin criterios para preeclampsia ni hipertensión crónica. La preeclampsia requiere proteinuria mayor de 300 mg/24h o criterios de daño orgánico (creatinina elevada, plaquetopenia, transaminasas, edema pulmonar, síntomas neurológicos), ninguno presente aquí. La hipertensión crónica se diagnostica cuando la HTA precede al embarazo o aparece antes de las 20 semanas, situación que no se describe en este caso. La preeclampsia sin criterios de severidad sigue siendo preeclampsia y exige proteinuria positiva, ausente. La hipertensión gestacional es importante porque hasta el 25% evoluciona a preeclampsia y requiere seguimiento, aunque el pronóstico es generalmente más favorable cuando aparece tardíamente y sin proteinuria.

PREGUNTA 69

Un nuevo fármaco para el tratamiento de hipertensión ha mostrado un perfil de seguridad aceptable en voluntarios sanos y datos preliminares de eficacia en pequeños grupos de pacientes. Actualmente se está realizando un ensayo clínico en varios hospitales, que incluye a cientos de pacientes hipertensos, comparando el nuevo fármaco contra el tratamiento estándar, con el objetivo principal de confirmar su eficacia clínica y seguir evaluando su seguridad. ¿A qué fase de desarrollo clínico corresponde este ensayo?

- A. II
- B. IV
- C. I
- D. III

CLAVE: D

El ensayo descrito corresponde a fase III: estudio multicéntrico, en cientos a miles de pacientes con la enfermedad de interés, diseñado para comparar el nuevo fármaco contra el tratamiento estándar (no contra placebo necesariamente) y confirmar la eficacia clínica establecida en estudios anteriores, evaluando y además seguridad a mayor escala. Las fases III suelen aleatorizar, son multicéntricas y proporcionan la evidencia regulatoria fundamental para la aprobación por agencias como la FDA, EMA o DIGEMID antes de la comercialización masiva. La fase I se realiza en voluntarios sanos en pequeño número (20 a 80) y evalúa farmacocinética, farmacodinamia y seguridad, no eficacia. La fase II se desarrolla en pacientes con la enfermedad pero en pequeños grupos (100 a 300) para establecer dosis óptima y eficacia preliminar, no para confirmar eficacia ni comparar con estándar. La fase IV es postmercado, ocurre tras la aprobación, y monitoriza efectos adversos raros y eficacia en condiciones reales, no en ensayo controlado para registro. Cientos de pacientes + comparación con estándar + objetivo de confirmar eficacia = fase III.

PREGUNTA 70

Adolescente de 13 años con anemia de células falciformes, desde hace 24 horas dolor intenso en extremidades y espalda tras actividad física intensa. Refiere astenia. Examen: palidez, escleras ictéricas, taquicardia, dolor a la palpación de huesos largos, no tolera la movilización, resto normal. Laboratorio: Hb 8 g/dL, reticulocitos 5%, bilirrubina total 4 mg/dL, indirecta 3 mg/dL, leucocitos normales. ¿Cuál es el evento fisiopatológico predominante que explica este cuadro clínico agudo?

- A. Crisis aplásica por supresión transitoria de la eritropoyesis
- B. Síndrome hemofagocítico por activación inmune
- C. Rabdomiólisis secundaria a esfuerzo físico intenso
- D. Crisis vasooclusiva por obstrucción microvascular

CLAVE: D

El cuadro clínico agudo en un paciente con anemia de células falciformes que presenta dolor intenso en huesos largos y espalda tras esfuerzo físico, sin signos de infección sistémica, corresponde a crisis vasooclusiva, evento fisiopatológico predominante en esta enfermedad. La hemoglobina S polimerizada deforma los eritrocitos en condiciones de hipoxia, deshidratación o estrés oxidativo, generando obstrucción microvascular en lechos capilares óseos, esplénicos, pulmonares o cerebrales, con isquemia tisular y dolor severo. Los reticulocitos ligeramente elevados (5%) y la bilirrubina indirecta aumentada reflejan la hemólisis crónica de fondo, no una crisis aplásica. La crisis aplásica por

parvovirus B19 produce caída de hemoglobina con reticulocitos prácticamente nulos (menores del 1%), no 5% como aquí, y suele tener antecedente infeccioso febril. El síndrome hemofagocítico cursa con fiebre alta, citopenias en al menos dos líneas, hiperferritinemia y hepatoesplenomegalia, ninguno predominante en el caso. La rabdomiólisis post-esfuerzo elevaría la CK marcadamente y produciría hiperpotasemia y mioglobinuria, sin la combinación específica de dolor óseo, ictericia y reticulocitosis sostenida. Crisis vasooclusiva es la respuesta y su manejo es hidratación EV, analgesia opiode y oxigenación.

PREGUNTA 71

Varón de 74 años, hipertenso desde hace 20 años, con mal control de la presión arterial. Desde hace 2 años presenta olvidos frecuentes, enlentecimiento psicomotor y dificultad progresiva para caminar, hablar y deglutir, configurando un síndrome pseudobulbar. Obtiene 5 puntos en la escala de Hachinski, lo que orienta a demencia vascular. ¿Cuál de los siguientes hallazgos en la tomografía computarizada (TC) de cerebro es más característico de este cuadro?

- A. Hematoma intraparenquimatoso hiperdenso lobar único en hemisferio cerebral
- B. Atrofia cortical temporal y parietal difusa sin lesiones en sustancia blanca profunda
- C. Ventriculomegalia con borramiento de surcos corticales y sin lesiones isquémicas
- D. Múltiples microinfartos lacunares en la sustancia blanca periventricular y ganglios basales

CLAVE: D

La demencia vascular subcortical (también llamada de pequeños vasos o enfermedad de Binswanger) es la forma más frecuente de demencia vascular en adultos mayores con HTA mal controlada. Los hallazgos imagenológicos característicos son múltiples microinfartos lacunares en la sustancia blanca periventricular y los ganglios basales, junto con leucoaraiosis (hipodensidad de la sustancia blanca subcortical). Estos hallazgos explican el deterioro cognitivo escalonado, el síndrome pseudobulbar y los signos motores subcorticales descritos en el paciente. El hematoma intraparenquimatoso hiperdenso único corresponde a hemorragia cerebral aguda, no a demencia vascular crónica, y produce déficit focal súbito, no demencia progresiva. La atrofia cortical temporo-parietal difusa sin lesiones en sustancia blanca es el patrón característico de la enfermedad de Alzheimer, no de demencia vascular. La ventriculomegalia con borramiento de surcos sin lesiones isquémicas sugiere hidrocefalia normotensiva (con triada de Hakim: marcha, demencia, incontinencia),

entidad distinta. Los microinfartos lacunares y la leucoaraiosis son la firma imagenológica de la demencia vascular subcortical.

PREGUNTA 72

Secundigesta de 34 semanas, acude por dolor abdominal súbito, intenso y continuo, acompañado de escaso sangrado vaginal oscuro. Antecedente de cesárea anterior. Examen: FC 120 x', PA 170/100 mmHg, Abdomen: útero hipertónico y doloroso a la palpación. FCF 160 x' con variabilidad mínima y desaceleraciones tardías. Laboratorio: Hb 7, 5 g/dL, plaquetas 110, 000/mm³ y fibrinógeno 250 mg/dL. ¿Cuál es la conducta a seguir?

- A. Sulfato de magnesio como tocolítico
- B. Cesárea de emergencia
- C. Inducción de labor de parto con oxitocina
- D. Manejo expectante

CLAVE: B

Como vimos en clase Villamedic, esto es desprendimiento prematuro de placenta normoinsera (DPPNI) severo en gestante con HTA. Los criterios diagnósticos están todos presentes: dolor abdominal súbito intenso y continuo, sangrado vaginal oscuro escaso (porque el sangrado se acumula retroplacentario), útero hipertónico y doloroso, signos de pérdida de bienestar fetal (variabilidad mínima y desaceleraciones tardías), anemia aguda (Hb 7, 5) y consumo de factores con plaquetopenia y fibrinógeno descendente como marcadores de coagulopatía de consumo. La conducta es cesárea de emergencia para salvar al feto y controlar la hemorragia materna. El sulfato de magnesio como tocolítico está contraindicado en DPP porque la prioridad es terminar la gestación, no prolongarla; y además expone a hipotensión materna en una paciente ya comprometida. La inducción del trabajo de parto con oxitocina puede considerarse en DPP leves con feto muerto y madre estable, no en DPP severo con feto vivo y signos de sufrimiento. El manejo expectante es peligroso: cada minuto que pasa progresa la coagulopatía, la hipoxia fetal y el riesgo de muerte materna por choque hemorrágico. La cesárea de emergencia con preparación de hemoderivados es la única conducta correcta.

PREGUNTA 73

Mujer de 22 años, de zona urbana con brote reciente de dengue, presenta fiebre de 5 días de evolución que mejoró parcialmente con paracetamol. En las últimas 24 horas

añade intenso cansancio, disnea y cefalea muy intensa. Examen: PA 80/40 mmHg, FC 115 x', FR 28 x', matidez y disminución del murmullo vesicular en ambas bases pulmonares, y múltiples petequias en tórax. Se sospecha dengue grave en fase crítica con choque hipovolémico por fuga capilar. ¿Cuál es la medida inicial más importante en el manejo de esta paciente?

- A. Infusión rápida de solución salina 0,9% en bolo
- B. Inicio de dopamina en infusión continua a baja dosis
- C. Transfusión de 5 unidades de concentrado de plaquetas
- D. Infusión de dextrosa al 5% en agua como solución de mantenimiento

CLAVE: A

El dengue grave en fase crítica con choque hipovolémico por fuga capilar requiere reposición agresiva con cristaloides isotónicos (solución salina 0,9% o lactato de Ringer) en bolo de 10 a 20 mL/kg en 15 a 30 minutos, evaluando respuesta clínica y signos de mejoría hemodinámica. La fisiopatología central del dengue grave es la fuga capilar plasmática a partir del día 4-5 de la enfermedad, generando hemoconcentración, hipotensión y derrames serosos (pleural, ascítico). La reposición rápida con cristaloides es la maniobra que cambia el desenlace y debe ser inmediata. La dopamina en infusión continua a baja dosis es un vasopresor que solo se considera tras una reposición adecuada de volumen sin respuesta, no como medida inicial; usarla antes de reponer fluidos perpetúa la hipovolemia. La transfusión de plaquetas profiláctica no está indicada en dengue grave a menos que haya sangrado activo significativo o plaquetopenia menor de 10,000, pues la trombocitopenia per se no requiere corrección. La dextrosa 5% no es solución de reanimación adecuada porque rápidamente sale del compartimento intravascular y no expande volumen efectivo. Cristaloides isotónicos en bolo aquí no hay vuelta.

PREGUNTA 74

Lactante de 4 meses, alimentado exclusivamente con leche materna con intervalos prolongados entre tomas, es llevado al servicio de urgencias por vómitos de 24 horas de evolución. La madre refiere que el niño ha estado durmiendo algo más, mucosas secas y signos de deshidratación. Signo de pliegue cutáneo positivo. Laboratorio: sodio sérico de 162 mEq/L, cloro ligeramente elevado y glucosa en rangos normales. ¿Cuál es la causa más probable de la hipernatremia en este paciente?

- A. Hiperaldosteronismo primario
- B. Lactancia materna ineficaz

C. Diabetes insípida nefrogénica

D. Diabetes insípida central

CLAVE: B

Esto lo trabajamos en clase y vuelve: hipernatremia por deshidratación hipertónica secundaria a lactancia materna ineficaz, situación más frecuente en las primeras semanas de vida pero que también se observa en lactantes con tomas espaciadas, succión débil o producción láctea materna insuficiente. El mecanismo central es la pérdida de agua libre superior a la pérdida de electrolitos, con concentración del sodio sérico hasta valores como los 162 mEq/L descritos. El cuadro clínico incluye somnolencia, pérdida de peso, mucosas secas, pliegue cutáneo positivo y vómitos por la propia hipernatremia. El hiperaldosteronismo primario es excepcional en lactantes y produciría y además hipopotasemia e hipertensión, no encaja con el escenario. La diabetes insípida nefrogénica y central producirían poliuria con orina diluida, no descrita aquí, y suelen tener antecedente familiar o etiología subyacente clara (litio, hipercalcemia, lesiones hipofisarias). En un lactante alimentado solo con leche materna y con intervalos prolongados entre tomas, la causa estadísticamente más probable y clínicamente coherente es lactancia ineficaz. El manejo requiere corrección lenta del sodio para evitar edema cerebral por descenso rápido y soporte nutricional inmediato.

PREGUNTA 75

Varón de 58 años, con antecedente de infección por *Helicobacter pylori* tratada hace 5 años. No presenta síntomas actuales, acude para control endoscópico. La endoscopia muestra mucosa atrófica en antro y cuerpo, por lo que se toman biopsias múltiples. Informe histopatológico: antro con gastritis crónica atrófica leve con metaplasia intestinal completa focal; cuerpo con gastritis crónica atrófica moderada con focos de metaplasia intestinal incompleta; curvatura menor distal con área de displasia epitelial gástrica de bajo grado. ¿Cuál hallazgo obliga a una vigilancia endoscópica más estrecha?

A. Metaplasia intestinal completa focal en antro

B. Displasia epitelial gástrica de bajo grado en curvatura menor distal

C. Metaplasia intestinal incompleta en cuerpo gástrico

D. Gastritis crónica atrófica leve en antro

CLAVE: B

En la cascada de Correa para carcinogénesis gástrica, la jerarquía de riesgo según las guías MAPS II 2019 y BSG 2019 es clara: gastritis crónica atrófica < metaplasia intestinal

completa < metaplasia intestinal incompleta < displasia de bajo grado < displasia de alto grado < adenocarcinoma. La displasia epitelial gástrica de bajo grado, aun cuando sea focal, representa una lesión preneoplásica con riesgo significativo de progresión y obliga a vigilancia endoscópica más estrecha (cada 6-12 meses con biopsias dirigidas y mapeo gástrico) y a confirmación por segundo patólogo experto, dado el riesgo de subdiagnóstico de displasia de alto grado o adenocarcinoma intramucoso. La metaplasia intestinal completa focal en antro tiene riesgo bajo y vigilancia espaciada (3 años). Ojo: la metaplasia intestinal incompleta en cuerpo gástrico sí eleva el riesgo respecto a la completa, pero queda por debajo de la displasia en jerarquía: las guías recomiendan vigilancia cada 3 años para metaplasia incompleta extensa, mientras que la displasia de bajo grado exige vigilancia a 6-12 meses con confirmación histopatológica. La gastritis crónica atrófica leve sin metaplasia ni displasia no requiere vigilancia intensiva. La displasia (cualquier grado) supera a la metaplasia en la cascada y obliga al control más estrecho del banco completo de hallazgos descritos.

PREGUNTA 76

Niña de 10 años, residente en zona endémica de dengue en la selva, acude al centro de salud por fiebre de 3 días y cefalea intensa. Existen múltiples casos similares en su localidad en las últimas semanas. El equipo de salud organiza una intervención comunitaria. ¿Cuál es la medida prioritaria para reducir la incidencia de dengue?

- A. Indicar profilaxis antibiótica en contactos cercanos
- B. Eliminar criaderos de *Aedes Aegypti* con control vectorial
- C. Vacunar a toda la población pediátrica contra el dengue
- D. Aislamiento domiciliario hasta la resolución de la fiebre

CLAVE: B

En zonas endémicas de dengue, la medida con mayor impacto sobre la incidencia comunitaria es el control vectorial dirigido a eliminar criaderos de *Aedes aegypti*, ya que actúa sobre el eslabón vector de la cadena epidemiológica. Las acciones incluyen eliminación de recipientes con agua estancada, uso de larvicidas, fumigación adulticida focal cuando hay brote y educación comunitaria sobre tapado y limpieza de tanques y bidones. Esta estrategia es la primera línea de respuesta del MINSA ante brote y la más costo-efectiva en zonas endémicas peruanas. La profilaxis antibiótica en contactos cercanos no aplica al dengue, que es viral y no se transmite persona a persona. La vacunación contra el dengue (Dengvaxia, Qdenga) tiene indicaciones específicas según serostatus previo y no es la medida inmediata frente a un brote, y además de no estar

implementada masivamente en el Perú. El aislamiento domiciliario hasta la resolución de la fiebre puede reducir transmisión local a mosquitos virémicos, pero su efecto poblacional es limitado en comparación con el control vectorial sistemático. Eliminar criaderos rompe la cadena en el eslabón modificable.

PREGUNTA 77

Puérpera mediata de 5 días de parto vaginal instrumentado, acude por fiebre y dolor abdominal. Examen: PA 100/60 mmHg, FC 98 x', T 38.5 °C. Génito urinario: útero a nivel de la cicatriz umbilical, doloroso a la palpación, loquios con mal olor y dolor a la palpación bimanual. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- A. Vancomicina más metronidazol
- B. Clindamicina más gentamicina
- C. Ciprofloxacina más nitrofurantoína
- D. Doxiciclina más metronidazol

CLAVE: B

Esto cae todos los años y lo repetimos: endometritis puerperal, infección polimicrobiana frecuente en parto instrumentado y con factores de riesgo como RPM prolongada, múltiples tactos vaginales o cesárea. El tratamiento empírico estándar y de mayor evidencia es la combinación de clindamicina más gentamicina endovenosas, esquema que cubre el espectro habitual de patógenos: estreptococos, estafilococos, anaerobios (*Bacteroides*, *Prevotella*) y bacilos gramnegativos entéricos (*E. coli*). Esta dupla mantiene tasas de curación del 90-97% y es el régimen recomendado en guías nacionales y de la ACOG. Vancomicina más metronidazol no cubre adecuadamente bacilos gramnegativos entéricos, que son frecuentes en endometritis puerperal. Ciprofloxacina más nitrofurantoína es esquema para infección urinaria, no para endometritis: la nitrofurantoína no alcanza concentraciones tisulares útiles fuera de orina. Doxiciclina más metronidazol se usa en enfermedad pélvica inflamatoria por ITS pero no es de elección en endometritis puerperal donde la flora es polimicrobiana ascendente, no por *chlamydia* o *gonococo*. Clindamicina + gentamicina es la combinación de oro y debe iniciarse de inmediato tras toma de cultivos.

PREGUNTA 78

Mujer de 24 años, hace cuatro semanas presentó infección respiratoria, se automedicó con cefuroxima y antiinflamatorio no esteroideo durante cinco días. Dos semanas después fiebre y erupción cutánea maculopapular eritematosa generalizada,

acompañadas de malestar y disminución del volumen urinario. Examen: erupción cutánea difusa y edema leve en MMII. Laboratorio: hemograma con eosinofilia; creatinina sérica 3, 8 mg/dL; examen de orina con hematuria microscópica y proteinuria de 1 g/24 h; sedimento urinario con leucocituria, eosinófilos y ausencia de cilindros hemáticos. Complemento sérico C3 y C4 en rangos normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Vasculitis leucocitoclástica cutánea
- B. Granulomatosis eosinofílica con poliangeítis
- C. Granulomatosis con poliangeítis
- D. Nefritis intersticial aguda inducida por fármacos

CLAVE: D

El cuadro reúne nefritis intersticial aguda inducida por fármacos, reacción inmunoalérgica clásicamente asociada a betalactámicos (cefuroxima) y AINEs, que son los dos grupos farmacológicos responsables más frecuentes. La triada diagnóstica clásica de Galpin (presente en menos del 30% pero altamente específica cuando coexiste) es fiebre, erupción cutánea y eosinofilia, todos presentes en esta paciente. Además, los hallazgos urinarios típicos son leucocituria con eosinófilos urinarios (sello del proceso), hematuria microscópica y proteinuria moderada (1 g/24h, no en rango nefrótico), con creatinina elevada y complemento normal. La vasculitis leucocitoclástica cutánea produce púrpura palpable en miembros inferiores como hallazgo cutáneo predominante, no exantema maculopapular generalizado, y la afectación renal es menos frecuente. La granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (Churg-Strauss) cursa con asma, eosinofilia marcada, neuropatía y vasculitis sistémica, no aplica aquí donde no hay asma ni neuropatía. La granulomatosis con poliangeítis (Wegener) afecta vías respiratorias altas y bajas con compromiso renal por GN rápidamente progresiva, ANCA-positiva, sin la temporalidad farmacológica clara de la NIA. Eosinofilia + erupción + AKI + leucocituria con eosinófilos urinarios = NIA por fármacos.

PREGUNTA 79

En un hospital de referencia, se reporta un aumento de casos de disfonía persistente posterior a tiroidectomía total, con parálisis unilateral de pliegue vocal verdadero. El comité de calidad identifica como causa probable la lesión de un nervio durante la disección quirúrgica del cuello. Desde el punto de vista anatómico y funcional, ¿cuál de los siguientes nervios explica mejor la parálisis del pliegue vocal verdadero?

- A. Laríngeo superior (rama externa)

- B. Laríngeo recurrente
- C. Glossofaríngeo (IX)
- D. Tronco Simpático cervical

CLAVE: B

El nervio laríngeo recurrente, rama del vago (X), inerva todos los músculos intrínsecos de la laringe excepto el cricotiroides. Su lesión durante la tiroidectomía produce parálisis del pliegue vocal verdadero ipsilateral con disfonía persistente, voz bitonal o, si es bilateral, compromiso de la vía aérea con estridor. El nervio recorre el surco traqueoesofágico y mantiene relación íntima con la cápsula tiroidea posterior y la arteria tiroidea inferior, por lo que es el más vulnerable en la cirugía tiroidea, sobre todo en tiroidectomías totales por bocio multinodular o cáncer. La rama externa del laríngeo superior inerva al músculo cricotiroides, su lesión produce dificultad para los tonos altos y voz monótona pero no parálisis del pliegue vocal verdadero. El nervio glossofaríngeo (IX) inerva la musculatura faríngea, la mucosa orofaríngea y la base de la lengua, sin relación con la motricidad del pliegue vocal verdadero. El tronco simpático cervical contribuye con fibras autonómicas a estructuras cervicales pero no inerva los músculos intrínsecos laríngeos. Disfonía + parálisis de cuerda vocal posterior a tiroidectomía = lesión del nervio laríngeo recurrente.

PREGUNTA 80

Varón de 35 años se somete a la extracción quirúrgica de un tercer molar inferior incluido. Días después, refiere pérdida de la sensibilidad al tacto, dolor y temperatura en los dos tercios anteriores de la lengua del mismo lado, conserva la percepción del sabor en esa zona. Considerando la neuroanatomía de la lengua. ¿Qué nervio probablemente sea el lesionado?

- A. Nervio lingual (rama del nervio mandibular, V3)
- B. Nervio glossofaríngeo (IX)
- C. Cuerda del tímpano (rama del nervio facial, VII)
- D. Nervio hipogloso (XII)

CLAVE: A

El nervio lingual, rama del nervio mandibular (V3), proporciona la sensibilidad general (tacto, dolor, temperatura) de los dos tercios anteriores de la lengua, mientras que la sensibilidad gustativa de esa misma región es transportada por la cuerda del tímpano (rama del facial VII), que viaja unida al nervio lingual pero es funcionalmente independiente. La extracción del tercer molar inferior (M3 incluido) puede dañar el nervio lingual por su trayecto cercano a la cara lingual del alvéolo, generando hipoestesia táctil

y térmica con preservación del gusto, escenario que encaja exactamente con este caso. El nervio glosofaríngeo (IX) inerva el tercio posterior de la lengua tanto en sensibilidad general como en gusto, no aplica al territorio anterior afectado. La cuerda del tímpano (rama del VII) lleva el gusto de los dos tercios anteriores: si esta hubiera sido la lesionada, se perdería el sabor pero no la sensibilidad táctil; aquí ocurre lo opuesto, lo cual descarta. El nervio hipogloso (XII) es motor puro y produce parálisis de la motilidad lingual con desviación al lado lesionado, no compromete la sensibilidad. Sensibilidad general perdida + gusto conservado en 2/3 anteriores = nervio lingual.

PREGUNTA 81

Agricultor de 52 años, con antecedente de fiebre reumática en la adolescencia y sin controles médicos regulares, consulta por disnea de esfuerzo progresiva y ortopnea. Examen: PA 150/50 mmHg, pulsos periféricos amplios, balanceo de la cabeza y pulso capilar visible en el lecho ungueal. Soplo diastólico, aspirativo, en decrescendo, mejor en el borde esternal izquierdo, con el paciente inclinado hacia adelante en espiración. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Miocardiopatía dilatada idiopática con insuficiencia cardíaca avanzada
- B. Estenosis aórtica calcificada de probable etiología degenerativa
- C. Insuficiencia aórtica crónica grave de probable etiología reumática
- D. Insuficiencia mitral crónica de probable etiología reumática

CLAVE: C

El detalle que define el caso: los signos clásicos de insuficiencia aórtica crónica grave: presión arterial divergente (150/50 con presión diferencial amplia de 100), pulsos periféricos amplios o saltones (Corrigan), balanceo de la cabeza con cada latido (signo de Musset), pulso capilar visible en lecho ungueal (signo de Quincke), y soplo diastólico aspirativo en decrescendo en borde esternal izquierdo, mejor audible con el paciente inclinado hacia adelante en espiración. El antecedente de fiebre reumática en la adolescencia hace que la etiología más probable sea la cardiopatía reumática crónica, frecuente en agricultores de zonas con bajo acceso a antibióticos por faringitis estreptocócica. La miocardiopatía dilatada idiopática produce insuficiencia cardíaca con cardiomegalia y disminución de la FEVI, pero no genera presión diferencial amplia ni soplo diastólico característico de insuficiencia aórtica. La estenosis aórtica calcificada produce soplo sistólico eyectivo en foco aórtico irradiado a carótidas, con presión diferencial estrechada (no amplia) y pulso parvus et tardus, lo opuesto al caso. La insuficiencia mitral crónica genera soplo holosistólico en ápex irradiado a axila, sin los

signos periféricos de pulso amplio descritos. Soplo diastólico aspirativo + Corrigan + Musset + Quincke = insuficiencia aórtica crónica.

PREGUNTA 82

Varón de 70 años con hernia inguinal estrangulada e irreductible es llevado a cirugía de urgencia por dolor abdominal difuso, fiebre y leucocitosis. Durante la intervención se expone el asa intestinal herniada. ¿Qué hallazgo intraoperatorio indica de manera más contundente la necesidad de resecar el segmento intestinal afectado?

- A. Presencia de líquido serohemático escaso en el saco herniario con saco eritematoso
- B. Edema marcado de la pared intestinal con coloración violácea que mejora al liberar el anillo herniario
- C. Coloración negruzca del asa con ausencia de pulso en los vasos mesentéricos adyacentes
- D. Ausencia inicial de peristaltismo con recuperación del color rosado tras la aplicación de compresas tibias

CLAVE: C

La decisión intraoperatoria de resecar un segmento intestinal en una hernia estrangulada se basa en signos de inviabilidad confirmada: coloración negruzca persistente del asa (necrosis transmural), ausencia de pulso arterial en los vasos mesentéricos del meso correspondiente y ausencia de peristaltismo o brillo seroso pese a las maniobras de calentamiento. Estos tres criterios juntos indican necrosis irreversible y obligan a resección del segmento con anastomosis primaria si las condiciones lo permiten o derivación enteral si el paciente está séptico. El líquido serohemático escaso con saco eritematoso es signo de compromiso vascular pero no necesariamente de necrosis irreversible y puede recuperarse al liberar el anillo. Ojo: el edema con coloración violácea que mejora al liberar la constricción significa que el asa es viable y solo requería liberación del compromiso mecánico, no resección. La ausencia inicial de peristaltismo con recuperación del color rosado tras compresas tibias indica que el asa recupera viabilidad y debe conservarse. Solo la coloración negruzca persistente con ausencia de pulso mesentérico es indicación inequívoca de resección.

PREGUNTA 83

En una urgencia oftalmológica, algunas situaciones requieren tratamiento en cuestión de minutos para disminuir el riesgo de pérdida visual permanente. ¿Cuál se considera una verdadera urgencia ocular?

- A. Pterigion nasal que invade levemente la córnea
- B. Golpe contuso en ojo sin alteración de la agudeza visual
- C. Orzuelo en párpado superior de 24 horas de evolución
- D. Quemadura química ocular por producto de limpieza doméstico

CLAVE: D

La quemadura química ocular es la verdadera urgencia oftalmológica que requiere intervención en minutos para evitar pérdida visual permanente. La conducta inmediata es lavado abundante con suero fisiológico o agua durante al menos 15-30 minutos antes de cualquier otra evaluación, midiendo el pH de la conjuntiva hasta normalizar a 7.0-7.4. Las quemaduras por álcali (lejía, amoníaco, productos de limpieza) son más graves que las ácidas porque penetran rápidamente en cámara anterior por necrosis de licuefacción, generando opacidad corneal, cataratas, glaucoma e isquemia limbar irreversible. El pterigion nasal con invasión leve de córnea es proceso crónico, no requiere manejo en minutos y se trata con cirugía electiva si compromete eje visual. El golpe contuso sin alteración de agudeza visual amerita evaluación oftalmológica para descartar contusión ocular, hipema o desprendimiento retinal pero no necesita intervención inmediata en minutos. El orzuelo es infección estafilocócica del borde palpebral, autolimitada o tratada con compresas calientes y antibiótico tópico, sin riesgo de pérdida visual permanente. Quemadura química = lavar de inmediato es la regla de oro oftalmológica.

PREGUNTA 84

Varón de 55 años con artritis reumatoide seropositiva y erosiva de 12 años de evolución, en tratamiento irregular con metotrexato, consulta por progresión de dolor y rigidez cervical desde hace 6 meses. Refiere episodios esporádicos de parestesias en ambas manos al flexionar el cuello, sin debilidad manifiesta. Examen: limitación de la movilidad cervical, sin déficit motor ni sensitivo, reflejos osteotendinosos levemente vivos en las cuatro extremidades. ¿Cuál es el examen auxiliar a indicar?

- A. Radiografía simple de columna lumbar en bipedestación
- B. TC de articulaciones sacroilíacas para descartar espondilitis anquilosante
- C. Resonancia magnética de columna dorsal para descartar espondilodiscitis
- D. Radiografía cervical dinámica (flexión y extensión) para evaluar inestabilidad atlantoaxial

CLAVE: D

En artritis reumatoide de larga data y mal controlada, la subluxación atlantoaxial es complicación neurológica grave (presente en 25-30% de pacientes con AR establecida) por erosión del ligamento transverso del atlas y de la apófisis odontoides, generando inestabilidad de la articulación C1-C2. Los síntomas iniciales son dolor cervical, parestesias al flexionar el cuello (signo de Lhermitte) y reflejos hiperactivos por compresión medular incipiente. El examen de elección es la radiografía cervical dinámica en flexión y extensión, que mide la distancia atlantodental anterior: mayor de 3 mm en adultos confirma inestabilidad y obliga a manejo neurológico-quirúrgico. La radiografía lumbar en bipedestación no aporta para la sintomatología cervical ni para AR, donde el compromiso lumbar es infrecuente. La TC de sacroilíacas se utiliza para sospecha de espondilitis anquilosante (espondiloartritis HLA-B27 con sacroileítis), entidad distinta de AR. La resonancia de columna dorsal busca espondilodiscitis (infección discal), patología poco probable sin fiebre ni síndrome radicular dorsal. La RX cervical dinámica es la herramienta diagnóstica específica y costo-efectiva para detectar subluxación atlantoaxial, complicación esperable en este perfil de paciente.

PREGUNTA 85

En un hospital general, un médico diagnosticó tuberculosis pulmonar bacilífera a un varón de 35 años. El paciente rechaza iniciar tratamiento inmediato y firma un documento dejando constancia de su negativa. Vive en un cuarto pequeño con tres compañeros y continúa asistiendo a reuniones sociales en espacios cerrados. Solicita al médico que mantenga en secreto su diagnóstico y se niega a que se contacte a sus convivientes. El médico sabe que la tuberculosis es una enfermedad de notificación obligatoria. ¿Cuál es la acción ética que debe tomar el médico en este contexto?

- A. Solicitar el alta voluntaria del paciente y derivarlo a un establecimiento privado
- B. Informar inmediatamente a los convivientes del paciente sobre su diagnóstico
- C. Respetar la decisión del paciente y su confidencialidad, limitándose a documentar la negativa
- D. Informar a las autoridades de salud competentes y al equipo de control de tuberculosis

CLAVE: D

En el caso de tuberculosis pulmonar bacilífera, el principio de confidencialidad cede ante el deber de protección de la salud pública porque el paciente se mantiene como fuente activa de transmisión a contactos vulnerables (convivientes en cuarto pequeño, asistencia a reuniones cerradas). La conducta ética y legalmente correcta es informar a

las autoridades de salud competentes (Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis del MINSA) y al equipo de control de TB para que realicen la búsqueda activa de contactos, su tamizaje (BK, Rx tórax, IGRA o PPD) e inicio de quimioprofilaxis cuando corresponda. Solicitar el alta voluntaria y derivar a un establecimiento privado deja al paciente sin tratamiento supervisado y a sus contactos sin protección, y además de transferir la responsabilidad sin resolver el riesgo. Informar a los convivientes sin protocolo es una violación de la confidencialidad que el sistema permite eludir solo a través de la autoridad sanitaria, no por iniciativa personal del médico. Respetar la decisión del paciente y solo documentar la negativa es ética insuficiente: el deber de notificación obligatoria no es opcional y la salud pública prevalece. La notificación a autoridades es lo que toca.

PREGUNTA 86

Niña de 5 años, previamente sana, presenta 3 días de enfermedad caracterizada por lesiones purpúricas palpables en extremidades inferiores y dolor con aumento de volumen en ambas rodillas. No tiene fiebre, no presenta dolor abdominal intenso ni vómitos, y se encuentra hemodinámicamente estable. Examen: no edemas ni compromiso neurológico. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A. Solicitar anticuerpos antinucleares y anti DNA de doble cadena
- B. Seguimiento ambulatorio con examen de orina y control de PA por lo menos 6 meses
- C. Reposo relativo con elevación de las piernas y AINEs para el dolor articular
- D. Pulsos de metilprednisolona a 30 mg/kg/día por vía EV durante 3 días

CLAVE: C

En clase lo dijimos claro: púrpura de Henoch-Schönlein (vasculitis IgA), la vasculitis sistémica más frecuente de la infancia, caracterizada por la triada de púrpura palpable en miembros inferiores y glúteos, artralgiyas o artritis (rodillas y tobillos) y dolor abdominal cólico. En esta paciente sin compromiso renal, abdominal severo ni neurológico, el manejo activo del cuadro agudo es de soporte: reposo relativo con elevación de las piernas para reducir nuevas lesiones por bipedestación prolongada y AINEs para el dolor articular (paracetamol o ibuprofeno). Esta intervención inmediata se complementa de forma obligatoria con seguimiento ambulatorio prolongado por al menos 6 meses con examen de orina y presión arterial seriados, porque la nefritis IgA tardía es la complicación más temida y puede aparecer semanas después del cuadro inicial. Los anticuerpos antinucleares y anti-DNA de doble cadena son útiles para sospecha de lupus, no de Henoch-Schönlein, donde el diagnóstico es clínico y los

anticuerpos son negativos. Ojo: el seguimiento ambulatorio con examen de orina por 6 meses es parte del manejo pero no es la conducta inmediata: la pregunta busca identificar el manejo activo del cuadro actual. Los pulsos de metilprednisolona se reservan para complicaciones graves como nefritis severa, hemorragia digestiva masiva o compromiso del sistema nervioso central, ninguno presente. Reposo + AINEs + vigilancia es el manejo estándar de Henoch-Schönlein no complicada.

PREGUNTA 87

Recién nacido a término, hijo de madre que presentó un cuadro pseudo gripal durante el primer trimestre del embarazo. En la ecografía craneal se evidencian ventriculomegalia y calcificaciones periventriculares. Examen: microcefalia. ¿Qué etiología se asocia con mayor probabilidad a este cuadro?

- A. Herpes simple neonatal
- B. Citomegalovirus congénito
- C. Toxoplasmosis congénita
- D. Rubeola primaria materna

CLAVE: B

La infección congénita por citomegalovirus (CMV) es la causa infecciosa congénita más frecuente y la principal etiología no genética de discapacidad neurológica en niños. El cuadro clásico incluye microcefalia, calcificaciones intracraneales con localización característica periventricular (a diferencia de las dispersas en toxoplasmosis), ventriculomegalia, hipoacusia neurosensorial progresiva y coriorretinitis. El antecedente materno de cuadro pseudogripal en el primer trimestre encaja con primoinfección por CMV durante el embarazo, momento de mayor riesgo de transmisión vertical y secuelas graves. El herpes simple neonatal se transmite predominantemente intraparto y produce sepsis viral con vesículas, encefalitis localizada o enfermedad diseminada en las primeras semanas, no microcefalia con calcificaciones desde el nacimiento. La toxoplasmosis congénita produce calcificaciones intracraneales pero su localización es dispersa por todo el parénquima, no específicamente periventricular, y suele asociarse a hidrocefalia y coriorretinitis macular. La rubéola congénita produce sordera, cataratas y cardiopatía (triada de Gregg) con calcificaciones menos prominentes y rara en países con vacunación. Calcificaciones PERIVENTRICULARES + microcefalia = CMV.

PREGUNTA 88

Varón de 36 años, 70 kg, sufre explosión de gas doméstico. Presenta quemaduras con flictenas dolorosas en tórax anterior, abdomen, ambos brazos y cara anterior de ambos muslos, además de algunas áreas blanquecinas y carbonizadas. Se estima clínicamente una superficie corporal quemada del 30% según la regla de los 9. ¿Cuál es el volumen total aproximado de solución cristaloide que debe indicarse utilizando la fórmula de Parkland, considerando que la mitad debe pasar en las primeras 8 horas?

- A. 4, 200 ml
- B. 10, 500 ml
- C. 5, 600 ml
- D. 8, 400 ml

CLAVE: D

La fórmula clásica de Parkland calcula el volumen de cristaloide (lactato de Ringer) a administrar en las primeras 24 horas tras la quemadura: $4 \text{ mL} \times \text{peso (kg)} \times \% \text{ SCT}$. Para este paciente: $4 \times 70 \times 30 = 8,400 \text{ mL}$ en total. La mitad (4,200 mL) se infunde en las primeras 8 horas desde la quemadura (no desde la admisión), y el resto en las siguientes 16 horas. Las guías ISBI 2016 y ABA actualizaron a un rango más conservador de 2-4 mL/kg/% para evitar el fluido creep y la sobrerreanimación, ajustando siempre por respuesta clínica. La diuresis horaria objetivo es 0.5 a 1 mL/kg/h en adultos. 4,200 mL corresponde solo a la mitad del cálculo de Parkland (las primeras 8 horas), no al volumen total. 10,500 mL excede el cálculo correcto (resultaría de aplicar $5 \text{ mL} \times \text{kg} \times \% \text{ SCT}$, no es la fórmula clásica de Parkland). 5,600 mL no se ajusta a ningún cálculo estándar para estos parámetros. Recordar que Parkland es $4 \text{ mL} \times \text{kg} \times \% \text{ SCT}$ total en 24 h, y que las primeras 8 horas concentran la mitad. La fórmula es solo orientativa: el ajuste final depende de la respuesta clínica medida por diuresis y signos de perfusión, no de adherirse rígidamente al cálculo.

PREGUNTA 89

En un hospital regional se implementa un programa de vigilancia endoscópica para pacientes con esófago de Barrett de largo segmento. Una mujer de 55 años, con antecedentes de obesidad y reflujo gastroesofágico crónico mal controlado, es incluida en el programa. En la primera endoscopia se encuentra una lesión ligeramente sobreelevada de 1.5 cm. La resección endoscópica informa adenocarcinoma bien diferenciado que infiltra la submucosa (T1b), sin invasión linfovascular demostrable. Imágenes: no metástasis. ¿Cuál es la estrategia más adecuada?

- A. Resección endoscópica ampliada del lecho tumoral
- B. Seguimiento endoscópico intensivo cada 6-12 meses
- C. Resección endoscópica de la mucosa y tratamiento médico
- D. Esofagectomía con linfadenectomía regional

CLAVE: D

En adenocarcinoma esofágico sobre esófago de Barrett con invasión submucosa (T1b), el riesgo de metástasis ganglionar regional asciende a 20-25%, por lo que la resección endoscópica deja de ser suficiente y la estrategia de elección pasa a ser esofagectomía con linfadenectomía regional. La invasión submucosa diferencia este escenario de las lesiones intramucosas (T1a), donde la resección endoscópica puede ser curativa. Aunque no haya invasión linfovascular ni metástasis a distancia visibles, la profundidad submucosa eleva la probabilidad de enfermedad ganglionar oculta y obliga a tratamiento radical con intención curativa. La resección endoscópica ampliada del lecho tumoral no controla el riesgo de metástasis ganglionar regional, fuera del alcance del endoscopio. Ojo: el seguimiento endoscópico intensivo cada 6-12 meses sin tratamiento adicional deja al paciente expuesto a progresión de enfermedad ganglionar oculta y es subóptimo para T1b. La resección endoscópica de la mucosa más tratamiento médico es estándar para T1a (lesión intramucosa), no para invasión submucosa. La esofagectomía con linfadenectomía es la estrategia oncológica definitiva en T1b sin metástasis a distancia.

PREGUNTA 90

Mujer de 35 años, con antecedente de estrés crónico por violencia psicológica conyugal, consulta por 18 meses de dolor musculoesquelético generalizado, fatiga intensa y sueño no reparador. Refiere sensación de hormigueos en miembros superiores. Ha recibido múltiples tratamientos con AINEs sin mejoría significativa. Examen: alodinia y dolor difuso a la palpación de músculos y tejidos blandos, sin signos de inflamación articular. Laboratorio: sin alteraciones en exámenes básicos. ¿Cuál es el fármaco más apropiado para iniciar el manejo farmacológico del dolor en la paciente?

- A. Etoricoxib a dosis antiinflamatoria durante varias semanas
- B. Morfina de liberación prolongada a dosis bajas
- C. Amitriptilina en dosis bajas, administrada por la noche
- D. Tramadol combinado con paracetamol, de manera continua

CLAVE: C

Aquí lo decisivo es fibromialgia, síndrome de dolor crónico generalizado caracterizado por alodinia, dolor difuso a la palpación, fatiga, sueño no reparador y trastornos cognitivos, frecuentemente asociado a estresores psicosociales. El tratamiento farmacológico de elección incluye antidepresivos tricíclicos a dosis bajas (amitriptilina 10-25 mg en la noche), inhibidores duales de recaptación (duloxetina, milnacipran) o anticonvulsivantes (pregabalina, gabapentina). La amitriptilina nocturna combina efecto antinociceptivo, mejora del sueño y modulación del eje serotonín-noradrenérgico, pilares de la fisiopatología del dolor central. Etoricoxib y otros AINEs tienen eficacia limitada en fibromialgia porque la fisiopatología es de sensibilización central, no inflamatoria; la paciente ya falló con AINEs. Morfina de liberación prolongada está formalmente contraindicada en fibromialgia por riesgo de hiperalgesia inducida por opioides, dependencia y mala respuesta a largo plazo. Tramadol con paracetamol puede usarse en casos seleccionados pero no como primera línea por riesgo de dependencia y efectos adversos. La amitriptilina en dosis bajas nocturnas es la elección con mayor evidencia y mejor perfil costo-efectividad.

PREGUNTA 91

Varón de 29 años, con antecedente de múltiples parejas sexuales y uso inconsistente de condón, consulta por aparición de úlceras genitales dolorosas, de base blanda y bordes irregulares, con linfadenitis inguinal dolorosa. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

- A. Ampicilina
- B. Tetraciclina
- C. Cotrimoxazol
- D. Azitromicina

CLAVE: D

Lo que define este caso es chancroide o chancro blando, infección de transmisión sexual por *Haemophilus ducreyi*, caracterizada por úlceras genitales dolorosas (a diferencia del chancro sifilítico, indoloro), de base blanda y bordes irregulares, asociadas a linfadenitis inguinal supurativa dolorosa. El tratamiento de elección recomendado por el CDC y el MINSA es azitromicina 1 g vía oral en dosis única, alternativa: ceftriaxona 250 mg IM dosis única o ciprofloxacino 500 mg cada 12 h por 3 días. La dosis única favorece la adherencia y permite tratamiento simultáneo a la pareja. La ampicilina no es activa contra *Haemophilus ducreyi* en la mayoría de las cepas y carece de evidencia para chancroide. La tetraciclina como monoterapia ha sido reemplazada por azitromicina por mejor

tolerabilidad y dosis única. El cotrimoxazol presenta resistencia creciente y ya no figura como primera línea en guías actualizadas. Azitromicina dosis única es el estándar contemporáneo para chancroide, y además es eficaz para concomitantes infecciones por *Chlamydia* que coexisten con frecuencia en pacientes con conducta sexual de riesgo.

PREGUNTA 92

Primigesta de 36 semanas sin antecedentes registrados de hipertensión arterial crónica, ingresa con diagnóstico de eclampsia y pese al manejo fallece por hemorragia intracerebral. ¿Qué diagnóstico debe registrarse como causa básica de esta muerte materna en el sistema de vigilancia?

- A. Eclampsia
- B. Hipertensión arterial crónica
- C. Hemorragia intracerebral
- D. Gestación pretérmino

CLAVE: A

En vigilancia epidemiológica de muerte materna, la causa básica se define según las reglas de la CIE-10 como la enfermedad o condición inicial que desencadenó la cadena de eventos que condujo a la muerte. En este caso, la eclampsia es la condición desencadenante: la complicación hipertensiva del embarazo que produjo la convulsión y la subsecuente hemorragia intracerebral fatal. Por lo tanto, en el certificado de defunción y en el registro del sistema de vigilancia debe consignarse eclampsia como causa básica de muerte materna. La hipertensión arterial crónica no aplica porque la paciente no tenía antecedente registrado y el cuadro se desencadenó como trastorno hipertensivo del embarazo, no por HTA preexistente. La hemorragia intracerebral es la causa final o terminal de muerte (mecanismo letal), pero no la causa básica que inició la cadena patológica; en CIE-10 las causas finales no se registran como básicas. La gestación pretérmino es una circunstancia, no una causa básica. Distinguir causa básica (la que desencadena) de causa final (la que mata directamente) es competencia clave en epidemiología y certificación de muerte materna.

PREGUNTA 93

Varón de 65 años con antecedente de trastorno bipolar en tratamiento con litio desde hace 10 años. Consulta por temblor en ambas manos que ha ido empeorando de forma progresiva en los últimos 2 años y los síntomas mejoran de forma transitoria después

de beber 1-2 cervezas pero dificulta su escritura y otras actividades finas. Refiere que el padre y el abuelo tenían un temblor similar. Examen: temblor bilateral al mantener los brazos extendidos y temblor de la voz; el resto del examen neurológico y general es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Intoxicación por litio
- B. Temblor esencial
- C. Hipertiroidismo
- D. Enfermedad de Parkinson

CLAVE: B

Lo que pega de inmediato: temblor esencial, el trastorno del movimiento más frecuente en adultos. Características clave en este paciente: temblor postural-de acción simétrico bilateral en manos al mantener los brazos extendidos, compromiso de la voz, mejoría transitoria con alcohol (signo distintivo del temblor esencial), historia familiar positiva (padre y abuelo) compatible con herencia autosómica dominante con penetrancia variable. El examen neurológico general es normal sin signos parkinsonianos (rigidez, bradicinesia, marcha festinante). La intoxicación por litio produce temblor pero suele acompañarse de náuseas, diarrea, ataxia, confusión y signos de toxicidad sistémica, y además de niveles séricos elevados; aquí no hay datos de toxicidad y el cuadro es crónico-progresivo familiar, no agudo. El hipertiroidismo cursa con temblor fino más taquicardia, pérdida de peso, intolerancia al calor y diaforesis, ninguno presente. La enfermedad de Parkinson genera temblor de reposo asimétrico (no postural ni simétrico), con rigidez, bradicinesia y, en estadios avanzados, marcha festinante; tampoco mejora con alcohol. Mejora con alcohol + historia familiar = temblor esencial.

PREGUNTA 94

Niño de 5 años programado para cirugía de urgencia por traumatismo facial cerrado. En la evaluación preanestésica se logra valorar la apertura bucal y la orofaringe, encontrándose un Mallampati clase I, sin limitación de apertura oral ni movilidad cervical. No hay edema significativo ni sangrado activo en cavidad oral. ¿Qué predice este hallazgo respecto a la intubación orotraqueal?

- A. Alta probabilidad de intubación orotraqueal fácil
- B. Necesidad obligatoria de videolaringoscopia para lograr la intubación
- C. Intubación imposible por vía orotraqueal
- D. Alta probabilidad de intubación orotraqueal difícil

CLAVE: A

La clasificación de Mallampati es un predictor preanestésico de dificultad de intubación basado en la visualización de las estructuras orofaríngeas con apertura bucal máxima. Mallampati clase I corresponde a visualización completa del paladar blando, úvula, fauces y pilares amigdalinos, lo que predice alta probabilidad de intubación orotraqueal fácil. Combinado con apertura oral adecuada y movilidad cervical conservada, este hallazgo permite anticipar una vía aérea de manejo sencillo con laringoscopia convencional, sin necesidad de equipos avanzados. La videolaringoscopia obligatoria es necesaria cuando hay predictores múltiples de vía aérea difícil, no en Mallampati I con apertura y movilidad normales. La intubación imposible por vía orotraqueal es escenario de vía aérea verdaderamente catastrófica, propia de Mallampati IV con limitaciones marcadas o anomalías anatómicas severas, no aplica aquí. La alta probabilidad de intubación difícil corresponde a Mallampati III-IV con criterios adicionales como retrognatia, cuello corto o limitación de apertura, condiciones ausentes en este paciente. Mallampati I = vía aérea predeciblemente fácil.

PREGUNTA 95

Mujer de 35 años, sin comorbilidades conocidas, presenta desde hace 7 días dolor en hipocondrio derecho, náuseas, vómitos, escalofríos y fiebre. Examen: FC 100 x', PA 90/60 mmHg, T 39 °C, dolor a la palpación en hipocondrio derecho con signo de Murphy positivo. Laboratorio: leucocitos 16, 000/mm³, amilasa 100 U/L, lipasa 50 U/L. Ecografía abdominal: vesícula biliar con pared engrosada, múltiples cálculos, vía biliar principal de 7 mm, sin dilatación marcada. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- A. Sólo AINEs y evaluación ambulatoria en 24 a 48 horas
- B. Antibióticos EV de amplio espectro, colecistectomía laparoscópica temprana
- C. Resonancia magnética colangio pancreática y definir conducta según hallazgos
- D. Colecistectomía abierta de urgencia bajo anestesia general sin otras medidas previas

CLAVE: B

La paciente cursa colecistitis aguda complicada (fiebre alta de 39, hipotensión limítrofe, taquicardia y leucocitosis 16, 000) por probable evolución prolongada de 7 días con potencial respuesta inflamatoria sistémica. La conducta correcta es iniciar antibioticoterapia endovenosa de amplio espectro con cobertura para gramnegativos y anaerobios entéricos (piperacilina-tazobactam o ceftriaxona más metronidazol), reanimación con cristaloides, y proceder con colecistectomía laparoscópica temprana en las primeras 72 horas tras estabilización, según guías de Tokyo y SAGES. AINEs y evaluación ambulatoria son inaceptables: la paciente está séptica, con T 39 y PA 90/60, y

requiere internamiento y tratamiento agresivo. La resonancia magnética colangio pancreática (colangio-RM) se solicita ante sospecha de coledocolitiasis con ictericia o pruebas hepáticas patológicas, pero aquí la vía biliar mide 7 mm sin dilatación marcada y el diagnóstico de colecistitis ya está hecho ecográficamente; pedirla solo retrasa el tratamiento. La colecistectomía abierta sin antibióticos previos ni reanimación es subóptima cuando hay signos sépticos. ATB EV + colelap temprana es la combinación correcta.

PREGUNTA 96

Varón de 30 años sufre accidente de tránsito y llega a emergencia con disnea súbita. Examen: FC 100 x', PA 90/60 mmHg, FR 26 x', SatO2 91% al aire ambiente. Tórax: MV abolido en HTD y timpanismo en el mismo lado. ¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?

- A. Toracotomía de urgencia para hemostasia
- B. Intubación orotraqueal con ventilación mecánica
- C. Pericardiocentesis subxifoidea
- D. Toracostomía con tubo en el hemitórax derecho

CLAVE: D

Antes de elegir, fíjate en neumotórax simple o a tensión incipiente en hemitórax derecho tras trauma cerrado: disnea, hipotensión limítrofe, abolición del murmullo vesicular y timpanismo a la percusión. La conducta inmediata es la colocación de tubo de toracostomía (drenaje pleural cerrado) en el hemitórax afectado, en quinto espacio intercostal entre línea axilar anterior y media, conectado a sello de agua. Esta maniobra resuelve simultáneamente neumotórax y hemotórax si coexisten, y permite evaluar volumen de drenaje para decidir necesidad de toracotomía. La toracotomía de urgencia para hemostasia se reserva para drenaje inicial mayor de 1500 mL o débito sostenido mayor de 200 mL/h por 4 horas, condiciones que aún no se conocen porque no se ha drenado nada. La intubación orotraqueal con ventilación mecánica antes de drenar un neumotórax puede precipitar neumotórax a tensión por presión positiva, está contraindicada como medida inicial sin tubo torácico. La pericardiocentesis subxifoidea se utiliza para taponamiento cardíaco, no aplica aquí donde el problema es pleural. Toracostomía con tubo es la maniobra correcta.

PREGUNTA 97

Durante una supervisión a las diferentes áreas de su establecimiento de salud, usted encuentra productos farmacéuticos vencidos. Según la normativa vigente del MINSA sobre gestión de residuos sólidos en establecimientos de salud. ¿Cómo se denomina a este tipo de residuos?

- A. De atención del paciente
- B. Comunes
- C. Especiales
- D. Químicos no peligrosos

CLAVE: C

Según la normativa peruana del MINSA (NTS 144-MINSA y reglamento de gestión de residuos sólidos en establecimientos de salud), los productos farmacéuticos vencidos se clasifican como residuos especiales clase B (biocontaminados, especiales y comunes son las tres categorías generales). Los residuos especiales incluyen los químicos peligrosos (productos farmacéuticos vencidos, desinfectantes, reactivos), los radiactivos y los residuos farmacéuticos. Su manejo requiere segregación en contenedores específicos rotulados, almacenamiento intermedio y disposición final con empresa autorizada por DIGESA. Los residuos de atención del paciente corresponden a la categoría biocontaminada (clase A): material punzocortante, fluidos corporales, sangre, partes anatómicas, no incluye productos farmacéuticos. Los residuos comunes (clase C) son los generados por actividades administrativas y de limpieza, similares a residuos domiciliarios, sin riesgo biológico ni químico. Los químicos no peligrosos no son una categoría formal en la clasificación peruana; los farmacéuticos vencidos sí son peligrosos por contaminación ambiental potencial. Productos farmacéuticos vencidos – residuos especiales (clase B).

PREGUNTA 98

Mujer de 35 años que hace 2 horas es mordida por su propio perro, produciéndole una herida en la cara anterior del muslo izquierdo. Examen: herida de 6 cm de longitud, de bordes netos, sin sangrado activo, sin necrosis ni cuerpos extraños visibles. La zona ha sido ya irrigada abundantemente con solución salina y se ha realizado limpieza adecuada. ¿Cuál es el tipo de cierre de herida indicado?

- A. Primario
- B. Secundario
- C. Terciario
- D. Desbridamiento

CLAVE: A

En heridas por mordedura de perro propio (no callejero, sin signos de rabia) atendidas dentro de las primeras 6 a 8 horas, con bordes netos, irrigación abundante con suero fisiológico y limpieza adecuada, el cierre primario está indicado. La evidencia actual respalda el cierre primario en mordeduras de localización facial, en miembros con limpieza adecuada y sin signos de infección, asociado a profilaxis antibiótica con amoxicilina-clavulánico para cubrir *Pasteurella multocida*. Las heridas en mano y las muy contaminadas se manejan con cierre por segunda intención o terciario. El cierre secundario (cicatrización por segunda intención) deja la herida abierta para que cicatrice por granulación y se reserva para heridas muy contaminadas, infectadas o con pérdida de tejido extensa. El cierre terciario (primario diferido) implica dejar la herida abierta 4-7 días con apósitos y luego suturar, indicado en heridas con riesgo intermedio de infección y bordes que pueden recuperarse. El desbridamiento es un paso del manejo, no un tipo de cierre. En esta herida limpia de bordes netos en muslo, atendida tempranamente y sin contaminación visible, el cierre primario es la opción correcta.

PREGUNTA 99

En un hospital regional, una mujer de 45 años con antecedente de depresión tratada con amitriptilina es llevada a emergencia, 3 horas después de ingerir intencionalmente 30 tabletas de 75 mg cada una. Al ingreso: PA 80/40 mmHg, FC 135 x', FR 24 x', T 36, 5 °C, Glasgow 9, pupilas midriáticas y piel seca. EKG: QRS 140 ms y QT prolongado. Laboratorio: pH 7, 25, HCO₃⁻ 18 mEq/L y potasio 3, 7 mEq/L. Tras asegurar la vía aérea y administrar cristaloides sin mejoría significativa, se decide iniciar tratamiento farmacológico. ¿Cuál es la intervención farmacológica más adecuada?

- A. Bicarbonato de sodio EV en bolos titulados hasta lograr pH 7, 45 - 7, 55
- B. Fisostigmina intravenosa para revertir el síndrome anticolinérgico central
- C. Gluconato de calcio intravenoso para estabilizar la membrana miocárdica
- D. Antagonista H₂ intravenoso para disminuir la absorción gastrointestinal del fármaco

CLAVE: A

En intoxicación por antidepresivos tricíclicos como amitriptilina, el QRS mayor de 100 ms en el ECG es marcador de toxicidad por bloqueo de canales rápidos de sodio cardíacos, con riesgo elevado de arritmias ventriculares y paro cardíaco. El tratamiento de elección es bicarbonato de sodio endovenoso en bolos titulados (1-2 mEq/kg) para alcalinizar el plasma a pH 7.45-7.55, con dos efectos terapéuticos sinérgicos: alcalinización plasmática reduce la fracción de fármaco libre y desplaza la unión a canales de sodio

cardíacos, y sobrecarga de sodio compite con el bloqueo y restaura la conducción ventricular. La fisostigmina puede revertir síntomas anticolinérgicos centrales pero está contraindicada en intoxicación por tricíclicos porque puede precipitar convulsiones, asistolia y arritmias graves. El gluconato de calcio se usa en hiperkalemia o intoxicación por bloqueadores de canales de calcio, no para tricíclicos donde el problema es bloqueo de sodio. Los antagonistas H₂ no aceleran la eliminación ni revierten la cardiotoxicidad de los tricíclicos. El bicarbonato de sodio es la terapia específica con mayor evidencia y debe iniciarse de inmediato cuando el QRS supera los 100 ms.

PREGUNTA 100

Primigesta de 32 semanas, sin control prenatal, asintomática. Examen: PA 100/60 mmHg, FC 72 x'. LCF 144 x'. VIH positivo. ¿Cuál medida lograría un mayor impacto en la reducción del riesgo de transmisión al recién nacido?

- A. Suspensión total de la lactancia materna
- B. Cesárea electiva a las 38 semanas
- C. Inicio inmediato de terapia antirretroviral
- D. Aislamiento de contacto del recién nacido

CLAVE: C

En toda gestante con diagnóstico de VIH la medida con mayor impacto sobre la transmisión vertical es el inicio inmediato de terapia antirretroviral (TAR) de alta efectividad, idealmente combinación de tres fármacos según guías nacionales y de la OMS. La carga viral materna es el predictor más importante de transmisión perinatal, y reducir esa carga viral a indetectable (<50 copias/mL) antes del parto disminuye la transmisión vertical de cifras del 25-30% sin TAR a menos del 1% con TAR adecuada y supresión virológica mantenida. La suspensión de la lactancia materna es relevante para evitar transmisión postnatal en países con acceso seguro a fórmula y agua potable, pero no es la medida con mayor impacto cuando se compara con TAR durante la gestación; y además en zonas sin acceso seguro a fórmula, la lactancia con TAR adecuada se considera una opción aceptable. Ojo: la cesárea electiva a las 38 semanas reduce transmisión cuando la carga viral materna es mayor de 1000 copias/mL al término, pero su impacto es menor que el TAR sostenida desde la gestación. El aislamiento de contacto del recién nacido no aplica para VIH (no se transmite por contacto casual). TAR inmediata ese dato es el que decide.

PREGUNTA 101

La ergonomía contribuye a mejorar la seguridad, el bienestar y la eficiencia de los trabajadores principalmente porque....

- A. optimiza los procesos administrativos para incrementar la productividad global de la empresa, independientemente de las capacidades del trabajador.
- B. define políticas de distribución equitativa de recursos laborales, priorizando la justicia y los objetivos dentro de la organización.
- C. identifica y controla los factores de riesgo de la comunidad y riesgos de enfermedades transmisibles y no transmisibles.
- D. analiza y adapta el diseño de los puestos de trabajo, herramientas y tareas a las características físicas y cognitivas de las personas que los utilizan.

CLAVE: D

La ergonomía es la disciplina científica que estudia las interacciones entre los seres humanos y los demás elementos de un sistema, y aplica principios teóricos, datos y métodos para diseñar puestos de trabajo, herramientas, equipos y tareas que se adapten a las características físicas (antropométricas, biomecánicas) y cognitivas (atención, memoria, toma de decisiones) de las personas que los utilizan. Este enfoque centrado en el trabajador previene trastornos musculoesqueléticos, reduce errores y accidentes, y mejora la productividad sostenible. Optimizar procesos administrativos para incrementar la productividad sin considerar las capacidades del trabajador es taylorismo clásico, contrario al enfoque ergonómico moderno que parte del trabajador. Definir políticas de distribución equitativa de recursos laborales corresponde a gestión de recursos humanos y justicia organizacional, no a ergonomía. Identificar y controlar factores de riesgo comunitarios y enfermedades transmisibles es competencia de salud pública y epidemiología, no de ergonomía. Adaptar el diseño del trabajo a las personas es la definición operativa correcta y respaldada por la OIT.

PREGUNTA 102

Varón de 45 años, presenta traumatismo craneoencefálico por accidente de tránsito. Llega a emergencia con Glasgow 8, PA 100/50 mmHg, FC 55 x', pupila izquierda midriática y arreactiva. Vía aérea asegurada, con oxígeno suplementario y se inician medidas de estabilización hemodinámica. ¿Cuál es la conducta específica inmediata más apropiada?

- A. Iniciar dexametasona EV y continuar monitorización en sala de observación
- B. Remitir al paciente a la unidad de cuidados intensivos para monitoreo y manejo intensivo

C. Solicitar TC de cráneo urgente y evaluar el resultado para decidir cirugía

D. Administrar solución hipertónica e indicar descompresión quirúrgica de emergencia

CLAVE: C

En TCE severo (GCS 8) con pupila ipsilateral midriática y arreactiva, bradicardia (FC 55) e hipertensión limítrofe (PA 100/50), el paciente cursa probable hernia uncal por hematoma supratentorial con compresión del III par craneal. La conducta específica inmediata es solicitar TC de cráneo urgente para identificar la lesión expansiva (hematoma epidural, subdural agudo o contusión expansiva) y coordinar la descompresión quirúrgica con neurocirugía. En paralelo a la solicitud de TC y mientras se traslada al paciente, debe iniciarse terapia hiperosmolar (manitol al 20% a 0.25-1 g/kg EV o solución salina hipertónica al 3%) como medida temporizadora para reducir la hipertensión intracraneal y dar tiempo a la imagen y al neurocirujano. Las medidas de estabilización (vía aérea asegurada, mantener PAM mayor de 65 mmHg, evitar hipoxia) ya están en curso y deben mantenerse. La dexametasona endovenosa no está indicada en TCE traumático: estudios CRASH demostraron que aumenta la mortalidad y va contra las guías. Remitir a UCI sin imagen es subóptimo porque retrasa el diagnóstico de una lesión potencialmente quirúrgica. Administrar solución hipertónica como manitol al 20% o salina hipertónica es razonable como medida temporizadora ante signos de herniación, pero la descompresión quirúrgica de emergencia sin TC y sin neurocirujano evaluador es ciega y peligrosa. La TC urgente con coordinación inmediata con neurocirugía es lo que toca.

PREGUNTA 103

Varón de 56 años con antecedente de hipertensión arterial, acude al servicio de urgencias por palpitaciones intensas y sensación de mareo. Examen: FC 180 x', PA 80/50 mmHg y Glasgow 13. El electrocardiograma muestra taquicardia regular con QRS estrecho. ¿Cuál es la conducta inmediata más apropiada?

A. Adenosina EV en bolo

B. Maniobra vagal más lidocaína EV

C. Amiodarona 300 mg EV en infusión

D. Cardioversión eléctrica sincronizada

CLAVE: D

En toda taquicardia con inestabilidad hemodinámica (hipotensión PA 80/50, alteración del estado de conciencia con Glasgow 13, signos de hipoperfusión), independientemente del tipo de taquicardia (supraventricular o ventricular), la conducta inmediata es

cardioversión eléctrica sincronizada bajo sedación. La energía recomendada para taquicardia supraventricular paroxística estrecha y regular inicia en 50-100 J en modo sincronizado, con escalada progresiva si no responde. La sincronización es crucial para evitar descarga sobre la onda T y precipitar fibrilación ventricular. La adenosina endovenosa en bolo es de elección en taquicardia supraventricular paroxística con paciente estable, pero en presencia de inestabilidad la prioridad es la cardioversión eléctrica sin demora farmacológica. Las maniobras vagales con lidocaína no son apropiadas: las maniobras vagales se reservan para pacientes estables y la lidocaína no es de primera línea en taquicardia con QRS estrecho. La amiodarona endovenosa puede considerarse en taquicardia con QRS ancho de origen incierto o post-cardioversión, pero no antes de la cardioversión eléctrica en paciente inestable.

PREGUNTA 104

En un hospital sin servicio de neurocirugía, ingresa un varón de 25 años tras accidente de tránsito. Examen: Glasgow 6, pupilas isocóricas y reactivas, SatO2 86% al aire ambiente, PA 100/60 mmHg y signos clínicos de fractura de base de cráneo. Deberá ser trasladado en ambulancia por 40 minutos a un hospital de referencia para TC y neurocirugía. Desde el punto de vista fisiopatológico y de seguridad del paciente durante el traslado. ¿Cuál debe ser la intervención inicial prioritaria?

- A. Intubación orotraqueal con secuencia rápida para asegurar vía aérea y ventilación
- B. Iniciar infusión de manitol para disminuir la presión intracraneal antes de derivarlo
- C. Trasladarlo de inmediato sin intubación para evitar retraso de la TC y la intervención neuroquirúrgica
- D. Administrar sedantes y analgésicos EV para disminuir el consumo cerebral de oxígeno sin intubar

CLAVE: A

En TCE severo con Glasgow ≤ 8 (en este caso Glasgow 6), la intubación orotraqueal con secuencia rápida es la prioridad antes de cualquier traslado prolongado, porque el paciente no puede proteger su vía aérea y la hipoxia (SatO2 86%) y la hipercapnia secundaria son factores fisiopatológicos que aumentan la presión intracraneal y empeoran el daño cerebral secundario. Con un traslado de 40 minutos, asegurar la vía aérea con tubo orotraqueal y ventilación mecánica con normoxia y normocapnia es esencial para preservar la perfusión cerebral. Iniciar manitol antes del diagnóstico imagenológico es controvertido porque puede aumentar el daño en hematomas epidurales o causar deshidratación; se reserva para signos claros de herniación.

Trasladar de inmediato sin intubación deja al paciente en riesgo crítico de aspiración, hipoxemia y deterioro neurológico durante el viaje, y va contra las recomendaciones de manejo prehospitalario del TCE severo. Sedantes y analgésicos sin intubación pueden deprimir aún más la respiración y comprometer la vía aérea, conducta peligrosa. IOT con secuencia rápida quédate con eso.

PREGUNTA 105

Niña de 18 meses es traída al consultorio por marcha anómala. La madre refiere que en el puesto de salud le indicaron "doble pañal" desde los 12 hasta los 18 meses por asimetría de pliegues glúteos. Examen: cojera leve y limitación de la abducción de cadera derecha. Rx de pelvis en proyección anteroposterior muestra luxación de cadera derecha con desplazamiento proximal de la cabeza femoral (índice de Tönnis III), sin signos de reducción. ¿Cuál es el tratamiento de elección en este momento?

- A. Bota de yeso corta para corrección
- B. Arnés de Pavlik a tiempo completo
- C. Cojín de Frejka intermitente
- D. Cirugía para reducción abierta de la cadera

CLAVE: D

En displasia del desarrollo de cadera diagnosticada después de los 18 meses con luxación franca (Tönnis III), las opciones conservadoras como arnés de Pavlik (efectivo solo hasta los 6 meses) o cojín de Frejka han perdido su ventana de aplicación. El tratamiento de elección en este escenario es la reducción abierta de la cadera por cirugía, frecuentemente combinada con osteotomía pélvica (Salter) o femoral (varización-desrotación) según el grado de displasia acetabular y femoral, para asegurar congruencia articular y desarrollo posterior normal. La bota de yeso corta no tiene utilidad en displasia de cadera; se usa para correcciones distales del pie. El arnés de Pavlik es eficaz solo en menores de 6 meses con cadera reducible o luxable; a los 18 meses con luxación establecida no logra reducción y puede causar necrosis avascular. El cojín de Frejka tiene aplicación en displasia leve en lactantes pequeños, no en luxación tardía. La cirugía abierta es la única intervención con probabilidad razonable de éxito en niñas mayores de 18 meses con luxación, idealmente antes de la deambulación independiente o lo más temprano posible para optimizar resultados.

PREGUNTA 106

Escolar de 8 años, previamente sano, presenta desde hace 5 días múltiples lesiones alrededor de la boca. Iniciaron como pequeñas vesículas sobre piel eritematosa que se rompieron fácilmente, dejando áreas húmedas que luego formaron costras amarillentas en "miel de abeja". No tiene fiebre ni compromiso del estado general. Refieren antecedente de rascado repetido por prurito leve en la zona. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Dermatitis atópica
- B. Varicela
- C. Escabiosis
- D. Impétigo

CLAVE: D

Lo de siempre, como vimos en clase: impétigo no buloso, infección bacteriana superficial de la piel causada principalmente por *Streptococcus pyogenes* y *Staphylococcus aureus*, frecuente en niños en edad escolar. Las características descritas son patognomónicas: lesiones periorificiales (alrededor de la boca), vesículas iniciales sobre base eritematosa que se rompen rápidamente, áreas húmedas exudativas que evolucionan a costras de color miel (melicéricas), sin fiebre ni compromiso sistémico, frecuentemente con antecedente de rascado por prurito leve o lesión cutánea previa que sirve de puerta de entrada. La dermatitis atópica produce placas eritematoescamosas pruriginosas crónicas en flexuras, párpados y mejillas, no costras melicéricas con vesículas previas. Ojo: la varicela cursa con vesículas en distintos estadios de evolución (polimorfismo lesional), distribución céfalo-caudal y compromiso sistémico con fiebre, no localización periorificial limitada. La escabiosis genera surcos y pápulas pruriginosas en pliegues, espacios interdigitales y genitales, con prurito nocturno marcado, sin costras melicéricas. Costras color miel en niño con prurito previo = impétigo. Tratamiento: mupirocina tópica o cefalexina oral.

PREGUNTA 107

Ingresa a emergencia durante la noche un hombre de 55 años con enfermedad renal crónica estadio 5 sin diálisis. Refiere 24 horas de debilidad intensa y náuseas. Examen: PA 150/90 mmHg, letárgico, con respiración Kussmaul. EKG: ondas T picudas y ensanchamiento del QRS. Gasometría arterial pH 7.2, HCO₃⁻ 15 mEq/L. Laboratorio: K⁺ sérico 7.6 mEq/L, creatinina 9.5 mg/dL. La unidad de hemodiálisis se encuentra cerrada durante la madrugada. En este escenario. ¿Cuál es la intervención inmediata más adecuada a realizar?

- A. Resinas de intercambio catiónico por vía oral o rectal y observar la respuesta en las siguientes horas
- B. Traslado inmediato a un hospital de mayor complejidad para hemodiálisis urgente
- C. Gluconato de calcio EV más infusión de insulina regular con glucosa y un agonista beta-2 nebulizado
- D. Bicarbonato de sodio EV como medida principal para corregir la acidosis y reducir el potasio sérico

CLAVE: C

En hiperpotasemia severa (K 7.6) con cambios electrocardiográficos significativos (T picudas, ensanchamiento del QRS), el manejo es secuencial e inmediato. Primero, gluconato de calcio al 10% (10 mL EV en 2-3 minutos, repetir si persisten cambios EKG a los 5 minutos) para estabilizar la membrana cardíaca; no reduce el potasio pero antagoniza sus efectos arritmogénicos en minutos. Segundo, insulina regular 10 UI EV con 50 mL de dextrosa al 50% para redistribución intracelular del potasio (efecto en 10-30 minutos). Tercero, salbutamol nebulizado 10-20 mg como adyuvante de redistribución. Estas tres medidas se inician en simultáneo mientras se gestiona el acceso a hemodiálisis definitiva. Las resinas de intercambio catiónico actúan en horas y no son apropiadas como única medida en hiperpotasemia severa con cambios ECG. El traslado para hemodiálisis sin intervenciones farmacológicas previas expone al paciente a paro cardíaco arritmico durante el viaje; primero hay que estabilizar y luego trasladar. El bicarbonato de sodio puede ayudar redistribuyendo potasio en pacientes con acidosis metabólica, pero no es la medida principal ni reemplaza al calcio EV para estabilización de membrana. La triada calcio + insulina/dextrosa + beta-2 es lo que toca inmediata.

PREGUNTA 108

Varón de 45 años, con antecedente de enfermedad por reflujo gastroesofágico, consulta por pirosis intensa de varios meses de duración. Ha usado antiácidos de venta libre con alivio parcial. El médico decide iniciar un tratamiento que inhiba específicamente la bomba H⁺/K⁺-ATPasa de las células responsables de la secreción de ácido clorhídrico en el cuerpo gástrico. ¿Sobre qué tipo de células actúa principalmente el fármaco prescrito para lograr este efecto?

- A. Mucosas superficiales del epitelio gástrico
- B. Parietales (oxínticas) de las glándulas del cuerpo gástrico
- C. G del antro gástrico
- D. Principales (zimógenas) de las glándulas gástricas

CLAVE: B

Los inhibidores de la bomba de protones (omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, etc.) actúan específicamente sobre la bomba $H^+/K^+-ATPasa$ localizada en las células parietales (oxínticas) de las glándulas del cuerpo gástrico. Estas células son las responsables exclusivas de la secreción del ácido clorhídrico (HCl) gástrico mediante el intercambio activo de protones por potasio en su membrana apical. El bloqueo irreversible de la bomba $H^+/K^+-ATPasa$ por los IBP reduce drásticamente la producción de ácido y permite la cicatrización de la mucosa esofágica en ERGE. Las células mucosas superficiales del epitelio gástrico secretan moco protector, no ácido; los IBP no actúan sobre ellas. Las células G del antro gástrico secretan gastrina, que estimula a las parietales pero no producen ácido; los IBP no las afectan en su función endocrina, aunque secundariamente la gastrina puede aumentar por feedback. Las células principales (zimógenas) producen pepsinógeno, precursor de la pepsina, no ácido clorhídrico. La bomba $H^+/K^+-ATPasa$ es marca registrada de las células parietales del cuerpo gástrico.

PREGUNTA 109

Niño de 1 año ingiere accidentalmente líquido desatorador de drenaje que contiene hidróxido de sodio (álcali fuerte). ¿Qué tipo de compromiso histopatológico produce este tipo de sustancia en el esófago y estómago?

- A. Lesión esofágica superficial autolimitada
- B. Lesión sin riesgo significativo de perforación
- C. Necrosis de coagulación de esófago y estómago
- D. Necrosis de licuefacción del esófago y estómago

CLAVE: D

Los álcalis fuertes (hidróxido de sodio, lejía concentrada, productos desatorados) producen necrosis por licuefacción al penetrar profundamente en los tejidos por saponificación de las grasas y disolución de las proteínas, generando lesiones transmurales esofágicas y gástricas con riesgo elevado de perforación, mediastinitis, fístulas y, a largo plazo, estenosis esofágicas cicatriciales. Por eso la ingesta de álcalis es considerada una emergencia toxicológica y exige endoscopia digestiva alta dentro de las primeras 24 horas para evaluar profundidad de la lesión. La lesión esofágica superficial autolimitada y la lesión sin riesgo significativo de perforación corresponderían a quemaduras leves por sustancias menos cáusticas o cantidades muy pequeñas, no a un álcali fuerte concentrado. La necrosis por coagulación es el tipo de lesión que

producen los ácidos fuertes (ácido clorhídrico, sulfúrico): coagulan las proteínas formando una escara superficial que limita la penetración profunda, lo que paradójicamente protege más al esófago aunque puede dañar más severamente el estómago. Álcali = licuefacción profunda; ácido = coagulación superficial.

PREGUNTA 110

Varón de 25 años sufre un accidente en motocicleta. Llega a emergencia con disnea severa. Examen: FC 100 x', PA 80/50 mmHg, desviación traqueal hacia la izquierda, ingurgitación yugular y ausencia de murmullo vesicular en el HTD, SatO₂ 82% con oxígeno por cánula nasal. ¿Cuál es la primera intervención que se debe realizar?

- A. Toracostomía con aguja en 2º espacio intercostal derecho
- B. Radiografía de tórax para confirmar diagnóstico
- C. Intubación orotraqueal inmediata con videolaringoscopia
- D. Oxigenoterapia con mascarilla de alto flujo

CLAVE: A

El detalle que define el caso: neumotórax a tensión derecho con compromiso hemodinámico inminente: disnea severa, hipotensión (80/50), desviación traqueal contralateral (hacia la izquierda), ingurgitación yugular por compresión de retorno venoso, ausencia de murmullo vesicular en el lado afectado y desaturación pese a oxígeno suplementario. La intervención inmediata salvavidas es la toracocentesis descompresiva con aguja gruesa (G14-16) en el segundo espacio intercostal en la línea medioclavicular del lado afectado (derecho), que convierte el neumotórax a tensión en neumotórax simple y permite estabilizar al paciente para colocar luego un tubo torácico definitivo. La radiografía de tórax confirmaría el diagnóstico pero retrasa la intervención salvadora; el neumotórax a tensión es diagnóstico clínico y se trata sin imagen previa. La intubación orotraqueal sin descomprimir el tórax puede precipitar paro cardíaco al aumentar la presión intratorácica con la ventilación positiva. La oxigenoterapia con mascarilla de alto flujo no resuelve el problema mecánico de compresión mediastínica. Toracocentesis descompresiva con aguja en segundo EIC línea medioclavicular es la primera intervención.

PREGUNTA 111

Varón de 35 años acude a consulta de cirugía por presentar desde hace 2 meses episodios de dolor perianal leve a moderado y manchado intermitente con secreción purulenta en la ropa interior. Refirió drenaje de un absceso perianal hace 3 meses.

Examen: pequeño orificio cutáneo cercano al margen anal, con salida escasa de material purulento a la presión. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Absceso perianal
- B. Fisura anal crónica
- C. Hemorroide externa trombosada
- D. Fístula perianal

CLAVE: D

Esto es lo que martillamos en clase: fístula perianal, complicación frecuente posterior al drenaje de un absceso perianal (entre 30 y 50% de los abscesos drenados desarrollan fístula). Las características clave son: antecedente de drenaje quirúrgico de absceso, evolución crónica con secreción purulenta intermitente, presencia de un orificio cutáneo externo cercano al margen anal con salida de pus a la presión. La fístula consiste en un trayecto que comunica la cripta anal infectada con la piel perianal, y su tratamiento es siempre quirúrgico (fistulotomía o sedón según la complejidad y el músculo esfinteriano comprometido). El absceso perianal cursa con dolor agudo e intenso, masa fluctuante, fiebre y signos inflamatorios marcados, no con secreción purulenta crónica intermitente como aquí. Ojo: la fisura anal crónica produce dolor intenso con la defecación más rectorragia escasa, sin orificio cutáneo con drenaje purulento. La hemorroide externa trombosada presenta nódulo violáceo doloroso en el margen anal, sin secreción purulenta ni orificio fistuloso. Antecedente de drenaje + orificio cutáneo + secreción crónica = fístula perianal.

PREGUNTA 112

Mujer de 30 años, sana, que desea lograr un embarazo, utiliza tiras reactivas de orina para detectar el aumento de la hormona luteinizante (LH). Hoy obtiene el pico máximo de LH en la prueba. ¿Aproximadamente cuántas horas después de este pico se espera que ocurra la ovulación en condiciones normales?

- A. 72
- B. 24
- C. 96
- D. 12

CLAVE: B

En el ciclo menstrual ovulatorio, el pico máximo de hormona luteinizante (LH) precede a la ovulación en aproximadamente 24 a 36 horas, siendo 24 horas el promedio. La cascada hormonal es la siguiente: el aumento del estradiol en la fase folicular tardía

dispara el pico de LH a través de retroalimentación positiva sobre la hipófisis, y este pico induce la ruptura del folículo dominante de Graaf con liberación del ovocito secundario. Este conocimiento es la base de los métodos de planificación familiar natural y de las técnicas de reproducción asistida. 72 horas (3 días) excede ampliamente el intervalo entre pico de LH y ovulación; corresponde a la duración total de la fase ovulatoria amplia, no al momento exacto. Ojo: 96 horas (4 días) es erróneo y subestima la fertilidad de los días post-pico. 12 horas subestima el intervalo: aunque la ovulación puede ocurrir en algunos casos en ese tiempo, el promedio descrito en la literatura es 24 horas. Conocer este intervalo permite a las parejas que buscan embarazo programar coitos efectivos en las 24-36 horas posteriores al pico de LH detectado por tira reactiva.

PREGUNTA 113

Varón de 32 años, con consumo diario de heroína por vía endovenosa desde hace 4 años, desea dejar de consumir. Refiere varios intentos de suspensión brusca con aparición de intenso malestar, insomnio y fuerte conducta adictiva, por lo que recae rápidamente. Acude a un centro especializado para iniciar un programa ambulatorio de mantenimiento farmacológico a largo plazo para su trastorno por uso de opioides. ¿Cuál es el medicamento de elección más adecuado?

- A. Metadona
- B. Diazepam
- C. Haloperidol
- D. Acido valproico

CLAVE: A

En el trastorno por uso de opioides con dependencia y múltiples intentos fallidos de suspensión, la metadona es el agonista opioide de larga duración utilizado en programas de mantenimiento ambulatorio. Su mecanismo se basa en ocupar los receptores μ con un perfil farmacocinético prolongado (vida media 24-36 horas) que evita los picos y valles de la heroína, suprime el síndrome de abstinencia y reduce el craving. Está respaldada por evidencia robusta como tratamiento que reduce mortalidad, conducta de riesgo y comorbilidad infecciosa (VIH, hepatitis C) asociada al uso endovenoso. El diazepam y otras benzodiacepinas pueden usarse para manejo sintomático puntual de la abstinencia pero no son tratamiento de mantenimiento; su uso prolongado genera dependencia y no actúa sobre los receptores opioides. El haloperidol es antipsicótico y no tiene rol en mantenimiento de adicción a opioides; podría usarse en casos de psicosis comórbida. El ácido valproico es estabilizador del ánimo en trastorno

bipolar y no aplica al trastorno por uso de opioides. La metadona y, alternativamente, la buprenorfina son los agonistas de elección en mantenimiento de adicción a opioides.

PREGUNTA 114

Mujer de 60 años desde hace 15 años con DM tipo 2 con control irregular, consulta por edema de miembros inferiores de 2 meses de evolución. Examen: PA 150/90 mmHg, edema con fóvea 2+/4+ en MMII, alopecia, sinovitis, fondo de ojo sin retinopatía diabética. Laboratorio: proteinuria de 5,4 g/24 h, C3 y C4 disminuidos. ¿Cuál es la conducta más adecuada a seguir?

- A. Solicitar solo control por oftalmología y repetir proteinuria en 6 meses
- B. Priorizar biopsia renal porque el resultado modificará el tratamiento
- C. Tratarla como nefropatía diabética con IECA/ARA II y estatinas
- D. Indicar pulsos de metilprednisolona y ciclofosfamida de inmediato

CLAVE: B

El cuadro plantea diagnóstico diferencial entre nefropatía diabética y nefritis lúpica. Los datos que orientan a una etiología distinta de la diabética son: proteinuria nefrótica masiva (5.4 g/24h), C3 y C4 disminuidos (la nefropatía diabética cursa con complemento normal), alopecia y sinovitis (datos extrarrenales sugestivos de LES), y sobre todo la ausencia de retinopatía diabética, que en pacientes con DM2 y nefropatía diabética típica suele estar presente. La biopsia renal es la herramienta indispensable porque su resultado modificará radicalmente el tratamiento (inmunosupresión específica vs manejo de DM2). Solicitar solo control oftalmológico y repetir proteinuria en 6 meses subestima la gravedad del cuadro y demora el diagnóstico de una posible nefritis lúpica progresiva. Tratarla como nefropatía diabética con IECA y estatinas ignora los datos discordantes (C3/C4 disminuidos, sinovitis, alopecia, ausencia de retinopatía) y puede dejar al paciente sin inmunosupresión específica si la causa real es lupus. Indicar pulsos de metilprednisolona y ciclofosfamida sin diagnóstico histológico es agresivo, expone a toxicidad sin certeza diagnóstica. La biopsia renal define conducta.

PREGUNTA 115

Lactante de 8 meses, traído al centro de salud por dificultad respiratoria de inicio súbito. Examen: irritable, tiraje subcostal marcado, quejido espiratorio. FR 70 x', SatO2 86% al aire ambiente. El establecimiento es de primer nivel y no cuenta con pediatra ni unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál es la mejor conducta inicial?

- A. Intentar intubación orotraqueal

- B. Administrar oxígeno y activar la referencia asistida
- C. Infundir fluidos EV y esperar para reevaluación
- D. Trasladar en auto particular con los padres

CLAVE: B

Lactante de 8 meses con dificultad respiratoria severa (FR 70, tiraje marcado, quejido, SatO₂ 86%) en un primer nivel sin pediatra ni UCI, la conducta correcta es estabilizar mientras se gestiona referencia: administrar oxígeno suplementario por cánula nasal o casco cefálico para corregir la hipoxemia, y activar inmediatamente el sistema de referencia asistida con ambulancia equipada y personal de salud que acompañe el traslado. La oxigenoterapia es la intervención que cambia el desenlace mientras llega el medio de transporte adecuado para llevar al niño a un centro con capacidad resolutive. Intentar intubación orotraqueal en primer nivel sin pediatra ni equipamiento adecuado es peligroso: la intubación pediátrica requiere experiencia, tubos de tamaño correcto y soporte ventilatorio que el establecimiento no tiene; un intento fallido puede resultar fatal. Infundir fluidos EV y esperar reevaluación retrasa la referencia y no resuelve la insuficiencia respiratoria; los fluidos no son la prioridad en este escenario respiratorio. Trasladar en auto particular con los padres es peligroso porque expone al niño a deterioro durante el traslado sin oxígeno ni soporte. Oxígeno + referencia asistida marca esto.

PREGUNTA 116

Tercigesta de 10 semanas por FUR confiable. Refiere dos partos pretérmino previos indoloros a las 22 y 25 semanas. Actualmente asintomática. Examen: útero acorde con 10 semanas, cérvix cerrado. Ecografía transvaginal: gestación intrauterina única de 10 semanas, longitud cervical 25 mm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A. Manejo expectante
- B. Cerclaje cervical
- C. Ritodrina
- D. Sulfato de Magnesio

CLAVE: B

En una gestante con dos antecedentes de parto pretérmino indoloros previos (a las 22 y 25 semanas) y longitud cervical de 25 mm en ecografía transvaginal a las 10 semanas, el diagnóstico es insuficiencia cervical y la conducta de elección es cerclaje cervical profiláctico (técnica de McDonald o Shirodkar) entre las 12 y 14 semanas, idealmente antes de que aparezca acortamiento progresivo o dilatación. Esta intervención reduce

significativamente la tasa de pérdida gestacional y parto pretérmino en pacientes con historia obstétrica de insuficiencia cervical demostrada. El manejo expectante en una paciente con dos antecedentes de pérdida gestacional indolora deja al embarazo actual sin protección frente a la recurrencia, conducta inaceptable cuando existe intervención eficaz disponible. Ojo: la ritodrina es un tocolítico beta-mimético utilizado para amenaza de parto pretérmino con dinámica activa, no para prevención en gestación temprana asintomática. El sulfato de magnesio se utiliza para neuroprotección fetal en pretérminos cercanos al parto y para eclampsia, no para prevención del parto pretérmino por insuficiencia cervical. Cerclaje cervical es lo que toca.

PREGUNTA 117

Antes de 2015, el virus del Zika producía solo pequeños brotes esporádicos y era poco relevante en salud pública. En 2015, se detectó en Brasil y se propagó rápidamente por varios países de las Américas, asociándose por primera vez con un aumento de casos de microcefalia en recién nacidos. ¿Qué término epidemiológico describe mejor la enfermedad por virus del Zika en este escenario?

- A. Emergente
- B. Infecciosa
- C. Endémica
- D. Reemergente

CLAVE: A

Las enfermedades emergentes son aquellas cuya aparición clínica en una población es nueva o cuya incidencia y/o distribución geográfica aumenta de manera significativa, presentando y además manifestaciones clínicas no descritas previamente. El virus del Zika cumple los tres criterios entre 2015 y 2016: aparición masiva en las Américas (donde no era endémico), incremento drástico de casos y, sobre todo, asociación nueva con microcefalia y síndrome congénito por Zika, manifestación no descrita antes. Por eso califica como enfermedad emergente. Que sea infecciosa describe su naturaleza microbiológica pero no su comportamiento epidemiológico nuevo. Endémica implica presencia constante con incidencia estable en una región, lo opuesto al patrón de propagación rápida y aparición de manifestaciones nuevas que mostró el Zika. Reemergente se aplica a patógenos previamente controlados que vuelven a aparecer en niveles preocupantes (como cólera o tuberculosis multirresistente), no al Zika que era prácticamente desconocido en magnitud antes de 2015. Aparición rápida + nuevas manifestaciones + nuevas regiones = enfermedad emergente.

PREGUNTA 118

Primigesta de 37 semanas, acude a emergencia por contracciones uterinas. Examen: PA 130/70 mmHg, FC 78 x'. AU 34 cm, LCF 144 x'. Tacto vaginal: D 4 cm, AP flotante, membranas íntegras. Pelvimetría: diámetro conjugado diagonal: 11 cm, espinas ciáticas prominentes, con diámetro interespinoso de 9 cm, ángulo subpúbico agudo. ¿Cuál es la indicación más adecuada?

- A. Manejo activo de labor de parto
- B. Realizar cesárea
- C. Prueba de bienestar fetal
- D. Amniorrexis y oxitocina

CLAVE: B

La pelvimetría clínica revela una pelvis estrecha en sus tres estrechos: conjugado diagonal de 11 cm (límite, conjugado obstétrico estimado en 9.5 cm, justo en el umbral de estrechez), espinas ciáticas prominentes con diámetro interespinoso de solo 9 cm (reducido, normal ≥ 10 cm), y ángulo subpúbico agudo (normal abierto, mayor de 90 grados). Sumado a la presentación cefálica flotante (sin encajamiento) en una primigesta de 37 semanas con contracciones, el cuadro configura desproporción cefalopélvica y la conducta es cesárea. El manejo activo del trabajo de parto requiere pelvis adecuada y descenso adecuado de la presentación, condiciones ausentes aquí; intentar trabajo de parto en estas condiciones expone a sufrimiento fetal y rotura uterina. Ojo: la prueba de bienestar fetal evalúa al feto pero no resuelve la barrera mecánica pélvica; pedirla solo retrasa la decisión. La amniorrexis con oxitocina sin pelvis adecuada perpetúa la distocia y aumenta el riesgo de complicaciones. Pelvis estrecha en los tres estrechos + presentación flotante = cesárea.

PREGUNTA 119

Varón de 63 años refiere que desde hace 2 meses le diagnostican anemia crónica, así como cambios en el ritmo evacuatorio. Palidez de piel. Le realizan colonoscopia y biopsia: diagnosticando adenocarcinoma en colon ascendente. TC de tórax, abdomen y pelvis: no evidencia de metástasis ganglionares ni a distancia. ¿Cuál es la conducta terapéutica de elección?

- A. Resección quirúrgica oncológica
- B. Inmunoterapia como tratamiento de primera línea
- C. Radioterapia pélvica externa

D. Quimioterapia adyuvante inmediata**CLAVE: A**

En adenocarcinoma de colon ascendente sin evidencia de metástasis ganglionares ni a distancia, la conducta terapéutica de elección con intención curativa es la resección quirúrgica oncológica: hemicolectomía derecha con linfadenectomía regional D2 que debe incluir al menos 12 ganglios linfáticos para estadificación adecuada según AJCC 8va edición. Este es el tratamiento estándar para cáncer de colon resecable, y la información postoperatoria del estadio definitivo (pTNM) determina la necesidad de quimioterapia adyuvante con esquemas FOLFOX o CAPOX en estadios III o II de alto riesgo. La inmunoterapia (anti-PD-1 como pembrolizumab) tiene rol en cáncer de colon metastásico con inestabilidad microsatelital alta o reparación de errores deficiente (MSI-H/dMMR), no como tratamiento de primera línea en enfermedad localizada resecable. Ojo: la radioterapia pélvica externa se utiliza en cáncer de recto bajo, no en cáncer de colon ascendente. La quimioterapia adyuvante inmediata sin cirugía previa no aplica: en cáncer de colon resecable la cirugía es siempre primero, y la adyuvancia se decide según estadio postoperatorio. Hemicolectomía derecha con linfadenectomía es el tratamiento curativo correcto.

PREGUNTA 120

Mujer 40 años sometida a miomectomía. En el postoperatorio presenta inestabilidad hemodinámica y requiere reintervención inmediata con posibilidad de histerectomía para evitar la muerte. La paciente está inconsciente y no hay familiares ni representantes presentes, por lo que no es posible obtener consentimiento informado. ¿Qué principio bioético respalda la decisión médica de realizar la cirugía de manera inmediata?

- A. Legalidad
- B. Beneficencia
- C. Autonomía
- D. Justicia

CLAVE: B

El principio bioético que respalda la decisión médica de intervenir de manera inmediata en una situación de urgencia vital, ante un paciente inconsciente y sin representantes presentes, es la beneficencia, entendida como la obligación ética de actuar buscando el mayor bien para el paciente, sobre todo cuando existe riesgo inminente de muerte. En el contexto de inestabilidad hemodinámica postoperatoria con necesidad de

reintervención salvadora, esperar el consentimiento informado expondría al paciente a daño irreversible, por lo que la beneficencia prevalece y la legislación (incluida la Ley General de Salud peruana) ampara este actuar. La legalidad describe la conformidad con la norma jurídica pero no es un principio bioético; el principio que justifica la acción es ético, no jurídico. La autonomía exige el consentimiento informado del paciente o su representante, justamente lo que no es posible en este caso por la inconsciencia y la ausencia de familiares; la urgencia vital suspende temporalmente la autonomía a favor de la beneficencia. La justicia se refiere a la distribución equitativa de recursos y oportunidades en salud, no aplica aquí donde el problema es individual y de urgencia. La beneficencia es el principio rector ante urgencia con paciente sin capacidad de decidir.

PREGUNTA 121

Primigesta de 36 semanas, en trabajo de parto fase latente. Refiere pérdida de líquido amniótico hace 24 horas. Examen: T 38, 5 °C. El monitoreo fetal intraparto muestra patrón sinusoidal sostenido durante más de 20 minutos y bradicardia fetal. ¿Cuál es la conducta a seguir?

- A. Término de gestación
- B. Tocolisis
- C. Manejo expectante
- D. Uso de sulfato de magnesio

CLAVE: A

El patrón sinusoidal sostenido en el monitoreo fetal es categoría III (patológico) según la clasificación de la NICHD, y refleja anemia fetal severa, hipoxia profunda o sufrimiento fetal terminal. Combinado con bradicardia fetal y fiebre materna (T 38.5) en contexto de RPM de 24 horas (con sospecha de corioamnionitis), el cuadro indica pérdida de bienestar fetal con riesgo inminente de muerte fetal intraútero. La conducta es término de gestación inmediato por la vía más rápida disponible (cesárea de emergencia en la mayoría de los casos) para salvar al feto. La tocolisis está formalmente contraindicada cuando hay patrón fetal categoría III: prolongar la gestación con el feto sufriendo es inaceptable. El manejo expectante perpetúa el sufrimiento fetal y la progresión de la corioamnionitis materna, con riesgo de muerte fetal y sepsis materna. El sulfato de magnesio puede usarse como neuroprotección en pretérminos menores de 32 semanas pero a las 36 semanas no aporta beneficio claro y no resuelve la urgencia fetal; y además no aborda el problema de fondo que es la pérdida del bienestar fetal. Término de gestación inmediato es la única conducta correcta.

PREGUNTA 122

Un centro de salud, al analizar su situación, identifica el siguiente problema: "baja cobertura de actividades de promoción de la salud y de prevención de enfermedades en su población adscrita". De acuerdo con la formulación de problemas priorizados en salud pública, este enunciado corresponde principalmente a:

- A. debilidad estructural
- B. enfermedad priorizada
- C. debilidad organizacional
- D. poblaciones o grupo población priorizado

CLAVE: C

En la formulación de problemas priorizados en salud pública, la baja cobertura de actividades de promoción y prevención corresponde a una debilidad organizacional, porque refleja un déficit en la capacidad operativa del establecimiento para llevar adelante actividades programáticas que son parte de su cartera de servicios. No se trata de un problema de infraestructura física (debilidad estructural), ni de una enfermedad específica (enfermedad priorizada como anemia o tuberculosis), ni de un grupo poblacional con vulnerabilidad particular (poblaciones priorizadas), sino de un problema de gestión interna que afecta los procesos sustantivos del establecimiento. La debilidad estructural describe limitaciones de infraestructura, equipamiento o recurso humano disponible (capacidad instalada), no de procesos. La enfermedad priorizada se refiere a problemas de salud específicos definidos como prioridad nacional o local (DM, HTA, anemia, TB), pero el enunciado del problema es de cobertura de actividades, no de una enfermedad específica. Las poblaciones o grupos priorizados se refieren a colectivos definidos por edad, sexo, condición socioeconómica o vulnerabilidad. Bajo desempeño en cobertura de actividades programáticas = debilidad organizacional.

PREGUNTA 123

Múltipara de 68 años, sexualmente activa, consulta por sensación de "bulto vaginal", presión pélvica y disfunción miccional. Examen ginecológico: cistocele grado II, rectocele grado III, hiperlaxitud del introito y periné amplio. ¿Cuál es el abordaje quirúrgico más adecuado?

- A. Suspensión uterosacra anterior
- B. Histerectomía vaginal simple sin colporrafia
- C. Colpocleisis total sin corrección del periné

D. Colporrafia anterior y posterior con perineorrafia**CLAVE: D**

En una multipara sexualmente activa con prolapso de órganos pélvicos que combina cistocele grado II, rectocele grado III, hiperlaxitud del introito y periné amplio, el abordaje quirúrgico más completo es la colporrafia anterior (corrige el cistocele) más colporrafia posterior (corrige el rectocele) más perineorrafia (corrige la hiperlaxitud del introito y reconstruye el cuerpo perineal). Esta combinación restaura la anatomía vaginal y perineal sin sacrificar la funcionalidad sexual de la paciente, que es activa. La suspensión uterosacra anterior aborda fundamentalmente el prolapso apical (uterino o de cúpula), no el cistocele o rectocele significativo. La histerectomía vaginal simple sin colporrafia no soluciona los defectos de pared anterior y posterior, y deja el problema funcional sin resolver. La colpocleisis total sin corrección del periné es procedimiento obliterativo que cierra la vagina, indicado solo en pacientes muy mayores que ya no tendrán actividad sexual; está contraindicado en esta paciente sexualmente activa. Colporrafia + perineorrafia es la corrección anatómica y funcional adecuada.

PREGUNTA 124

En un centro de salud del Ministerio de Salud, un odontólogo atiende a un paciente afiliado a una IAFAS de las Fuerzas Armadas que requiere una cirugía bucal compleja, que solo se realiza en un hospital de EsSalud. Aunque sí existen convenios de intercambio prestacional. Sin embargo, al intentar gestionar la referencia, el odontólogo encuentra múltiples dificultades en la coordinación y aceptación de la referencia. ¿Cuál es el principal factor estructural del sistema de salud peruano que explica estas dificultades para concretar el intercambio prestacional?

- A. Fragmentación del sistema, cada IAFAS opera su propia red de servicios de salud, con débil articulación entre ellas
- B. Falta de capacitación exclusiva del odontólogo sobre los procedimientos de referencia y contrarreferencia
- C. Inexistencia de un Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) común para todas las IAFAS
- D. Competencia directa entre el Minsa y EsSalud por el financiamiento de las prestaciones de salud por las IAFAS

CLAVE: A

El sistema de salud peruano se caracteriza por una fragmentación estructural histórica donde coexisten múltiples Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en

Salud (IAFAS): MINSA-SIS, EsSalud, Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y los seguros privados, cada una con su propia red de prestadores, sus propios reglamentos administrativos, su propio tarifario y, frecuentemente, débil articulación operativa entre ellas. Esta fragmentación es el factor estructural principal que dificulta el intercambio prestacional, aun cuando los convenios formales existan. La falta de capacitación del odontólogo sobre procedimientos de referencia es un factor operativo individual, no estructural del sistema. La inexistencia de un PEAS común no aplica porque sí existe un Plan Esencial de Aseguramiento en Salud que debería garantizar prestaciones mínimas a todos los asegurados, aunque la implementación efectiva varía. La competencia directa entre MINSA y EsSalud por financiamiento es parcial y secundaria al problema de fondo. Fragmentación con redes paralelas y débil articulación es el diagnóstico estructural canónico del sistema peruano.

PREGUNTA 125

Varón de 87 años, sometido hace 1 hora a resección transuretral de próstata bajo anestesia raquídea con irrigación continua de solución hipotónica, presenta en el postoperatorio inmediato agitación psicomotriz, desorientación y una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada. Examen: presión arterial estable sin focalización neurológica. La causa más frecuente asociada a este cuadro clínico es aguda.

- A. hipomagnesemia
- B. hipokalemia
- C. hiponatremia
- D. hipocalcemia

CLAVE: C

El cuadro corresponde al síndrome de resección transuretral de próstata (síndrome RTU), complicación clásica del uso de soluciones de irrigación hipotónicas (clásicamente glicina al 1.5%) durante la RTU prostática. La absorción intravascular de gran cantidad de solución hipotónica genera una hiponatremia aguda dilucional (sodio sérico cae rápidamente) que desencadena edema cerebral, manifestándose con agitación psicomotriz, desorientación, convulsiones tónico-clónicas, alteraciones visuales y, en casos severos, coma y muerte. La presión arterial puede mantenerse estable inicialmente pese al cuadro neurológico florido. La hipomagnesemia y la hipocalcemia pueden generar tetania o convulsiones pero no se asocian al uso de soluciones hipotónicas en RTU prostática y no son la causa típica del síndrome. La hipokalemia

produce debilidad muscular, arritmias y, en casos severos, parálisis flácida, no convulsiones tónico-clónicas con agitación como cuadro predominante. La hiponatremia aguda dilucional es la marca distintiva del síndrome RTU y obliga a corrección con solución salina hipertónica al 3% bajo monitoreo estricto, idealmente en UCI, para evitar la mielinólisis pontina central por corrección excesivamente rápida.

PREGUNTA 126

Varón de 35 años acude a consulta por dispepsia y trae un informe reciente que confirma infección por *Helicobacter pylori*. Usted sabe que vive en una zona donde la resistencia a claritromicina es mayor al 15%. ¿Cuál es el esquema de primera elección para la erradicación de *H. pylori* en este contexto?

- A. Inhibidor de bomba de protones + sucralfato + doxiciclina
- B. Inhibidor de bomba de protones + bismuto + tetraciclina + metronidazol
- C. Inhibidor de bomba de protones + levofloxacino
- D. Inhibidor de bomba de protones + claritromicina + amoxicilina + metronidazol

CLAVE: B

En zonas con resistencia a claritromicina mayor al 15%, las guías de Maastricht VI y la ACG recomiendan abandonar la triple terapia clásica y utilizar como primera línea la cuádruple terapia con bismuto durante 14 días: IBP a dosis estándar dos veces al día + subsalicilato de bismuto 525 mg cuatro veces al día + tetraciclina 500 mg cuatro veces al día + metronidazol 250-500 mg cuatro veces al día. Este esquema mantiene tasas de erradicación superiores al 90% incluso en regiones de alta resistencia, y es sobre todo útil en el Perú donde la prevalencia de resistencia a claritromicina es elevada. La duración de 14 días es crítica para optimizar la erradicación. El IBP con sucralfato y doxiciclina no es esquema reconocido para *H. pylori*; el sucralfato es protector de mucosa pero no antimicrobiano efectivo contra el organismo. El IBP con levofloxacino sería terapia de segunda línea (terapia de rescate con fluoroquinolona) tras falla de cuádruple terapia, no primera elección. El IBP con claritromicina, amoxicilina y metronidazol es la triple o cuádruple concomitante con claritromicina, contraindicada cuando la resistencia a claritromicina supera 15% por baja eficacia. Cuádruple con bismuto: esa pista no falla.

PREGUNTA 127

Primigesta de 19 años, acude por primera vez a control prenatal a las 22 semanas de gestación. No cuenta con controles previos, presenta anemia moderada y refiere vivir en zona rural con bajo acceso a servicios de salud. De acuerdo con las normas

nacionales de atención prenatal ¿cuál es el principal factor de riesgo obstétrico que tiene la paciente?

- A. Residencia en zona rural alejada
- B. Condiciones socioeconómicas bajas
- C. Inicio tardío del control prenatal
- D. Edad materna de 19 años

CLAVE: C

El principal factor de riesgo obstétrico identificable y modificable en esta paciente es el inicio tardío del control prenatal, ya que ingresó al sistema de salud recién a las 22 semanas de gestación, cuando ya transcurrió más de la mitad del embarazo sin tamizajes ni intervenciones preventivas. La NTS 105-MINSA/DGSP-V.01 (Atención Integral de Salud Materna) establece que el primer control prenatal debe realizarse antes de las 14 semanas, con un mínimo de 6 controles durante toda la gestación, para detectar precozmente patologías, iniciar suplementación con ácido fólico y hierro, planificar tamizajes infecciosos (VIH, sífilis, hepatitis B) y educar sobre signos de alarma. El inicio tardío es responsable de la anemia moderada no detectada ni tratada. La residencia en zona rural alejada es factor contextual de riesgo pero no es clasificada como factor obstétrico modificable individual; el control prenatal puede gestionarse con estrategias específicas para este contexto (visitas domiciliarias, casas de espera). Las condiciones socioeconómicas bajas son determinante social pero, similarmente, no son el factor obstétrico primario que se evalúa según normas. La edad materna de 19 años está dentro del rango fisiológico (13-19 sería adolescencia tardía aceptable obstétricamente), no es factor de riesgo principal. Inicio tardío del control prenatal es el factor de mayor peso modificable.

PREGUNTA 128

En un centro de salud de zona cálida, un niño de 8 años con diagnóstico confirmado de fibrosis quística consulta por debilidad intensa, mareos y vómitos de 24 horas de evolución. La madre refiere que el niño ha estado jugando al aire libre con sudoración muy abundante. Recibe desde hace 6 horas solución salina EV al 0, 45%. Examen: PA 85/50 mmHg, FC 120 x', mucosas muy secas, llenado capilar lento. Laboratorio: Na⁺ sérico 124 mEq/L, K⁺ sérico 3,6 mEq/L, creatinina normal, Na⁺ urinario 8 mEq/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada respecto al manejo de líquidos en este paciente?

- A. Suspender los líquidos EV y manejar solo con restricción de sal en la dieta
- B. Continuar la infusión de solución salina al 0, 45% al mismo ritmo

C. Cambiar a NaCl 0, 9% en bolo inicial seguido de infusión continua

D. Iniciar solución glucosada al 5% sin electrolitos para evitar mayor sobrecarga de sodio

CLAVE: C

El paciente con fibrosis quística sufre crisis pierde sal en zona cálida con sudoración abundante: hiponatremia hipovolémica (Na 124, sodio urinario 8 mEq/L que confirma pérdida extrarrenal) con signos de hipoperfusión (PA 85/50, taquicardia, llenado capilar lento, mucosas secas). La conducta es expandir volumen y reponer sodio con solución salina isotónica al 0.9% en bolo inicial de 20 mL/kg, seguido de infusión continua según evolución. La SS al 0.45% que recibía es hipotónica y agrava la hiponatremia, no la corrige; por eso se debe cambiar a SS al 0.9% para reanimación adecuada. Suspender líquidos EV y manejar con restricción de sal en la dieta es contraindicado: el paciente está hipovolémico y necesita reposición agresiva, no restricción. Continuar SS al 0.45% perpetúa la hiponatremia hipotónica y empeora el cuadro. La solución glucosada al 5% sin electrolitos es agua libre que rápidamente sale del intravascular, no expande volumen ni corrige sodio, y empeora la hiponatremia dilucional. Pacientes con FQ en zonas cálidas requieren suplementación de sal y reposición isotónica en crisis.

PREGUNTA 129

Varón de 40 años, con antecedente de uso crónico de AINEs por gonalgia, acude a emergencia por dolor epigástrico súbito muy intenso, de 2 horas de evolución, asociado a náuseas. Examen: PA 100/60 mmHg, FC 108 x', T 37, 5 °C, abdomen con defensa muscular generalizada y dolor intenso a la palpación. Rx de tórax en bipedestación: aire libre subdiafragmático. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A. Test de ureasa

B. Laparotomía exploratoria

C. Manejo conservador con analgésicos

D. Endoscopia digestiva alta

CLAVE: B

Como repetimos siempre en clase, úlcera péptica perforada en paciente con uso crónico de AINEs: dolor epigástrico súbito intenso, abdomen en tabla con defensa generalizada (peritonitis química y bacteriana), fiebre baja, taquicardia y, sobre todo, neumoperitoneo evidente con aire libre subdiafragmático en la radiografía de tórax en bipedestación. La conducta correcta es laparotomía exploratoria urgente, idealmente con reanimación hídrica y antibioticoterapia perioperatoria, para reparar la perforación con parche de

Graham (epiplón) y lavado peritoneal extenso. El test de ureasa diagnostica H. Ojo: pylori pero es completamente irrelevante en una emergencia quirúrgica; pedirlo retrasa la cirugía vital. El manejo conservador con analgésicos en úlcera péptica perforada con peritonitis y neumoperitoneo es peligroso y solo se considera en pacientes muy seleccionados con perforación contenida y muy alto riesgo quirúrgico. La endoscopia digestiva alta está contraindicada en sospecha de perforación porque la insuflación puede convertir una perforación contenida en una libre, y y además no aporta utilidad terapéutica en la urgencia. Laparotomía esa pista no falla.

PREGUNTA 130

Usted es director de la Dirección Regional de Salud y debe priorizar un establecimiento de salud del primer nivel para implementar el programa de mejora de servicios del MINSA, de acuerdo con los lineamientos nacionales vigentes sobre categorización. En un primer momento. ¿Cuál establecimiento debería ser priorizado?

- A. Puesto de Salud, categoría I-1, sin función de puerta de entrada
- B. Hospital Regional Docente Materno Infantil
- C. Hospital de Apoyo
- D. Centro de Salud, categoría I-3

CLAVE: D

En el sistema de salud peruano, los establecimientos de primer nivel se clasifican en categorías I-1 (Puesto de Salud sin médico), I-2 (Puesto de Salud con médico), I-3 (Centro de Salud sin internamiento) y I-4 (Centro de Salud con internamiento). El Centro de Salud categoría I-3 cumple función de puerta de entrada al sistema con consulta médica, atención de emergencias básicas y referencia organizada, lo que lo hace el establecimiento priorizado para programas de mejora del primer nivel, ya que articula la atención primaria y resuelve mayor volumen de demanda comparado con los puestos I-1. El Puesto de Salud I-1 sin función de puerta de entrada tiene capacidad resolutoria limitada y no es prioridad para programas de mejora estructural; primero se fortalecen los I-3 y I-4. El Hospital Regional Docente Materno Infantil corresponde al tercer nivel de atención (III-1 o III-2), no al primer nivel; está fuera del marco de la pregunta. El Hospital de Apoyo pertenece al segundo nivel (II-1 o II-2), no al primer nivel; tampoco aplica. El Centro de Salud I-3 es el escalón más operativo del primer nivel y la elección priorizada.

PREGUNTA 131

Mujer de 22 años acude a Emergencia por palpitaciones, debilidad y calambres musculares. Refiere que desde hace 6 meses recibe un preparado magistral para "bajar de peso", con pérdida de 16 kg en ese periodo. Examen: ansiosa, disnea leve, PA 100/70 mmHg, FC 110 x', pulso irregular. Gasometría arterial: alcalosis metabólica. Laboratorio: K sérico 2, 6 mEq/L. Orina: pH 5, Na 40 mEq/L, K 30 mEq/L. EKG: ondas U prominentes con depresión del ST. ¿Cuál es el componente del preparado magistral que explica el cuadro?

- A. Anorexígenos con efecto simpaticomimético
- B. Triyodotironina a dosis altas
- C. Complejo polivitamínico a dosis altas
- D. Diuréticos de asa como la furosemida

CLAVE: D

El sello clínico aquí: hipokalemia severa (K 2, 6) con alcalosis metabólica, ondas U prominentes y depresión del ST en EKG, en una paciente con preparado magistral para bajar de peso. La presencia de potasio urinario elevado (30 mEq/L, lo esperable en pérdida renal de potasio mayor a 20 mEq/L) junto con sodio urinario elevado (40 mEq/L) y alcalosis metabólica son patrón característico del uso de diuréticos de asa como furosemida, que aumentan la excreción renal de potasio, sodio y cloro, generando y además contracción de volumen e hipokalemia con alcalosis hipoclorémica. Los anorexígenos simpaticomiméticos producen taquicardia, ansiedad e hipertensión pero no causan hipokalemia con perfil urinario de pérdida renal y alcalosis metabólica. La triyodotironina a dosis altas genera hipertiroidismo iatrogénico con taquicardia, pérdida de peso y ansiedad, pero la hipokalemia que produce es por desplazamiento intracelular y no se acompaña típicamente de potasio urinario elevado ni alcalosis con sodio urinario alto. Los complejos polivitamínicos a dosis altas no producen este síndrome. Hipokalemia + alcalosis + K urinario alto + Na urinario alto + pérdida de peso = diuréticos de asa.

PREGUNTA 132

Niña de 2 años, previamente sana, con 2 días de diarrea acuosa sin sangre. Presenta buen estado general, está activa, con ojos ligeramente hundidos y mucosas orales secas, bebe líquidos con avidez y orina algo menos que lo habitual. No tiene vómitos persistentes ni fiebre alta. ¿Cuál es la medida más importante en su manejo inicial?

- A. Antibióticos orales
- B. Antiemético y antidiarreico
- C. Sales de rehidratación oral (SRO)

D. Hidratación EV

CLAVE: C

En diarrea aguda con deshidratación leve a moderada (clasificación tipo Plan B según AIEPI: ojos hundidos, mucosas secas, bebe con avidez, ánimo conservado), la medida más importante es la rehidratación oral con sales de rehidratación oral (SRO) a dosis de 75 mL/kg en 4 horas según protocolo OMS, reevaluando cada hora. Las SRO de baja osmolaridad (75 mEq/L de sodio, osmolaridad total 245 mOsm/L) recomendadas por OMS y UNICEF son seguras, eficaces y costo-efectivas en el primer nivel, y deben ser la primera línea en cualquier diarrea con deshidratación que pueda tomar líquidos. Los antibióticos orales no están indicados en diarrea aguda viral acuosa sin sangre (la mayoría son por rotavirus o norovirus en niños), y se reservan para diarrea bacteriana específica con disentería o sospecha de cólera/shigella. Los antieméticos y antidiarreicos son controvertidos en pediatría: el ondansetrón puede usarse para vómitos persistentes en emergencia, pero no es la medida principal; los antidiarreicos como loperamida están contraindicados en niños pequeños por riesgo de íleo paralítico. La hidratación endovenosa se reserva para deshidratación severa con choque o intolerancia oral, escenarios distintos al descrito.

PREGUNTA 133

Lactante de 9 meses, nacido por parto en presentación podálica, sin otros antecedentes relevantes. Los padres refieren que, al gatear, parece arrastrar la pierna izquierda. Al examen físico se encuentra limitación de la abducción de la cadera izquierda y aparente acortamiento de la extremidad inferior izquierda. Se sospecha displasia del desarrollo de la cadera. ¿Cuál es la indicación más adecuada?

- A. Solicitar radiografía de pelvis y caderas
- B. Iniciar uso de arnés de Pavlik de manera inmediata
- C. Solicitar ecografía de caderas
- D. Continuar observación y reevaluar en 3 meses

CLAVE: A

En lactante mayor de 4 a 6 meses con sospecha clínica de displasia del desarrollo de cadera (parto podálico es factor de riesgo, limitación de abducción, aparente acortamiento de pierna), la herramienta diagnóstica de elección es la radiografía de pelvis y caderas en proyección anteroposterior. A esta edad ya se ha completado la osificación del núcleo cefálico femoral y la radiografía permite evaluar el índice acetabular, las líneas de Hilgenreiner, Perkins y Shenton, y clasificar el grado de displasia

o luxación según la escala de Tönnis. El arnés de Pavlik tiene su indicación en menores de 6 meses con cadera reducible o luxable detectable por maniobras de Ortolani-Barlow; iniciarlo a los 9 meses sin diagnóstico anatómico claro es subóptimo y puede ser ineficaz si hay luxación irreductible. La ecografía de caderas es de elección en menores de 4-6 meses, antes de la osificación del núcleo cefálico, donde la radiografía no es concluyente; a los 9 meses la radiografía la supera. Continuar observación y reevaluar en 3 meses es peligroso porque retrasa el diagnóstico en una ventana crítica para tratamiento. Radiografía de pelvis eso es lo que cae siempre.

PREGUNTA 134

Mujer de 34 años, consulta por infertilidad primaria de 2 años de evolución. Tras la evaluación inicial, su ginecólogo decide iniciar tratamiento con citrato de clomifeno por vía oral y luego de varios ciclos, la paciente logra gestar. ¿Cuál fue el factor más probable de su infertilidad?

- A. Cervical
- B. Ovulatorio
- C. Uterino
- D. Tubárico

CLAVE: B

El citrato de clomifeno es un modulador selectivo de los receptores de estrógeno (SERM) que actúa bloqueando los receptores estrogénicos hipotalámicos, lo que estimula la liberación pulsátil de GnRH y, consecuentemente, FSH y LH hipofisarias, induciendo la maduración folicular y la ovulación. Es el tratamiento de primera línea en infertilidad por anovulación crónica, sobre todo en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Si la paciente logró gestar tras varios ciclos de clomifeno, esto demuestra que el factor de infertilidad era ovulatorio. El factor cervical (moco cervical hostil, estenosis cervical) se trata con inseminación intrauterina o procedimientos cervicales, no con clomifeno. El factor uterino (miomas, sinequias intracavitarias, malformaciones uterinas) requiere intervención quirúrgica histeroscópica o miomectomía, no inducción de la ovulación. El factor tubárico (obstrucción tubárica por EPI previa) requiere FIV o salpingoplastia, ya que el clomifeno no resuelve un problema mecánico tubárico. Que el clomifeno haya resuelto la infertilidad es prueba diagnóstica retrospectiva del factor ovulatorio.

PREGUNTA 135

Varón de 58 años, con diabetes mellitus tipo 2 mal controlada (HbA1c 9, 5%), es sometido a apendicectomía abierta. A las 36 horas de la cirugía, el examen de la herida muestra bordes algo edematosos, eritema leve y exudado serohemático escaso, sin signos de colección purulenta ni dehiscencia. A nivel histológico ¿en qué fase de la cicatrización se encuentra predominantemente la herida quirúrgica de este paciente?

- A. Inflamatoria temprana
- B. Remodelación de la matriz extracelular
- C. Epitelización avanzada
- D. Fibroblástica (proliferativa)

CLAVE: A

A las 36 horas de una herida quirúrgica, la cicatrización se encuentra predominantemente en la fase inflamatoria temprana, también llamada fase exudativa, que abarca aproximadamente del día 0 al día 3 postlesión. Esta fase se caracteriza por vasodilatación local, aumento de la permeabilidad capilar, exudado serohemático con migración de neutrófilos y luego macrófagos, y los signos clínicos descritos: bordes edematosos, eritema leve y exudado escaso. El paciente diabético mal controlado puede tener prolongación o alteración de esta fase por defecto en la quimiotaxis y fagocitosis. La fase de remodelación de la matriz extracelular ocurre desde el día 21 hasta meses después, donde el colágeno tipo III es reemplazado progresivamente por colágeno tipo I y la cicatriz adquiere su resistencia tensil definitiva, escenario muy posterior al actual. La epitelización avanzada se produce desde el día 4-5 hacia adelante, con cobertura del defecto cutáneo, y aún no se ha alcanzado a las 36 horas. La fase fibroblástica o proliferativa ocurre del día 3 al 21, con formación de tejido de granulación, depósito de colágeno III y angiogénesis, también posterior al momento actual. 36 horas = fase inflamatoria temprana.

PREGUNTA 136

Varón de 45 años con falla hepática aguda secundaria a intoxicación por paracetamol, desarrolla encefalopatía grado III con edema cerebral confirmado por TC más hipertensión intracraneal refractaria al manejo médico convencional. Es admitido a UCI. ¿Qué soporte avanzado de vida es el más importante para el manejo de la hipertensión intracraneal en este paciente?

- A. Monitoreo continuo de presión intracraneal (PIC)
- B. Hiperventilación profiláctica prolongada
- C. Infusión continua de manitol al 20%

D. Inducción de hipotermia terapéutica moderada

CLAVE: C

En falla hepática aguda con encefalopatía grado III-IV y edema cerebral con hipertensión intracraneal refractaria al manejo convencional, la infusión de manitol al 20% endovenosa (0.25 a 1 g/kg en bolo o infusión continua) es el soporte farmacológico más importante. El manitol genera un gradiente osmótico que arrastra agua del cerebro hacia el plasma, reduciendo el edema cerebral y la presión intracraneal en cuestión de minutos a horas. Es la terapia hiperosmolar de primera línea junto con la solución salina hipertónica al 3%, y forma parte del manejo escalonado de hipertensión intracraneal. El monitoreo continuo de PIC mediante catéter intraventricular o sensor parenquimatoso es útil para guiar terapia escalonada y aceptable como soporte avanzado en algunos centros, pero su uso en falla hepática aguda es controversial por el riesgo de hemorragia intracraneal asociada a coagulopatía severa, y no es por sí mismo terapéutico. La hiperventilación profiláctica prolongada está formalmente contraindicada porque genera vasoconstricción cerebral excesiva con isquemia secundaria; solo se usa puntualmente como medida temporizadora frente a herniación inminente. La hipotermia terapéutica moderada tiene evidencia limitada y no está estandarizada en falla hepática aguda. Entre las opciones, el manitol al 20% es la intervención específica que reduce activamente la presión intracraneal mediante gradiente osmótico.

PREGUNTA 137

Secundigesta añosa, de 11 semanas de gestación. Acude a control prenatal asintomática. Antecedente de preeclampsia en embarazo anterior y diagnóstico de síndrome antifosfolipídico. Examen: PA 130/80 mmHg, IMC 30 kg/m². Ecografía transvaginal doppler: resistencia aumentada de ambas arterias uterinas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A. Restricción de sal en la dieta
- B. Profilaxis con antihipertensivos
- C. Inicio de ácido acetilsalicílico
- D. Suplementos de vitamina C

CLAVE: C

En gestante con múltiples factores de riesgo para preeclampsia (antecedente personal de preeclampsia, síndrome antifosfolipídico, edad mayor, IMC 30 con obesidad, alteración de doppler uterino con resistencia aumentada), está indicado iniciar ácido acetilsalicílico (AAS) a dosis bajas (100-150 mg/día) entre las 12 y 16 semanas y

mantenerlo hasta la semana 36 o el parto. La evidencia ASPRE y otros metaanálisis muestran reducción significativa (mayor del 60%) de preeclampsia precoz cuando el AAS se inicia oportunamente en pacientes de alto riesgo. La restricción de sal en la dieta no ha demostrado reducir el riesgo de preeclampsia y puede ser contraproducente; las guías actuales no la recomiendan como medida preventiva. La profilaxis con antihipertensivos no se justifica en una paciente con PA 130/80 mmHg que está dentro del rango normal-alto pero no hipertensa franca; los antihipertensivos se inician cuando hay HTA documentada, no como prevención de preeclampsia. Los suplementos de vitamina C y E no han demostrado eficacia en prevención de preeclampsia y no se recomiendan. AAS a dosis bajas aquí no hay vuelta.

PREGUNTA 138

Niño de 6 años, presenta hipotensión arterial, hipoxemia y acidosis láctica, durante un estatus epiléptico. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico más probable que explique en conjunto estas alteraciones?

- A. Infección bacteriana sistémica con liberación de mediadores inflamatorios
- B. Hipoglucemia secundaria a ayuno prolongado previo a la crisis
- C. Reacción adversa grave a anticonvulsivos administrados
- D. Aumento del consumo de oxígeno y alteración ventilatoria

CLAVE: D

En el estatus epiléptico (crisis de duración mayor de 5 minutos o crisis recurrentes sin recuperación de conciencia entre ellas), el mecanismo fisiopatológico que explica simultáneamente hipotensión, hipoxemia y acidosis láctica es el aumento masivo del consumo de oxígeno por la actividad muscular y neuronal sostenida, junto con alteración ventilatoria por compromiso de la mecánica respiratoria durante las contracciones tónico-clónicas. La demanda metabólica neuronal supera el aporte y se genera glicólisis anaeróbica con producción aumentada de lactato, mientras la hipoventilación contribuye a hipoxemia e hipercapnia. La infección bacteriana sistémica con liberación de mediadores inflamatorios podría producir un cuadro similar pero requiere foco infeccioso identificable, fiebre y otros signos de sepsis no descritos en el caso. La hipoglucemia secundaria a ayuno produciría convulsión pero no explicaría hipotensión y acidosis láctica como conjunto; y además se descartaría con glucometría inmediata. Las reacciones adversas a anticonvulsivos pueden producir efectos hemodinámicos pero no son la explicación predominante de la triada metabólica del estatus epiléptico. Aumento del consumo de O₂ y alteración ventilatoria esa pista no falla.

PREGUNTA 139

Niño de 5 años, previamente sano, es llevado a consulta porque sus padres notan "que sus pies son planos". Niega dolor, cansancio al caminar o limitaciones en sus actividades. Examen: pie plano bilateral, arco medial que reaparece al caminar de puntillas, sin acortamiento del tendón de Aquiles ni otras alteraciones neurológicas u ortopédicas. ¿Cuál es la acción más adecuada?

- A. Plantillas ortopédicas rígidas de forma inmediata
- B. Tranquilizar a los padres y explicar que es normal para su edad
- C. Estudios de imagen (radiografía) y referir a ortopedia pediátrica
- D. Fisioterapia y ejercicios correctivos

CLAVE: B

El pie plano flexible asintomático en un niño de 5 años con arco medial que reaparece al caminar de puntillas, sin dolor, sin acortamiento del tendón de Aquiles ni alteraciones neurológicas, es una variante anatómica fisiológica que no requiere tratamiento ortopédico ni intervención. La conducta correcta es tranquilizar a los padres, explicar que el arco plantar se desarrolla progresivamente entre los 3 y los 6 años en la mayoría de los niños (AAP, Pediatrics 2018), y continuar con seguimiento clínico habitual. Solo cuando hay dolor, fatiga importante con actividad o pie plano rígido se requiere evaluación ortopédica. Indicar plantillas ortopédicas rígidas de forma inmediata en un niño con pie plano flexible asintomático no tiene base en evidencia y genera dependencia y costos innecesarios; estudios randomizados no muestran beneficio sobre el desarrollo del arco. Solicitar estudios de imagen y referir a ortopedia pediátrica está indicado solo en pie plano rígido (no se corrige al caminar de puntillas), doloroso o con asimetría marcada. La fisioterapia y ejercicios correctivos pueden ayudar en pie plano sintomático, pero en este caso asintomático no son necesarios. Tranquilizar y vigilar es lo que toca.

PREGUNTA 140

En una comunidad urbana de Lima, un médico del primer nivel de atención identifica que aproximadamente el 40% de los adolescentes de 15 a 19 años consume alcohol al menos una vez por semana. En una reunión con padres, docentes y autoridades locales, se reconocen como factores importantes la falta de actividades recreativas organizadas y el fácil acceso a bebidas alcohólicas en comercios cercanos a las escuelas. El médico propone una intervención basada en los principios de promoción de la salud. ¿Cuál es la estrategia más efectiva?

- A. Realizar charlas mensuales sobre riesgos del consumo de alcohol
- B. Establecer un sistema de vigilancia e imponer multas a comercios
- C. Distribuir folletos informativos sobre los daños del alcohol
- D. Programa con enfoque integral educativo, comunitario y regulatorio

CLAVE: D

En promoción de la salud, los problemas con múltiples determinantes (en este caso, falta de actividades recreativas, fácil acceso a alcohol en comercios cercanos a escuelas y vacíos regulatorios) requieren estrategias integrales que combinan los pilares de la Carta de Ottawa: educación para la salud (componente educativo en escuelas y familias), reorientación de los servicios y entorno saludable (componente comunitario con actividades recreativas alternativas) y políticas públicas saludables (componente regulatorio con control de venta de alcohol cerca de escuelas, fiscalización y multas a comercios infractores). Realizar charlas mensuales sobre riesgos es solo el componente educativo, insuficiente cuando el problema tiene determinantes ambientales y regulatorios fuertes. Establecer un sistema de vigilancia con multas a comercios es solo el componente regulatorio, también insuficiente sin educación y oferta de alternativas recreativas. Distribuir folletos informativos es la estrategia con menor impacto demostrado en cambios de comportamiento adolescente. La intervención integral con enfoque educativo, comunitario y regulatorio es la única que aborda los determinantes múltiples del problema y tiene mayor probabilidad de impacto sostenible. Esta estrategia se alinea con el Plan Nacional de Salud Mental 2020-2021 del MINSA y la Ley 30947 (Ley de Salud Mental), que priorizan la prevención del consumo de alcohol en adolescentes desde el primer nivel de atención y los Centros de Salud Mental Comunitarios.

PREGUNTA 141

Mujer de 40 años es rescatada de un incendio en ambiente cerrado por explosión de balón de gas. Llega con quemaduras de aproximadamente 35% de la superficie corporal total. Examen: PA 80/50 mmHg, FC 124 x', FR 30 x', SatO2 86% al aire ambiente; agitada, con tiraje intercostal, estridor leve, quemaduras faciales y hollín en la orofaringe. ¿Cuál es la primera medida que se debe realizar?

- A. Oxigenoterapia con mascarilla con reservorio
- B. Asegurar vía aérea precoz con intubación traqueal
- C. Analgesia opioide EV de forma inmediata
- D. Reposición hídrica según la fórmula de Parkland

CLAVE: B

La paciente presenta múltiples signos predictores de obstrucción inminente de la vía aérea por lesión inhalatoria: incendio en espacio cerrado, quemaduras faciales, hollín en la orofaringe, estridor (signo cardinal de compromiso laríngeo) y desaturación 86%. La primera medida es asegurar la vía aérea con intubación orotraqueal precoz, antes de que el edema progrese y haga imposible la intubación. Demorar la intubación condena a un escenario donde la vía aérea se cierra y la cricotirotomía de emergencia es la única opción. Las demás intervenciones se realizan después o en paralelo. La oxigenoterapia con mascarilla con reservorio es razonable como medida inicial mientras se prepara la intubación, pero por sí sola no resuelve la obstrucción inminente: la paciente necesita vía aérea definitiva ya. La analgesia opiode endovenosa puede administrarse luego, pero no es la prioridad y puede deprimir aún más la respiración si se da antes de asegurar la vía aérea. La reposición hídrica según Parkland es esencial pero corresponde al paso C del ABCDE; primero hay que tener vía aérea (A) y respiración (B) bajo control. Asegurar vía aérea precoz es la primera medida.

PREGUNTA 142

Mujer de 56 años, con antecedente de cáncer de mama receptor hormonal positivo, tratada con cirugía y quimioterapia. Recibe tamoxifeno desde hace 4 años. Consulta por sangrado uterino escaso e intermitente. Examen: no hallazgos relevantes. ¿Cuál es la indicación pertinente?

- A. Ecografía transvaginal
- B. Resonancia magnética
- C. Laparoscopia quirúrgica
- D. Histerectomía profiláctica

CLAVE: A

En toda paciente posmenopáusica con sangrado uterino, el primer estudio indicado es la ecografía transvaginal para medir el grosor endometrial. En esta paciente con uso prolongado de tamoxifeno (efecto agonista estrogénico parcial sobre endometrio que aumenta el riesgo de hiperplasia, pólipos y carcinoma endometrial), la indicación es aún más imperativa. La ecografía transvaginal permite medir el endometrio: si es menor de 4-5 mm el riesgo de cáncer endometrial es bajo, y si es mayor o presenta irregularidades se procede a biopsia endometrial. La resonancia magnética es estudio de segunda línea para estadificación local cuando ya hay diagnóstico histológico de carcinoma endometrial, no como tamizaje inicial frente a sangrado. La laparoscopia quirúrgica diagnóstica no es la conducta primaria: el endometrio se evalúa primero por imagen y

biopsia, no por cirugía. La histerectomía profiláctica está formalmente contraindicada sin diagnóstico histológico previo; sería excesiva e injustificada antes de descartar patología orgánica con biopsia. Ecografía transvaginal es el primer paso correcto.

PREGUNTA 143

Primigesta de 14 semanas de embarazo gemelar es evaluada por ecografía. Se observa una sola placenta y una delgada membrana intergemelar que se inserta de manera perpendicular en la superficie placentaria, formando el denominado "signo en T". ¿En qué tipo de gestación múltiple se observa este hallazgo?

- A. Monocoriónica monoamniótica
- B. Bicoriónica biamniótica
- C. Monocoriónica biamniótica
- D. Bicoriónica monoamniótica

CLAVE: C

El signo en T es un hallazgo ecográfico patognomónico de gestación gemelar monocoriónica biamniótica: una sola placenta compartida (monocoriónica) con dos sacos amnióticos separados por una membrana fina y avascular que se inserta perpendicularmente en la superficie placentaria, sin grosor en la base. La gestación monocoriónica biamniótica representa aproximadamente el 70% de los gemelos monocigóticos y tiene riesgos específicos como síndrome de transfusión feto-fetal (TTTS), restricción selectiva del crecimiento y secuencia anemia-policitemia, por lo que requiere control ecográfico cada 2 semanas desde la semana 16. La gestación monocoriónica monoamniótica tiene una sola placenta y una sola bolsa amniótica (sin membrana entre los fetos), no signo en T. La gestación bicoriónica biamniótica presenta dos placentas (o una placenta fusionada con dos componentes) y dos sacos separados por una membrana gruesa con tejido placentario que produce el signo lambda o pico de Pasteur, no el signo en T. La gestación bicoriónica monoamniótica no existe (siempre dos coriones implican dos amnios). Signo en T = monocoriónica biamniótica.

PREGUNTA 144

Lactante de 2 meses, producto de parto a las 28 semanas, permanece hospitalizado en UCI. Desde el nacimiento ha requerido oxígeno suplementario y actualmente se encuentra con CPAP nasal con FiO2 35%, SatO2 92%, ganancia ponderal adecuada y sin datos de infección aguda. ¿Cuál es el componente fundamental del manejo en esta etapa?

- A. Iniciar vitamina A oral
- B. Uso de oxígeno dosificado para llevar la SatO₂ al 100%
- C. Adecuado aporte calórico proteico para el gasto energético
- D. Uso de ventilación mecánica para protección pulmonar

CLAVE: C

En lactante de 2 meses prematuro extremo (28 semanas) hospitalizado en UCI con CPAP nasal con FiO₂ baja, SatO₂ 92% adecuada y ganancia ponderal favorable, el componente fundamental del manejo es el adecuado aporte calórico proteico para el gasto energético elevado del prematuro, idealmente con leche materna fortificada o fórmula para prematuro. El crecimiento óptimo en esta etapa influye en el desarrollo neurológico, la maduración pulmonar (displasia broncopulmonar) y el peso al alta, y es marcador clave del éxito del manejo de UCI neonatal. El uso de vitamina A oral tiene cierto rol en prevención de displasia broncopulmonar pero la evidencia actual es limitada y no es el componente principal del manejo cotidiano. Llevar la SatO₂ al 100% con oxígeno dosificado está formalmente contraindicado en prematuros porque la hiperoxia aumenta el riesgo de retinopatía del prematuro y displasia broncopulmonar; la SatO₂ objetivo en prematuros es 90-95%. El uso de ventilación mecánica para protección pulmonar no se justifica en un paciente que está mejorando con CPAP y SatO₂ 92%; intubarlo lo expone a riesgos innecesarios. Aporte calórico-proteico adecuado ese dato es el que decide.

PREGUNTA 145

Puérpera de 9 horas de parto eutócico y episiotomía mediolateral, presenta fiebre durante la visita médica. Examen: PA 100/70 mmHg, FC 96 x', T 38.2 °C. Mamas blandas y no dolorosas, útero involucionado, loquios hemáticos sin mal olor, episiorrafia bien afrontada sin eritema ni secreción. Laboratorio: hemograma y examen de orina normal. ¿Cuál es la causa más probable de la fiebre?

- A. Infección de episiorrafia
- B. Pirógenos endógenos
- C. Mastitis puerperal
- D. Endometritis puerperal

CLAVE: B

La fiebre fisiológica de las primeras 24 horas posparto se debe a la liberación de pirógenos endógenos por el trauma muscular y vaginal del trabajo de parto, deshidratación leve, esfuerzo físico intenso y respuesta inflamatoria sistémica subclínica.

Es benigna, autolimitada, no se asocia a foco infeccioso identificable y suele resolverse en 12-24 horas con hidratación y analgesia. En esta paciente con todos los hallazgos normales (mamas, útero, loquios, episiorrafia, laboratorio), la fiebre 38.2 a las 9 horas es justamente este patrón fisiológico. La infección de la episiorrafia produce eritema, dolor local intenso, secreción purulenta y dehiscencia, ninguno presente. La mastitis puerperal cursa con mama dolorosa, eritematosa, fiebre alta y aparece típicamente entre la 2ª y 4ª semana posparto, no a las 9 horas. La endometritis puerperal genera útero subinvolucionado y doloroso, loquios fétidos, fiebre y leucocitosis, hallazgos ausentes. Por exclusión y por el momento de aparición (primeras 24 horas), la causa es pirógenos endógenos del proceso de parto, sin necesidad de antibioticoterapia ni estudios adicionales.

PREGUNTA 146

Mujer de 80 años acude al servicio de urgencias por disnea en reposo, ortopnea y edema generalizado. Examen: PA 180/100 mmHg, FC 110 x', FR 18 x', SatO2 88% con aire ambiental, crepitantes bibasales. ProBNP 1200 pg/mL. Rx de tórax: edema alveolar bilateral. Tras colocarla en posición semisentada y administrar oxígeno suplementario. ¿Cuál es el fármaco de primera elección en el manejo inicial de este cuadro?

- A. Nitroglicerina EV
- B. Furosemida EV
- C. Salbutamol vía nebulización
- D. Morfina EV

CLAVE: B

En edema agudo de pulmón cardiogénico con HTA (PA 180/100), el manejo inicial tras posición semisentada y oxígeno suplementario incluye furosemida endovenosa como diurético de asa de primera elección, en bolo de 40-80 mg, que actúa rápidamente (15-30 minutos) reduciendo la congestión pulmonar por su efecto venodilatador inicial y luego diurético. La elevación marcada del proBNP (1200 pg/mL) confirma sobrecarga ventricular y respalda el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda con edema pulmonar. La furosemida es el pilar farmacológico del manejo y debe administrarse precozmente. La nitroglicerina endovenosa es alternativa razonable y frecuentemente complementaria como vasodilatador venoso, sobre todo útil cuando la HTA es severa, pero no es la primera elección monoterápica; suele asociarse a furosemida. El salbutamol nebulizado se usa en broncoespasmo (asma, EPOC), no en EAP cardiogénico,

donde no hay obstrucción bronquial primaria. La morfina endovenosa fue clásicamente usada para reducir ansiedad y precarga venosa, pero estudios recientes (registros y RCT) sugieren mayor mortalidad con su uso y se reserva solo para casos seleccionados con dolor torácico isquémico asociado o ansiedad extrema. Furosemida es la primera elección.

PREGUNTA 147

Mujer de 62 años que desde hace 12 horas presenta dolor abdominal tipo cólico de inicio en epigastrio con migración a FID, acompañado de anorexia y vómitos en 2 ocasiones. Examen: T 38.5°C. Abdomen: McBurney (+), Blumberg (+). Laboratorio: leucocitos de 9, 890 cel/mm³ y neutrófilos 77%. ¿Cuál es su puntaje en la escala de Alvarado?

- A. 8
- B. 6
- C. 9
- D. 7

CLAVE: A

La escala de Alvarado para apendicitis aguda asigna puntaje a 8 ítems que sumados orientan al diagnóstico. Para esta paciente: dolor migratorio de epigastrio a FID (1 punto), anorexia (1 punto), náuseas/vómitos (1 punto), dolor en FID con McBurney positivo (2 puntos), rebote positivo o Blumberg (1 punto), temperatura mayor de 37.3°C (1 punto, aquí 38.5), leucocitosis mayor de 10, 000 (0 puntos, porque tiene 9, 890 que es justo por debajo), neutrofilia mayor de 75% (1 punto, tiene 77%). Total: 1+1+1+2+1+1+0+1 = 8 puntos. Un puntaje de 6 subestimaría el cuadro al no contar correctamente los signos peritoneales (rebote y McBurney). Un puntaje de 9 sería excesivo y solo aplicaría si la leucocitosis fuera mayor de 10, 000 (hubiera sumado un punto adicional), lo cual no es el caso. Un puntaje de 7 quedaría corto al no incluir alguno de los signos clínicos descritos. Alvarado de 8 corresponde a apendicitis probable con alta sospecha (rangos 7-8: probable, 9-10: muy probable), e indica conducta quirúrgica con apendicectomía o, según contexto, imagen confirmatoria.

PREGUNTA 148

Lactante de 3 meses, llevada a CRED de un establecimiento del primer nivel de atención. Nació a las 37 semanas de gestación no controlada de madre adolescente. Peso al nacer: 3 Kg. Corte del cordón umbilical fue precoz. Recibe lactancia materna

exclusiva. En el último mes presenta ganancia de peso limítrofe, pero se encuentra activa, reactiva con palidez evidente, no otros hallazgos patológicos. ¿Cuál es la conducta más adecuada respecto a la suplementación con hierro vía oral?

- A. Inmediatamente, dosis terapéutica
- B. De manera inmediata, dosis profiláctica
- C. A los 4 meses, dosis terapéutica
- D. A los 4 meses, dosis profiláctica

CLAVE: B

La lactante tiene factores de riesgo importantes para anemia ferropénica del lactante: pretérmino tardío (37 semanas), madre adolescente con embarazo no controlado, corte precoz del cordón umbilical (que reduce el aporte de hierro placentario) y ganancia de peso limítrofe con palidez evidente. La conducta correcta es iniciar suplementación profiláctica con hierro de manera inmediata, sin esperar a los 4 meses (norma estándar para RNT bajo riesgo), porque las reservas de hierro de los pretérminos y de los niños con corte precoz del cordón se agotan tempranamente, por lo general antes del cuarto mes. Dar dosis terapéutica inmediata sin diagnóstico hematológico de anemia ferropénica confirmada con hemograma sería excesivo; primero se inicia dosis profiláctica y, si se confirma anemia con hemograma, se escala a dosis terapéutica. Esperar a los 4 meses para iniciar profilaxis estándar va contra las recomendaciones específicas para pretérminos y niños con factores de riesgo, en quienes el inicio debe ser más temprano. La dosis profiláctica es 2-3 mg/kg/día y la terapéutica 3-6 mg/kg/día. Inmediato + profiláctico aquí no hay vuelta para este perfil de riesgo.

PREGUNTA 149

Mujer de 32 años, previamente sana, fue sometida a cesárea hace 7 días bajo anestesia raquídea con lidocaína hiperbárica al 5%. Refiere que, desde hace 24 horas, presenta retención urinaria, estreñimiento, debilidad progresiva de ambas piernas y anestesia en "silla de montar". Al examen se evidencian arreflexia aquilea bilateral y disminución del tono del esfínter anal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Intoxicación sistémica por anestésico local
- B. Síndrome de cola de caballo
- C. Disautonomía aguda posquirúrgica
- D. Hematoma epidural espinal

CLAVE: B

Lo que pega de inmediato: síndrome de cola de caballo: retención urinaria, estreñimiento, debilidad progresiva de ambas piernas, anestesia en silla de montar (perineal), arreflexia aquilea bilateral y disminución del tono del esfínter anal. En esta paciente la causa probable es la neurotoxicidad por lidocaína hiperbárica al 5% administrada en raquídea, asociación clásica reportada en la literatura por concentración elevada y volumen, sobre todo cuando se utilizan microcatéteres o se reinyectan dosis. La neurotoxicidad genera lesión transitoria o permanente de las raíces de la cola de caballo (L2-S5). La intoxicación sistémica por anestésico local cursa con cuadro neurológico central agudo (convulsiones, depresión del SNC) y cardiovascular durante la administración, no con cuadro radicular sacro tardío como aquí. La disautonomía aguda posquirúrgica produce alteraciones autonómicas pero no anestesia en silla de montar con arreflexia bilateral. El hematoma epidural espinal es complicación posible de la anestesia neuroaxial pero típicamente se presenta dentro de las primeras 24-48 horas con dolor de espalda intenso y déficit neurológico progresivo, no a los 7 días con cuadro insidioso. Síndrome de cola de caballo por neurotoxicidad de lidocaína 5% aquí no hay vuelta.

PREGUNTA 150

Durante el proceso de fecundación humana, la reacción acrosomal del espermatozoide se desencadena principalmente cuando este entra en contacto con

.....

- A. las células foliculares de la corona radiada
- B. el espacio perivitelino
- C. la membrana plasmática del ovocito (ooloma)
- D. la zona pelúcida que rodea al ovocito secundario

CLAVE: D

La reacción acrosomal es el proceso por el cual el espermatozoide libera enzimas (acrosina, hialuronidasa, neuraminidasa) almacenadas en su acrosoma cuando entra en contacto con la zona pelúcida del ovocito secundario. Las glicoproteínas ZP3 de la zona pelúcida actúan como receptor específico para la membrana del espermatozoide y desencadenan la fusión vesicular y liberación enzimática que permite digerir la zona pelúcida y atravesarla. Sin reacción acrosomal no hay fecundación, ya que el espermatozoide no podría perforar la zona pelúcida y alcanzar la membrana del ovocito. Las células foliculares de la corona radiada son atravesadas por el espermatozoide gracias a la hialuronidasa pero no son el sitio donde se desencadena la reacción

acrosomal completa, que requiere contacto específico con la zona pelúcida. Ojo: el espacio perivitelino es el espacio entre la zona pelúcida y la membrana del ovocito, alcanzado solo después de la reacción acrosomal y la perforación de la zona pelúcida. La membrana plasmática del ovocito (ooloma) es el sitio de fusión final del espermatozoide tras atravesar la zona pelúcida; ya no se desencadena reacción acrosomal allí. Zona pelúcida (ZP3) es el sitio de la reacción acrosomal.

PREGUNTA 151

Varón de 60 años con antecedentes de lesiones tipo parche eritematosa y placa eritematosa pruriginosa en tronco y extremidades desde hace varios años, con escasa respuesta a corticoides tópicos. Biopsia de piel: infiltrado linfocitario epidérmico de células T CD4+ atípicas, compatible con micosis fungoide. ¿Cuál es la naturaleza de esta enfermedad?

- A. Variante de psoriasis eritrodérmica crónica
- B. Infección por micosis profunda invasora
- C. Linfoma primario cutáneo no Hodgkin de fenotipo T
- D. Leucemia mieloide crónica con afectación cutánea primaria

CLAVE: C

La micosis fungoide es el linfoma primario cutáneo no Hodgkin de células T más frecuente, derivado de linfocitos T CD4+ con tropismo epidérmico (epidermotropismo). Su nombre histórico es engañoso porque no es de origen micótico. Se caracteriza por evolución indolente con tres estadios cutáneos progresivos: parche, placa y tumor, con prurito frecuente y respuesta limitada a corticoides tópicos en las lesiones consolidadas. La biopsia muestra infiltrado linfocitario epidérmico atípico de fenotipo T CD4 positivo, compatible con esta entidad. El diagnóstico se confirma con inmunohistoquímica y reordenamiento monoclonal del receptor T. La psoriasis eritrodérmica crónica produce lesiones eritematoescamosas extensas con descamación característica y respuesta a corticoides tópicos y sistémicos en mayor medida que la micosis fungoide. La micosis profunda invasora es infección fúngica con histología muy distinta (granulomas con hifas), no infiltrado linfocitario T atípico. La leucemia mieloide crónica con afectación cutánea es excepcional como presentación primaria y los infiltrados serían de células mieloides, no T CD4. Linfoma primario cutáneo de células T (micosis fungoide) aquí no hay vuelta.

PREGUNTA 152

En un hospital se observa un incremento de infecciones intrahospitalarias, con una incidencia basal de 8%. Se implementa un programa de mejora en higiene de manos, técnicas de antisepsia y medidas de bioseguridad. Tres meses después, la incidencia de infecciones intrahospitalarias disminuye a 2%. ¿Cuál es la reducción relativa del riesgo (RRR) de infecciones intrahospitalarias asociada a esta intervención?

- A. 65%
- B. 70%
- C. 75%
- D. 85%

CLAVE: C

La reducción relativa del riesgo (RRR) se calcula como: (incidencia inicial menos incidencia final) dividida entre la incidencia inicial, multiplicada por 100. En este caso: $(8\% - 2\%) / 8\% \times 100 = 6/8 \times 100 = 75\%$. La RRR es una medida que expresa qué porcentaje del riesgo basal fue reducido por la intervención, y se utiliza ampliamente para comunicar el efecto de programas de calidad y de medidas preventivas en salud. Una RRR del 75% es muy significativa y respalda la efectividad del programa de higiene de manos y bioseguridad implementado. Los valores 65%, 70% y 85% no se obtienen con la fórmula correcta de RRR aplicada a estos datos. Es importante distinguir RRR de la reducción absoluta del riesgo (RAR), que sería $8\% - 2\% = 6$ puntos porcentuales, una diferencia distinta y también informativa para calcular el número necesario a tratar (NNT). La RRR es muy comunicada en literatura médica pero puede sobreestimar el impacto cuando la incidencia basal es baja, mientras que la RAR es más representativa del efecto poblacional real. La aritmética sencilla $6/8 \times 100 = 75\%$ ojo: el truco está justo ahí.

PREGUNTA 153

Los cálculos pigmentarios que se forman principalmente en las vías biliares, asociados a estasis biliar e infecciones bacterianas ascendentes, se denominan:

- A. De colesterol
- B. Mixtos de colesterol y bilirrubinato
- C. Pigmentarios negros
- D. Pigmentarios marrones

CLAVE: D

Los cálculos pigmentarios marrones se forman principalmente en las vías biliares (colédoco) en contexto de estasis biliar e infecciones bacterianas ascendentes (*E. coli* y otras enterobacterias). Las bacterias producen β -glucuronidasa que desconjuga la

bilirrubina, generando bilirrubinato cálcico no soluble que precipita y forma cálculos blandos, friables y de color pardo-marrón. Son característicos de zonas con alta prevalencia de parasitosis biliar (*Clonorchis*, *Ascaris*) y se asocian a colangitis recurrente, sobre todo en Asia y Latinoamérica. Los cálculos de colesterol son los más frecuentes en países occidentales y se forman en la vesícula por sobresaturación biliar, asociados a obesidad, embarazo y estrógenos, no por infección. Ojo: los cálculos mixtos de colesterol y bilirrubinato cálcico son una variedad común vesicular pero no específicamente asociada a infección. Los pigmentarios negros se forman en la vesícula en pacientes con hemólisis crónica (anemia falciforme, talasemia, esferocitosis) o cirrosis, por exceso de bilirrubina no conjugada, no por infección bacteriana ascendente. En el contexto peruano, los cálculos pigmentarios marrones se asocian y además a *Fasciola hepatica* (zonas altoandinas como Cajamarca, Junín, Puno) y, con menor frecuencia, a *Ascaris lumbricoides* en regiones tropicales, que generan colangitis recurrente con litogénesis pigmentaria.

PREGUNTA 154

Mujer de 25 años con lupus eritematoso sistémico diagnosticado hace 2 años, en tratamiento irregular con corticoides orales. En los exámenes de control se encuentra creatinina sérica de 3,1 mg/dL. Examen de orina: proteinuria de 2,5 g/24 h, sangre 2+, eritrocitos dismórficos y cilindros hemáticos. Biopsia renal: nefritis lúpica clase IV (proliferativa). Se eleva dosis de glucocorticoides sin mejoría significativa. ¿Cuál es el fármaco inmunosupresor de elección a administrar?

- A. Ciclofosfamida
- B. Rituximab
- C. Azatioprina
- D. Metotrexato

CLAVE: A

La nefritis lúpica clase IV (proliferativa difusa) es la forma más severa y frecuente de compromiso renal en LES, con peor pronóstico y mayor riesgo de progresión a enfermedad renal crónica. El tratamiento estándar de inducción incluye glucocorticoides en pulsos altos junto con un agente inmunosupresor; el de elección clásico es ciclofosfamida endovenosa según el régimen Euro-Lupus o NIH, sobre todo cuando hay datos de actividad severa con creatinina elevada y cilindros hemáticos. La respuesta inadecuada a glucocorticoides en monoterapia confirma la necesidad de añadir el inmunosupresor. El rituximab puede usarse en casos refractarios a ciclofosfamida o en

pacientes con contraindicaciones específicas, pero no es la primera elección en inducción de nefritis lúpica clase IV. La azatioprina se utiliza más bien como mantenimiento tras la inducción exitosa con ciclofosfamida o como alternativa al micofenolato; no tiene la potencia de inducción necesaria en clase IV severa. El metotrexato no es eficaz para nefritis lúpica significativa y se utiliza en otras manifestaciones del LES (artritis, lupus cutáneo). Ciclofosfamida o micofenolato son los fármacos de inducción de elección, y ciclofosfamida marca esto entre las opciones.

PREGUNTA 155

Lactante de 6 meses, previamente sano, con fiebre de 39 °C de 24 horas de evolución, vómitos a repetición y rechazo a la lactancia. Examen: irritable, regular estado general. Laboratorio: leucocitosis, elevación de PCR y procalcitonina. Uroanálisis compatible con infección urinaria. ¿Cuál es el manejo más adecuado?

- A. Espera de cultivos para antibioticoterapia
- B. Antibioticoterapia EV y ecografía renal
- C. Observación con sintomáticos
- D. Antibioticoterapia oral ambulatoria

CLAVE: B

En lactante menor de 1 año con infección urinaria febril (fiebre alta, leucocitosis, PCR y procalcitonina elevadas), la conducta correcta es hospitalizar para iniciar antibioticoterapia endovenosa empírica de amplio espectro tras tomar urocultivo (cefalosporina de tercera generación como ceftriaxona) y solicitar ecografía renal y de vías urinarias para descartar uropatía obstructiva, malformaciones o complicaciones. La rica vascularización renal del lactante eleva el riesgo de sepsis urinaria y de cicatrices renales si no se tratan adecuadamente, por lo que el manejo debe ser inmediato e intensivo. Esperar cultivos para iniciar antibióticos demora el tratamiento en un lactante con sepsis urinaria probable y alto riesgo de daño renal; los antibióticos empíricos deben iniciarse tras la toma de urocultivo, no esperar. La observación con sintomáticos en lactante con fiebre alta e ITU es peligrosa y subestima la gravedad. La antibioticoterapia oral ambulatoria se acepta en pacientes mayores de 2-3 meses con afectación leve y tolerancia oral adecuada, no en lactante con vómitos a repetición y rechazo a la lactancia con datos de bacteriemia inflamatoria. Hospitalización + ATB EV + ecografía renal es el estándar.

PREGUNTA 156

Niño de 10 años con antecedente de hipotonía neonatal y dificultad para alimentarse en el primer año de vida. En los últimos años presenta hiperfagia marcada, obesidad central, talla baja para la edad, discapacidad intelectual leve, hipogonadismo y testículos no descendidos. No hay antecedentes familiares similares. ¿Cuál es el síndrome genético más probable?

- A. X frágil
- B. Klinefelter
- C. Prader-Willi
- D. Turner

CLAVE: C

El cuadro corresponde al síndrome de Prader-Willi, trastorno genético por delección en el cromosoma 15 paterno (15q11-q13) o disomía uniparental materna. La presentación clásica tiene dos fases evolutivas: en el primer año hipotonía neonatal severa, dificultad para succionar y baja ganancia ponderal; a partir del segundo o tercer año aparece hiperfagia incontrolable, obesidad central, talla baja, discapacidad intelectual leve a moderada, hipogonadismo hipogonadotrófico y rasgos faciales característicos. La criptorquidia es común. El diagnóstico se confirma con metilación del 15q11-q13. El síndrome X frágil produce discapacidad intelectual con autismo, macroorquidia (testículos grandes) postpuberal y rasgos faciales como cara alargada y orejas grandes, no encaja con criptorquidia ni con hiperfagia obesa. El síndrome de Klinefelter (47 XXY) cursa con talla alta (no baja), ginecomastia, hipogonadismo y rasgos eunucoides en la pubertad, no con hipotonía neonatal ni hiperfagia infantil. El síndrome de Turner (45 X) afecta solo a niñas con talla baja, cuello alado y disgenesia gonadal; el caso es de un varón. Hipotonía neonatal + hiperfagia obesa + criptorquidia + discapacidad = Prader-Willi.

PREGUNTA 157

Usted ha sido designado Ministro de Salud y se propone reducir las inequidades en el acceso a los servicios entre zonas urbanas y rurales, garantizando una distribución de recursos del sistema sanitario a las poblaciones más vulnerables, de acuerdo a las FESP. Desde la bioética aplicada a la salud pública, ¿Qué principio bioético es prioritario en estas decisiones de política?

- A. Autonomía
- B. Beneficencia
- C. Justicia

D. No maleficencia

CLAVE: C

En bioética aplicada a salud pública, el principio prioritario para decisiones que buscan reducir inequidades en el acceso a servicios y distribuir recursos hacia las poblaciones más vulnerables es la justicia, entendida en su sentido distributivo. La justicia distributiva exige que los recursos del sistema sanitario se asignen de manera proporcional a las necesidades de cada grupo, priorizando a quienes están en peor situación (poblaciones rurales, pobres, con barreras geográficas y culturales). Este principio está alineado con las Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP) y con marcos como la cobertura universal de salud. La autonomía se refiere al respeto de la voluntad y capacidad de decisión individual del paciente, principio esencial en la relación médica pero no específicamente operativo para decisiones de política sanitaria distributiva. La beneficencia busca el bien del paciente individual y se aplica a la práctica clínica, no es el marco principal para reducir inequidades poblacionales. La no maleficencia exige no dañar al paciente y rige también la práctica clínica individual. La justicia es el principio bioético central para decisiones de distribución equitativa y reducción de inequidades en salud pública.

PREGUNTA 158

Varón de 50 años acude por cefalea de inicio súbito de 30 minutos de evolución, intensidad 10/10, descrita como "la peor cefalea de su vida", tipo "en trueno". Antecedente de hipertensión arterial en tratamiento con losartán. Examen: afebril, consciente, orientado, Glasgow 15, sin déficit neurológico focal, presenta rigidez de nuca. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Migraña con aura
- B. Meningitis viral
- C. Hemorragia subaracnoidea
- D. DVC isquémico

CLAVE: C

Lo que define este caso es altamente sugerente de hemorragia subaracnoidea (HSA), generalmente por ruptura de aneurisma sacular en el polígono de Willis. La presentación clásica es cefalea súbita de máxima intensidad desde el inicio (la peor cefalea de su vida, descrita como en trueno o thunderclap), rigidez de nuca por irritación meníngea química, sin necesariamente déficit focal en HSA pequeñas. La HTA es factor de riesgo importante para ruptura aneurismática. El diagnóstico se confirma con TC sin contraste

urgente (sangre hiperdensa en cisternas basales y surcos): la sensibilidad supera el 98% en las primeras 6 horas y desciende a 80-85% a las 24 horas. Si la TC es negativa con clínica fuerte, se realiza punción lumbar buscando xantocromía. La migraña con aura tiene presentación gradual con auras visuales o sensoriales que preceden a la cefalea pulsátil unilateral, y aunque puede ser intensa no se describe como en trueno con inicio súbito ni con rigidez de nuca. La meningitis viral cursa con fiebre, cefalea progresiva en horas o días, rigidez de nuca y compromiso del estado mental, no inicio súbito en segundos sin fiebre. El DVC isquémico genera déficit focal súbito (hemiparesia, afasia, hemianopsia) según territorio comprometido, no cefalea aislada en trueno con rigidez de nuca. Cefalea en trueno + rigidez de nuca = HSA y no hay vuelta.

PREGUNTA 159

Recién nacido a término de madre de 24 años, no controles prenatales. Parto vaginal con líquido amniótico fétido. A las 12 horas de vida presenta hipotermia (35 °C), letargia, succión débil y escasa respuesta a estímulos. Examen: palidez, llenado capilar lento y fontanela discretamente abombada. ¿Cuál es el estudio diagnóstico de mayor relevancia?

- A. Dosificación sérica de procalcitonina
- B. Prueba rápida cuantitativa de proteína C reactiva
- C. Hemocultivo y cultivo de líquido cefalorraquídeo
- D. Urocultivo con antibiograma

CLAVE: C

El recién nacido cursa sepsis neonatal precoz con probable meningitis bacteriana asociada (factores de riesgo: madre sin controles prenatales, líquido amniótico fétido como signo de corioamnionitis, hipotermia, letargia y, sobre todo, fontanela discretamente abombada como signo de hipertensión intracraneal). El estudio de mayor relevancia diagnóstica es el hemocultivo más cultivo de líquido cefalorraquídeo (punción lumbar) para identificar el agente causal y dirigir la terapia antibiótica. La punción lumbar es obligatoria en neonato con sospecha de sepsis y signos meníngeos para descartar meningitis bacteriana neonatal. La procalcitonina y la proteína C reactiva son marcadores inflamatorios útiles como apoyo diagnóstico y seguimiento de sepsis, pero no identifican el agente causal ni reemplazan los cultivos definitivos. El urocultivo es relevante en infección urinaria pediátrica pero no es el estudio de mayor relevancia ante un neonato con clínica de sepsis con compromiso del SNC. Hemocultivo más cultivo de LCR son los exámenes que cambian el manejo antibiótico (selección y duración) y deben

tomarse antes de iniciar antibióticos empíricos como ampicilina más gentamicina o cefotaxima.

PREGUNTA 160

Varón de 45 años acude por fatiga progresiva y sensación de plenitud abdominal. Examen: esplenomegalia palpable 6 cm por debajo del reborde costal izquierdo. Hemograma: leucocitos 130, 000/ μ L a predominio de neutrófilos y mielocitos, Hb 11 g/dL, plaquetas 600, 000/ μ L. En el frotis leucocitosis con formas mieloides en distintas etapas de maduración y escasos blastos. La citometría de flujo descarta fenotipo linfoide. Para confirmar el diagnóstico y orientar una terapia dirigida con inhibidores de tirosina cinasa, ¿Cuál es la alteración citogenético-molecular?

- A. Deleción 5q asociada a síndrome mielodisplásico
- B. Translocación t(9;22)(q34;q11) con gen de fusión BCR-ABL1 (cromosoma Filadelfia)
- C. Translocación t(15;17)(q24;q21) con gen de fusión PML-RARA
- D. Mutación del gen JAK2 V617F

CLAVE: B

Lo que define este caso es leucemia mieloide crónica (LMC) en fase crónica: leucocitosis marcada con desviación izquierda granulocítica completa (mielocitos, metamielocitos y todas las etapas de maduración), basofilia frecuente, escasos blastos, esplenomegalia palpable y síntomas constitucionales. La alteración citogenético-molecular patognomónica es la translocación t(9;22)(q34;q11), llamada cromosoma Filadelfia, que genera el gen de fusión BCR-ABL1 con actividad de tirosina cinasa constitutiva. La identificación de BCR-ABL1 permite usar inhibidores específicos de tirosina cinasa como imatinib, dasatinib o nilotinib, con respuestas hematológicas y moleculares profundas. La deleción 5q se asocia a síndrome mielodisplásico con anemia macrocítica refractaria (no LMC), tratado con lenalidomida. La translocación t(15;17) genera el gen de fusión PML-RARA y es característica de leucemia promielocítica aguda (LPA, LMA M3), con respuesta a ácido transretinoico (ATRA) y arsénico, no a inhibidores de tirosina cinasa. La mutación JAK2 V617F es marcador de neoplasias mieloproliferativas Philadelphia-negativas como policitemia vera, trombocitemia esencial y mielofibrosis primaria, no de LMC. t(9;22) BCR-ABL1 es la alteración correcta.

PREGUNTA 161

Según el enfoque de la Carta de Ottawa, "facilitar la articulación y coordinación entre diferentes sectores de la sociedad para mejorar los determinantes de la salud" corresponde a:

- A. Participación ciudadana
- B. Prevención de la salud
- C. Promoción de la salud
- D. Comunicación intersectorial

CLAVE: D

La Carta de Ottawa (1986) establece cinco áreas de acción para la promoción de la salud: políticas públicas saludables, ambientes de apoyo, fortalecimiento de la acción comunitaria, desarrollo de habilidades personales y reorientación de los servicios de salud. Dentro de este marco, la articulación y coordinación entre diferentes sectores de la sociedad (educación, transporte, agricultura, vivienda, trabajo) para abordar los determinantes sociales de la salud se denomina comunicación intersectorial o acción intersectorial, principio operativo clave porque la mayoría de los determinantes de salud están fuera del sector sanitario clásico. La participación ciudadana se refiere al involucramiento activo de las comunidades en las decisiones de salud, dimensión importante pero distinta de la articulación intersectorial. La prevención de la salud no es un término preciso de la Carta de Ottawa; los conceptos correctos son prevención de enfermedades (primaria, secundaria, terciaria) y promoción de la salud, no se mezclan. La promoción de la salud es el marco general de la Carta, pero la pregunta busca la dimensión específica de articulación entre sectores, que es comunicación intersectorial. Articulación entre sectores = comunicación intersectorial.

PREGUNTA 162

Recién nacido de 41 semanas, parto vaginal, peso 4, 000 g. APGAR 9 al minuto y a los 5 minutos. A las 2 horas de vida se encuentra activo, con buena succión y sin signos de dificultad respiratoria ni alteraciones neurológicas. Laboratorio: hematocrito 68%, glucosa capilar 60 mg/dL. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A. Exanguíneo transfusión total y control de temperatura
- B. Exanguíneo transfusión parcial y control de hematocrito
- C. Dextrosa al 10% en bolo de 8 ml y control de glucosa
- D. Hidratación EV y controles de hematocrito

CLAVE: D

La policitemia neonatal se define como hematocrito venoso central mayor de 65%. En este recién nacido el hematocrito de 68% se sitúa en el rango límite (65-70%), pero el dato clínico decisivo es que está activo, con buena succión y sin signos de hiperviscosidad, dificultad respiratoria, hipoglucemia ni alteraciones neurológicas. Las guías AAP, Cochrane y SIBEN coinciden: en recién nacido asintomático con hematocrito entre 65 y 70%, la conducta es hidratación endovenosa con cristaloides isotónicos a 80-100 mL/kg/día y controles seriados de hematocrito cada 6-12 horas. La hipoxia crónica intrauterina del postérmino macrosómico explica la policitemia, pero no obliga a intervención invasiva si el cuadro es asintomático. La exanguinotransfusión parcial se reserva para neonatos sintomáticos (letargia, irritabilidad, dificultad respiratoria, hipoglucemia, trombosis, ECN) con hematocrito mayor de 65%, o para asintomáticos con hematocrito mayor de 70%, escenarios distintos al actual. La exanguinotransfusión total es para hiperbilirrubinemia severa por isoimmunización o hemólisis masiva, no para policitemia. El bolo de dextrosa al 10% se usa en hipoglucemia neonatal documentada (glucosa capilar 60 mg/dL en este caso es valor normal, no hipoglucemia franca). La hidratación EV con control de hematocrito previene complicaciones sin la morbilidad de un procedimiento invasivo en un neonato que no lo necesita.

PREGUNTA 163

Mujer de 28 años, natural de Loreto, con infección por VIH en estadio avanzado (recuento de CD4+ de 180 células/ μ l), acude por fiebre de 4 semanas de evolución, astenia marcada y pérdida de 8 kg de peso. Examen: palidez cutáneo-mucosa, hepatoesplenomegalia y adenopatías pequeñas generalizadas. Laboratorio: anemia normocítica normocrómica y pancitopenia leve. La prueba serológica rápida rK39 es positiva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Tuberculosis miliar
- B. Linfoma Hodgkin
- C. Leishmaniasis visceral
- D. Esquistosomiasis hepatoesplénica

CLAVE: C

La leishmaniasis visceral o kala-azar es enfermedad parasitaria sistémica por *Leishmania donovani* o *L. infantum*, transmitida por flebotomos (*Lutzomyia* en el Perú), endémica en zonas selváticas. La triada clásica es fiebre prolongada, hepatoesplenomegalia (a expensas del bazo, frecuentemente palpable hasta cresta iliaca) y pancitopenia, con pérdida de peso marcada y palidez por anemia. La prueba

serológica rK39 detecta anticuerpos contra antígeno recombinante de *Leishmania donovani* complex con sensibilidad y especificidad altas. En pacientes con VIH avanzado y CD4 bajos, la presentación es más severa y la coinfección debe sospecharse en zonas endémicas. La tuberculosis miliar produce fiebre, pérdida de peso y compromiso multisistémico, pero las imágenes muestran patrón miliar pulmonar característico y la rK39 sería negativa; el diagnóstico se confirma con BAAR, cultivo o PCR. El linfoma Hodgkin produce adenopatías significativas con síntomas B (fiebre, sudoración, pérdida de peso) y hepatoesplenomegalia, pero rK39 es negativa y el diagnóstico requiere biopsia ganglionar con células de Reed-Sternberg. La esquistosomiasis hepatoesplénica produce hipertensión portal con esplenomegalia pero no se asocia a rK39 ni es endémica en el Perú. rK39 positivo + perfil clínico = leishmaniasis visceral.

PREGUNTA 164

Varón de 60 años, fumador de 40 paquetes-año, desde hace tres años presenta tos productiva y disnea progresiva. Refiere dos exacerbaciones infecciosas respiratorias en el último año que requirieron corticoides sistémicos. Espirometría posbroncodilatador: FEV1 45% del predicho, relación FEV1/FVC < 0,7, sin reversibilidad significativa. Eosinófilos en sangre periférica: 350/ μ L. No presenta antecedentes personales de asma ni síntomas respiratorios desde la juventud. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Fenotipo mixto asma-EPOC
- B. Bronquitis crónica sin obstrucción al flujo aéreo
- C. Asma persistente moderada
- D. EPOC estable moderado-grave

CLAVE: D

El paciente cumple criterios diagnósticos de EPOC: tabaquismo significativo (40 paquetes-año), tos productiva crónica, disnea progresiva, espirometría posbroncodilatador con relación FEV1/FVC menor de 0.7 (criterio diagnóstico de EPOC) sin reversibilidad significativa al broncodilatador, y FEV1 45% del predicho que clasifica como GOLD III (severo). Los dos episodios de exacerbación que requirieron corticoides sistémicos en el último año lo clasifican como GOLD E (alto riesgo). El conteo de eosinófilos en sangre periférica de 350/ μ L orienta el tratamiento (uso eventual de corticoide inhalado en combinación) pero no cambia el diagnóstico de EPOC. El fenotipo mixto asma-EPOC requiere antecedente personal de asma documentado o reversibilidad significativa al broncodilatador, ambos ausentes en este paciente. La

bronquitis crónica sin obstrucción al flujo aéreo no aplica porque la espirometría sí muestra obstrucción persistente con FEV1/FVC menor de 0.7. El asma persistente moderada cursa con reversibilidad significativa, antecedentes desde la juventud y patrón obstructivo variable, características no presentes aquí. Tabaquismo + obstrucción no reversible + exacerbaciones = EPOC moderado-grave (GOLD III-E).

PREGUNTA 165

Varón de 60 años, procedente de zona endémica, ha sido tratado por paludismo por Plasmodium vivax con un esquema completo de cloroquina, con buena respuesta clínica y parasitológica. Se decide indicar un curso de terapia adicional para prevenir recaídas (cura radical). Antes de iniciar este manejo, ¿cuál es el riesgo más importante que debe evaluarse en el paciente?

- A. Desarrollo de retinopatía por dosis acumuladas de cloroquina
- B. Predisposición a hipoglucemia por tratamiento con quinina
- C. Hemólisis por deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa
- D. Insuficiencia hepática crónica y riesgo de hepatotoxicidad

CLAVE: C

En malaria por Plasmodium vivax (y P. ovale), después de eliminar las formas eritrocíticas con cloroquina, es necesario administrar primaquina por 14 días para erradicar los hipnozoítos hepáticos y prevenir recaídas tardías (cura radical). El riesgo más importante a evaluar antes de iniciar primaquina es la deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD), enzima que protege a los eritrocitos del estrés oxidativo. Los pacientes con déficit de G6PD pueden desarrollar hemólisis aguda severa al recibir primaquina, por lo que se debe solicitar dosaje cuantitativo de G6PD antes del tratamiento. La retinopatía por cloroquina ocurre con uso prolongado a dosis acumuladas altas en enfermedades autoinmunes (lupus, artritis reumatoide), no en cursos cortos de malaria. La predisposición a hipoglucemia por quinina es relevante en P. falciparum severo tratado con quinina parenteral, no en P. vivax tratado con primaquina. La insuficiencia hepática crónica con riesgo de hepatotoxicidad no es la consideración principal al iniciar primaquina; el riesgo dominante es la hemólisis por G6PD. Tamizaje de G6PD antes de primaquina es lo que toca.

PREGUNTA 166

Mujer de 65 años, con diagnóstico de cáncer avanzado en tratamiento paliativo para el dolor, es encontrada inconsciente, con miosis puntiforme, bradipnea y bradicardia. En

el servicio de emergencias se sospecha intoxicación aguda. ¿Cuál sería el medicamento vía EV más adecuado?

- A. Naloxona
- B. Flumazenilo
- C. Atropina
- D. Fisostigmina

CLAVE: A

La triada de intoxicación opioide está toda presente: depresión del estado de conciencia (inconsciencia), miosis puntiforme (pupilas en cabeza de alfiler) y bradipnea con bradicardia, en una paciente con cáncer avanzado en tratamiento del dolor con opioides. El antídoto específico es naloxona endovenosa, antagonista competitivo de los receptores μ opioides, en bolos de 0.04 a 0.4 mg endovenoso, titulables según respuesta clínica. En pacientes con dolor crónico oncológico se usan dosis bajas iniciales para evitar reversión total con dolor agudo y síndrome de abstinencia. El efecto es rápido (1-2 minutos) pero corto, por lo que puede requerir infusión continua. El flumazenilo es antagonista de benzodiacepinas y se usa en intoxicación por benzodiacepinas, no por opioides; su uso en pacientes con uso crónico puede precipitar convulsiones. La atropina se usa en intoxicación por organofosforados y carbamatos (síndrome colinérgico con miosis pero también sialorrea, broncoespasmo, bradicardia y diarrea). La fisostigmina revierte el síndrome anticolinérgico (intoxicación por antihistamínicos, atropina, antidepresivos tricíclicos), no es indicada en intoxicación por opioides. Naloxona es el antídoto correcto.

PREGUNTA 167

En un centro de salud I-4 se implementa un procedimiento mediante el cual, antes de dispensar los medicamentos, el personal de enfermería realiza un doble chequeo de las prescripciones médicas, y el personal informático genera alertas automáticas ante posibles interacciones medicamentosas o errores de dosis. Esta intervención se clasifica principalmente como una estrategia de:

- A. Enfoque centrado exclusivamente en la responsabilidad individual
- B. Conducta reactiva ante eventos adversos ya ocurridos
- C. Búsqueda punitiva de culpables por errores de medicación
- D. Actitud proactiva en seguridad clínica

CLAVE: D

La intervención descrita corresponde a una actitud proactiva en seguridad clínica, paradigma moderno de gestión de la seguridad del paciente que se centra en prevenir errores antes de que ocurran mediante el rediseño de procesos, la implementación de barreras múltiples (doble chequeo) y el uso de tecnología (alertas automáticas en sistemas informáticos). Este enfoque sigue los principios de la teoría del queso suizo de Reason, donde múltiples capas de seguridad reducen la probabilidad de que un error individual atraviese todo el sistema y llegue al paciente. El enfoque centrado exclusivamente en la responsabilidad individual es el modelo antiguo o de la culpa, que atribuye los errores únicamente a los profesionales sin considerar fallas del sistema; ha sido superado por la cultura de seguridad sistémica. La conducta reactiva ante eventos adversos ya ocurridos describe lo que se hace después de que el daño ha sucedido (análisis causa-raíz, aprendizaje del error), no lo que evita que ocurran. La búsqueda punitiva de culpables es contraproducente porque desincentiva el reporte de errores y oculta riesgos. Doble chequeo + alertas automáticas = actitud proactiva en seguridad clínica.

PREGUNTA 168

Niño de 6 años, desde hace 7 días presenta anorexia, malestar general y dolor abdominal difuso. Examen: FC 84 x', FR 24 x', PA en percentil 50 para la edad y sexo. Presenta edema en miembros inferiores y genitales con fóvea, murmullo vesicular disminuido en bases pulmonares, y abdomen con matidez desplazable. Laboratorio: hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, proteinuria 3+ en tira reactiva, sin hematuria. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Síndrome nefrítico agudo
- B. Glomerulonefritis aguda post estreptocócica
- C. Síndrome nefrótico
- D. Proteinuria ortostática

CLAVE: C

Lo de siempre, como vimos en clase: síndrome nefrótico, definido por la triada de proteinuria masiva, hipoalbuminemia e hipercolesterolemia, acompañado de edema. En este niño están todos los criterios: proteinuria 3+ en tira reactiva (rango nefrótico), hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, edema en miembros inferiores y genitales, ascitis (matidez desplazable abdominal) y derrame pleural (murmulo vesicular disminuido en bases). La presión arterial normal y la ausencia de hematuria orientan a la forma idiopática, que en niños corresponde en el 90% a enfermedad por cambios mínimos,

sensible a corticoides como tratamiento de primera línea. El síndrome nefrítico agudo cursa con hematuria macroscópica con cilindros hemáticos, hipertensión arterial, oliguria y edema, no con proteinuria masiva ni hipoalbuminemia profunda. La glomerulonefritis aguda postestreptocócica es la causa más común de síndrome nefrítico en niños, no de síndrome nefrótico. La proteinuria ortostática es benigna, presente solo en bipedestación, sin edema, hipoalbuminemia ni hipercolesterolemia, y se descarta con muestras de orina en distintas posiciones. Edema + proteinuria 3+ + hipoalbuminemia + hipercolesterolemia = síndrome nefrótico.

PREGUNTA 169

En una comunidad rural de la sierra peruana con alta prevalencia de pobreza extrema, la dieta habitual se basa casi exclusivamente en maíz y carbohidratos refinados, con escaso consumo de proteínas de origen animal. Un varón de 45 años acude al centro de salud por diarrea crónica, pérdida de peso, irritabilidad y dificultad para concentrarse. Examen: lesiones eritematoescamosas simétricas en dorso de manos y cara, que empeoran con la exposición solar. Considerando la información clínica y el contexto de salud pública descrito, ¿la deficiencia de cuál de las siguientes vitaminas explica mejor este cuadro?

- A. Vitamina B3 (niacina)
- B. Vitamina B9 (ácido fólico)
- C. Vitamina B1 (tiamina)
- D. Vitamina C (ácido ascórbico)

CLAVE: A

Aquí lo decisivo es pelagra clásica, enfermedad por deficiencia crónica de niacina (vitamina B3) y de su precursor el triptófano, característica de poblaciones cuya dieta se basa exclusivamente en maíz no nixtamalizado, donde la niacina está unida a carbohidratos en forma no biodisponible. La triada clásica de pelagra son las tres D: dermatitis fotosensible (lesiones eritematoescamosas simétricas en zonas expuestas al sol como dorso de manos, cara y collar de Casal en cuello), diarrea crónica y demencia o alteraciones neuropsiquiátricas (irritabilidad, dificultad para concentrarse, en estadios avanzados delirio). La deficiencia de vitamina B9 (ácido fólico) produce anemia megaloblástica y, en gestantes, defectos del tubo neural; no genera la dermatitis fotosensible ni la triada de pelagra. La deficiencia de vitamina B1 (tiamina) produce beriberi (forma seca con polineuropatía o forma húmeda con insuficiencia cardíaca de alto gasto) y, en alcohólicos, encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, no la triada de

pelagra. La deficiencia de vitamina C produce escorbuto con sangrado gingival, hemorragias subperiósticas y mala cicatrización, no dermatitis fotosensible con diarrea y demencia. Pelagra (3 D) = deficiencia de niacina.

PREGUNTA 170

Escolar de 8 años acude a control de niño sano. ¿Cuál es la recomendación dietética más importante respecto a las bebidas?

- A. Ofrecer jugos de frutas naturales en lugar de gaseosas durante el día
- B. Cambiar las bebidas actuales por leche entera en las principales comidas
- C. Evitar las bebidas azucaradas y promover el consumo habitual de agua simple
- D. Reemplazar las gaseosas por bebidas bajas en calorías

CLAVE: C

La recomendación dietética con mayor evidencia y mayor impacto poblacional para escolares es evitar el consumo de bebidas azucaradas (gaseosas, jugos comerciales, néctares envasados, bebidas energéticas) y promover el consumo habitual de agua simple como bebida principal. El consumo elevado de bebidas azucaradas es el principal factor dietético modificable asociado a obesidad infantil, caries dental y riesgo cardiometabólico futuro. Esta recomendación es respaldada por la OMS, la Academia Americana de Pediatría y las guías peruanas de alimentación saludable. Ofrecer jugos de frutas naturales en lugar de gaseosas mejora algunos micronutrientes pero conserva alta carga de azúcar libre y calorías; las guías recomiendan limitar también los jugos naturales a 120-180 mL/día en preescolares y escolares. Cambiar bebidas por leche entera es razonable en la dieta diaria pero no resuelve el problema central de bebidas azucaradas, y el consumo excesivo de leche en escolares puede desplazar otros alimentos. Reemplazar gaseosas por bebidas bajas en calorías sustituye azúcar por edulcorantes pero no fomenta hábitos saludables sostenibles. Agua simple es la mejor bebida.

PREGUNTA 171

Adolescente de 17 años consulta por sangrado persistente del alvéolo dentario 7 días después de una extracción de molares, se controla solo con presión local. Refiere menorragia desde la menarquia. La madre comenta que varios familiares maternos (mujeres y varones) han tenido "sangrados excesivos" tras procedimientos menores. Examen: palidez leve, sin equimosis extensas ni hepatoesplenomegalia. Lab: Hb 11 g/dL,

VCM 78 fL, plaquetas $400 \times 10^9/L$, TP 12 s (INR 1, 0), TTPa 30 s. Función renal y hepática normales. ¿Cuál es la siguiente prueba diagnóstica más adecuada?

- A. Dosaje de factor VII
- B. Actividad del cofactor de ristocetina
- C. Dosaje de factor IX
- D. Búsqueda de inhibidor del factor VIII

CLAVE: B

Lo primero a identificar es altamente sugerente de enfermedad de Von Willebrand (EvW), la coagulopatía hereditaria más frecuente, autosómica dominante (afecta a hombres y mujeres por igual). Las pistas son: sangrado mucocutáneo persistente postextracción dentaria, menorragia desde la menarquia, antecedente familiar bilineal (mujeres y varones), TTPa normal o levemente prolongado y conteo de plaquetas normal. La prueba diagnóstica clave es la actividad del cofactor de ristocetina (también llamada cofactor ristocetínico o test de actividad funcional del FvW), que mide la función adhesiva del factor de Von Willebrand mediada por la GP Ib plaquetaria, en paralelo con dosaje del antígeno y del factor VIII. El dosaje de factor VII evalúa la vía extrínseca (TP/INR) y se utiliza cuando hay TP prolongado, lo cual no aplica aquí (TP 12 s, INR 1.0 normales). El dosaje de factor IX se solicita en sospecha de hemofilia B, enfermedad ligada al X que afecta principalmente a varones y suele cursar con TTPa marcadamente prolongado, no con sangrado mucocutáneo en mujer con TTPa solo levemente alto. La búsqueda de inhibidor del factor VIII se realiza en sospecha de hemofilia A adquirida o en hemofílicos politransfundidos, no en este perfil hereditario familiar. Cofactor de ristocetina es la prueba específica para EvW.

PREGUNTA 172

Mujer de 50 años, con antecedente de laparotomía mediana hace 2 años, refiere 18 horas de dolor abdominal intenso y constante, asociado a vómitos y ausencia de eliminación de gases y heces. En la última hora el dolor se ha intensificado. Examen: abdomen distendido, doloroso a la palpación, sobre la cicatriz mediana se palpa una masa tensa, muy dolorosa e irreductible, con enrojecimiento de la piel suprayacente. Ruidos hidroaéreos abolidos. ¿Cuál es la decisión más adecuada para reducir el riesgo de necrosis intestinal y sepsis en esta paciente?

- A. Estabilizar hemodinámicamente, laparotomía exploradora de urgencia
- B. Programar para posible manejo laparoscópico electivo
- C. Antibióticos de amplio espectro, manejo con sonda nasogástrica

D. Radiografía simple de abdomen de pie

CLAVE: A

En clase lo dijimos claro: hernia incisional estrangulada con obstrucción intestinal: paciente con antecedente de laparotomía media, masa tensa irreductible muy dolorosa con eritema cutáneo (signo de compromiso vascular del contenido), obstrucción intestinal completa (sin gases ni heces, vómitos, ruidos abolidos) y dolor agudo intensificado. La conducta correcta es estabilizar hemodinámicamente con cristaloides, descompresión gástrica con sonda nasogástrica, antibioticoterapia de amplio espectro endovenosa y laparotomía exploradora de urgencia para reducir la hernia, evaluar viabilidad intestinal y reparar el defecto. Programar manejo laparoscópico electivo es peligroso porque cada hora de demora aumenta el riesgo de necrosis intestinal y peritonitis; la urgencia es ahora, no electiva. Ojo: antibióticos con sonda nasogástrica como manejo único, sin cirugía, es manejo de obstrucción adinámica simple, no de hernia estrangulada con compromiso vascular evidente. La radiografía de abdomen de pie puede confirmar niveles hidroaéreos pero no cambia la conducta quirúrgica urgente y solo retrasa la cirugía. Estabilizar y operar urgentemente no te enredas con lo demás.

PREGUNTA 173

Mujer de 21 años, previamente sana, presenta desde hace 8 meses disnea progresiva y cansancio. Examen: palidez generalizada de piel y mucosas; signos vitales estables, sin visceromegalia. Laboratorio: Hb 7 g/dL, leucocitos 5, 000/mm³, plaquetas 239, 000/mm³, reticulocitos 5%, bilirrubina total 5 mg/dL (directa 0, 5 mg/dL), prueba de Coombs directo positiva. No usa medicamentos y no refiere transfusiones previas. Se sospecha anemia hemolítica autoinmune. ¿Cuál es el tratamiento inicial más apropiado?

- A. Plasmaferesis
- B. Metilprednisolona EV
- C. Inmunoglobulina EV
- D. Rituximab EV

CLAVE: B

La anemia hemolítica autoinmune (AHAI) por anticuerpos calientes (Coombs directo positivo) en una paciente sin medicamentos ni transfusiones previas es la presentación clásica idiopática. Los datos clave son anemia normocítica con hiperbilirrubinemia indirecta y reticulocitosis, sin visceromegalia. El tratamiento inicial de elección son los corticoides a dosis altas: metilprednisolona endovenosa o prednisona oral 1-2

mg/kg/día, que reducen la hemólisis al modular la respuesta inmune contra los eritrocitos. La respuesta clínica suele observarse en 1-3 semanas, con descenso gradual posterior según evolución. La plasmaféresis no es de primera línea en AHAI por anticuerpos calientes; tiene rol en algunas formas por crioaglutininas o en casos refractarios catastróficos, pero no como tratamiento inicial. La inmunoglobulina endovenosa puede usarse como adyuvante o cuando los corticoides están contraindicados, pero no es el tratamiento inicial estándar. El rituximab (anti-CD20) es excelente terapia de segunda línea en AHAI refractaria a corticoides o como terapia de mantenimiento en recaídas, pero no es la primera elección de inducción. Corticoides son el pilar inicial de la AHAI por anticuerpos calientes.

PREGUNTA 174

Varón de 58 años con cirrosis hepática alcohólica, consulta por dolor abdominal difuso y fiebre de 38, 5 °C. Examen: PA 95/60 mmHg, FC 104 x', ascitis moderada, leve asterixis. Laboratorio: creatinina 1, 7 mg/dL (previa 0, 9 mg/dL), bilirrubina total 4, 2 mg/dL, INR 1, 8. Líquido ascítico: 720 polimorfonucleares/mm³ y cultivo preliminar muestra bacilos Gram negativos. ¿Cuál es la terapia recomendada?

- A. Amikacina EV y albúmina según creatinina
- B. Ciprofloxacina EV y cristaloides en bolo
- C. Cefotaxima EV y albúmina EV
- D. Metronidazol EV y evitar aporte de proteínas

CLAVE: C

Como insistimos en clase Villamedic, peritonitis bacteriana espontánea (PBE) en cirrótico con ascitis: fiebre, dolor abdominal, deterioro de función renal (creatinina de 0.9 a 1.7), ascitis con polimorfonucleares mayores de 250/mm³ (en este caso 720) y cultivo con bacilos gramnegativos (típicamente *E. coli* o *K. pneumoniae*). El tratamiento de elección es cefotaxima endovenosa 2 g cada 8 h por 5-7 días, asociada a expansión con albúmina endovenosa al 20% (1.5 g/kg el día 1 y 1 g/kg el día 3), que reduce significativamente el riesgo de síndrome hepatorenal y la mortalidad asociada a la PBE. La amikacina endovenosa con albúmina no es elección porque los aminoglucósidos son nefrotóxicos y el paciente ya tiene deterioro renal incipiente; cefotaxima tiene mejor perfil. La ciprofloxacina endovenosa con cristaloides en bolo no aporta el efecto protector renal específico de la albúmina, que es estándar en PBE; y además los cristaloides solos no replican el efecto oncótico necesario. El metronidazol endovenoso evitando proteínas es manejo errado: el metronidazol cubre solo anaerobios y no enterobacterias, y

restringir proteínas en cirrótico empeora la masa muscular y la encefalopatía. Cefotaxima + albúmina es el estándar.

PREGUNTA 175

Niño de 2 años de 12 kg, ingiere accidentalmente una tableta de paracetamol de 500 mg hace 1 hora. Es llevado a Emergencia, se confirma que la ingestión fue única y sin síntomas. Se confirma que no ha recibido otros medicamentos. ¿Cuál es la conducta más adecuada en este momento?

- A. Tranquilizar a los padres y dar de alta
- B. Administrar carbón activado
- C. Iniciar N-acetilcisteína de inmediato
- D. Iniciar infusión de bicarbonato

CLAVE: A

La dosis tóxica de paracetamol en niños se considera mayor o igual a 200 mg/kg en una ingestión única (umbral pediátrico actualizado AAP/AAPCC), o 10 g totales en mayores. Para este niño de 12 kg, la dosis tóxica sería mayor o igual a 2,400 mg. La ingestión de una tableta de 500 mg corresponde a $500/12 =$ aproximadamente 41 mg/kg, por debajo del umbral tóxico. En esta situación, la conducta correcta es tranquilizar a los padres, brindar consejería sobre prevención de accidentes y mantenimiento seguro de medicamentos, y dar de alta con observación domiciliaria, sin necesidad de antídoto ni decontaminación. Administrar carbón activado podría considerarse en ingestiones tóxicas dentro de las primeras 1-2 horas, pero en una ingestión subtóxica como esta no aporta beneficio y expone al niño a aspiración u otros riesgos del procedimiento. Ojo: iniciar N-acetilcisteína de inmediato sin determinar nivel sérico de paracetamol y sin ingestión tóxica es injustificado y excesivo; el antídoto se reserva para niveles tóxicos confirmados según nomograma de Rumack-Matthew. Iniciar infusión de bicarbonato no aplica al paracetamol; se usa en intoxicación por antidepresivos tricíclicos. Tranquilizar y dar de alta es lo que toca.

PREGUNTA 176

Mujer de 25 años consulta por pérdida de peso, palpitaciones, intolerancia al calor y nerviosismo de 3 meses de evolución. Examen: FC 110 x', temblor fino distal, bocio difuso blando y exoftalmos bilateral. ¿Cuál es el examen más apropiado para confirmar el diagnóstico?

- A. Anticuerpos estimulantes del receptor de TSH (TRAb)

- B. TSH ultrasensible y T4 libre sérica
- C. Gammagrafía tiroidea con yodo radiactivo
- D. Ecografía tiroidea con Doppler color

CLAVE: A

Aquí lo decisivo es hipertiroidismo por enfermedad de Graves: clínica clásica de tirotoxicosis (pérdida de peso, palpitaciones, intolerancia al calor, nerviosismo, taquicardia, temblor fino), bocio difuso (no nodular), y oftalmopatía con exoftalmos bilateral, que es el sello distintivo de Graves entre las causas de hipertiroidismo. La confirmación diagnóstica específica de Graves se realiza con anticuerpos estimulantes del receptor de TSH (TRAb), que están presentes en más del 95% de los pacientes con Graves no tratado y son los responsables fisiopatológicos directos de la hiperestimulación tiroidea y de la oftalmopatía. La TSH ultrasensible y T4 libre confirman el estado de tirotoxicosis (TSH suprimida, T4 libre elevada) pero no diferencian Graves de otras causas como bocio multinodular tóxico o tiroiditis; son el primer paso pero no la confirmación etiológica. La gammagrafía tiroidea con yodo radiactivo es útil para diferenciar etiologías cuando el TRAb es negativo o ambiguo (Graves muestra captación difusa y aumentada), pero si la clínica con bocio difuso y exoftalmos ya orienta fuertemente a Graves, el TRAb es más específico y costo-efectivo. La ecografía tiroidea con Doppler complementa pero no confirma etiología. TRAb es la prueba de elección para confirmar Graves.

PREGUNTA 177

Recién nacido de 3 semanas, producto de embarazo sin controles regulares, acude por ictericia que persiste desde el nacimiento, dificultad para alimentarse y escasa ganancia de peso. Examen: fontanelas amplias, hernia umbilical, macroglosia, hipotonía generalizada y piel seca. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

- A. Propiltiouracilo
- B. Metimazol
- C. Propanolol
- D. Levotiroxina

CLAVE: D

La pista clave aquí es hipotiroidismo congénito: ictericia prolongada más allá de las 2 semanas, dificultad para alimentarse, retraso ponderal, fontanelas amplias persistentes, hernia umbilical, macroglosia, hipotonía y piel seca. Esta es una emergencia diagnóstica y terapéutica porque el inicio temprano de levotiroxina (vía oral, dosis inicial de 10-15

$\mu\text{g/kg/día}$) en las primeras 2-4 semanas de vida es crucial para preservar el desarrollo cognitivo normal. El tamizaje neonatal con TSH al nacer detecta la mayoría de casos antes de que aparezca clínica, pero en gestantes sin controles puede llegarse al diagnóstico tardíamente con clínica florida. El propiltiouracilo y el metimazol son antitiroideos utilizados para hipertiroidismo (Graves, BMNT), no para hipotiroidismo, donde su uso sería contraproducente porque inhibe aún más la síntesis hormonal. El propranolol es betabloqueador usado para controlar manifestaciones simpáticas del hipertiroidismo (taquicardia, temblor); tampoco aplica al hipotiroidismo. La levotiroxina por vía oral es la hormona de reemplazo y la única terapia válida; el inicio precoz preserva el desarrollo cognitivo y revierte rápidamente las manifestaciones somáticas del cretinismo congénito.

PREGUNTA 178

Recién nacido a término, de 10 horas de vida, con ausencia de eliminación de meconio. Examen: ausencia de abertura anal en la posición habitual, sin malformaciones externas evidentes. ¿Cuál es el siguiente paso en el abordaje inicial para un manejo integral de este recién nacido?

- A. Sonda orogástrica en derivación
- B. Anorrectoplastia posterior sagital inmediata
- C. Alimentación enteral con fórmula hidrolizada de alta digestibilidad
- D. Estudios de imagen para descartar malformaciones asociadas

CLAVE: D

En todo recién nacido con atresia anorrectal (malformación anorrectal), el siguiente paso en el abordaje inicial es solicitar estudios de imagen para descartar malformaciones asociadas, ya que esta entidad forma parte del complejo VACTERL en aproximadamente 30-50% de los casos. Las malformaciones asociadas a buscar son: vertebrales (radiografía de columna), cardíacas (ecocardiografía), traqueoesofágicas (radiografía con sonda nasogástrica), renales (ecografía renal y de vías urinarias) y de extremidades. El conocimiento del espectro completo de anomalías guía el manejo quirúrgico definitivo y el pronóstico. La sonda orogástrica en derivación se utiliza para descomprimir el estómago y manejar la obstrucción intestinal funcional, parte del soporte inicial pero no es el siguiente paso integral del abordaje. La anorrectoplastia posterior sagital inmediata no se realiza en las primeras horas; la cirugía definitiva se planifica según el tipo de malformación (alta, intermedia o baja) y suele requerir colostomía protectora previa en defectos altos, con reconstrucción posterior en meses.

La alimentación enteral con fórmula hidrolizada está formalmente contraindicada antes de resolver la obstrucción intestinal. Estudios de imagen para descartar VACTERL marca esto.

PREGUNTA 179

En una comunidad indígena quechua del Cusco se ha identificado alta prevalencia de anemia en mujeres embarazadas (48%) y niños menores de 5 años (44%), asociada a baja ingesta de hierro y barreras culturales para acudir a los servicios de salud (desconfianza hacia la medicina occidental, dificultades de transporte y escaso uso del español). Considerando los principios de promoción de la salud y el enfoque intercultural. ¿Cuál es la estrategia más efectiva para reducir la prevalencia de anemia en esta comunidad?

- A. Implementar campañas de educación sanitaria en la comunidad mediante folletos impresos en español
- B. Distribuir suplementos de hierro y ácido fólico a todas las mujeres embarazadas y niños menores de 5 años
- C. Capacitar a líderes comunitarios (autoridades locales y agentes de medicina tradicional) como promotores de salud
- D. Iniciar un programa intensivo de vacunación en la comunidad para prevenir enfermedades infecciosas

CLAVE: C

En contextos con alta prevalencia de problemas de salud y barreras culturales y lingüísticas como una comunidad indígena quechua, la estrategia más efectiva basada en los principios de promoción de la salud y el enfoque intercultural es capacitar a líderes comunitarios (autoridades locales y agentes de medicina tradicional) como promotores de salud. Esta estrategia construye puentes culturales, aprovecha la legitimidad y confianza preexistente de los líderes en su comunidad, respeta la cosmovisión indígena y permite que los mensajes sanitarios circulen de manera horizontal y en quechua, lo que aumenta la aceptación y la efectividad real de las intervenciones. Las campañas educativas con folletos impresos en español son inadecuadas en una comunidad con escaso uso del español, generan alfabetización funcional limitada y no construyen confianza con la medicina occidental rechazada por barreras culturales. Distribuir suplementos sin acompañamiento cultural es la solución técnica clásica, pero su efectividad disminuye drásticamente cuando hay barreras de adherencia y aceptación cultural; la suplementación es necesaria pero insuficiente

como única medida. Iniciar un programa de vacunación no aborda la anemia, que es problema nutricional. Capacitar a líderes comunitarios articula la estrategia con el enfoque intercultural correcto.

PREGUNTA 180

Mujer de 45 años es atendida porque hace 30 minutos sufre quemadura con líquidos calientes. Examen: PA 120/70 mmHg, FC: 95 x'. Lesiones extensas con ampollas alrededor de ambas caras del antebrazo derecho. Luego de 5 días, presenta parestesias y dolor de los dedos de la mano derecha. Examen: mano fría, palidez distal y llenado capilar enlentecido, pulso radial disminuido. ¿Qué indicación inmediata es la más pertinente?

- A. Fasciotomía a las 24 horas
- B. Opioides endovenosos y antibióticos
- C. Antibióticos amplio espectro con curaciones
- D. Programar para escarotomía

CLAVE: D

En quemaduras circunferenciales de espesor parcial profundo o total que rodean una extremidad, la formación de una escara rígida puede generar síndrome compartimental por compresión vasculonerviosa progresiva, manifestándose con la triada característica: dolor desproporcionado, parestesias, palidez distal con frialdad y disminución del pulso. La conducta correcta es la escarotomía urgente, incisión longitudinal en la escara hasta el tejido subcutáneo a lo largo de la extremidad para liberar la presión y restaurar la perfusión distal. Este procedimiento puede realizarse en cama o en sala según la disponibilidad, sin demora. La fasciotomía a las 24 horas (que se realiza profundizando hasta la fascia muscular) está indicada en síndrome compartimental establecido con presiones intracompartimentales elevadas, generalmente cuando la escarotomía sola no resuelve la perfusión; pero el primer paso ante quemadura circunferencial con compromiso isquémico es escarotomía. Los opioides endovenosos y antibióticos manejan dolor e infección pero no resuelven la causa mecánica del compromiso vascular y, por sí solos, no salvan la extremidad. Los antibióticos de amplio espectro con curaciones tampoco resuelven la causa mecánica isquémica. Escarotomía quédate con eso y debe ser inmediata.